

dr. Hesti Herlinawati

12 Oktober 2026

[16.45, 12/10/2026]
Assalamu'alaikum, saat ini dr Hesti praktik di Madani ya. Saya minta tolong untuk menganalisa tentang faktor apa yang membuat angka rujukan ke RS di Madani jauh lebih tinggi dg angka rujukan di KMSC? Terima kasih 🙏🙏

[16.45, 12/10/2026]
Iya pelajari dulu ya krn tdk urgent, hanya ingin evaluasi untuk perbaikan ke depannya🙏🙏

A. Jenis Rujukan

Angka rujukan tinggi memang butuh evaluasi, tetapi tidak semua rujukan sama. Setidaknya rujukan harus dibagi menjadi 2 (dua) jenis, rujukan baru dan rujukan berulang. Karena dasar masalah dan cara penyelesaiannya berbeda.

1. Rujukan Baru

Definisi :

Rujukan yang dibuat untuk pasien yang belum pernah dirujuk sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama, atau sudah pernah tetapi episode penyakitnya sudah selesai dan sekarang muncul episode baru.

Kriteria :

- Tidak ada riwayat rujukan sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama.
- Atau ada riwayat, tetapi sudah lewat masa episode.
- Diagnosis bisa sama, tapi ini episode baru.

Contoh :

Pasien pernah dirujuk karena demam berdarah 1 tahun lalu, sekarang dirujuk lagi karena demam berdarah. Itu rujukan baru karena episode baru.

Dasar Masalah :

- Keterbatasan fasilitas klinik: alat, lab, radiologi, atau obat yang dibutuhkan tidak tersedia.
- Keterbatasan kompetensi: butuh dokter spesialis atau subspesialis yang tidak ada di klinik.
- Tingkat keparahan pasien: kondisi akut, gawat, atau butuh observasi/rawat inap.
- Diagnosis yang belum pasti: butuh pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis.
- Case mix pasien: klinik menerima lebih banyak pasien dengan penyakit kompleks.
- Kebijakan rujukan berjenjang: aturan asuransi mewajibkan rujukan untuk kasus tertentu.

Cara Penyelesaian :

- Perkuat fasilitas klinik: tambah lab, radiologi, USG, EKG, obat yang sering dibutuhkan.
- Perbaiki SOP rujukan: buat kriteria rujukan yang jelas.
- Tingkatkan kemampuan diagnostik: pelatihan dokter umum untuk kasus tak perlu rujuk.
- Analisis case mix: kalau rujukan baru tinggi karena pasien memang lebih berat, itu wajar. Fokusnya bukan menurunkan angka, tapi memastikan rujukan tepat.
- Audit rujukan: review sampel rujukan baru untuk melihat apakah ada yang seharusnya bisa ditangani di klinik.



dr. Hesti Herlinawati

2. Rujukan Berulang

Definisi :

Rujukan yang dibuat untuk pasien yang sudah pernah dirujuk sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama, dan masih dalam rangkaian masalah kesehatan yang sama.

Kriteria :

- Ada riwayat rujukan sebelumnya untuk diagnosis/kondisi yang sama.
- Masih dalam episode yang sama.

Contoh :

- Kontrol rutin
- Perpanjangan surat rujukan
- Rujukan ulang karena habis masa berlaku
- Perburukan kondisi yang sama

Dasar Masalah :

- Masa berlaku surat rujukan habis: aturan BPJS membatasi masa berlaku rujukan, sehingga pasien harus minta perpanjangan.
- Penyakit kronis yang butuh kontrol rutin: hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, dll. Pasien Prolanis/PRB.
- Follow-up yang tidak berjalan: pasien tidak kontrol teratur, sehingga kondisinya memburuk dan harus dirujuk lagi.
- Obat tidak tersedia di klinik: pasien harus ke RS untuk mendapat obat tertentu.
- Komunikasi dengan RS kurang: tidak ada rujukan balik, sehingga pasien kembali ke klinik dan dirujuk lagi.
- Edukasi pasien kurang: pasien tidak paham cara kontrol, minum obat, atau kapan harus kembali.
- Permintaan pasien/keluarga: pasien ingin tetap kontrol ke spesialis/RS yang sama.
- Kondisi memburuk: penyakit yang sama mengalami perburukan, sehingga butuh penanganan lanjutan.
- SOP perpanjangan rujukan tidak jelas: perpanjangan dilakukan tanpa evaluasi klinis yang memadai.

Cara Penyelesaian :

- Perjelas SOP perpanjangan rujukan: tentukan kriteria kapan rujukan boleh diperpanjang, kapan harus dievaluasi ulang.
- Optimalkan Prolanis/PRB: pastikan pasien kronis kontrol teratur di klinik, bukan hanya minta perpanjangan rujukan.
- Sediakan obat kronis: pastikan obat untuk penyakit kronis tersedia di klinik, sehingga pasien tidak perlu ke RS hanya untuk obat.
- Perbaiki komunikasi dengan RS: minta rujukan balik, koordinasi dengan spesialis, buat jalur komunikasi yang jelas.
- Edukasi pasien: beri pemahaman tentang penyakit, obat, kontrol, dan kapan harus ke RS.
- Audit perpanjangan rujukan: review apakah perpanjangan dilakukan tanpa evaluasi klinis.
- Manajemen kasus kronis: buat program follow-up untuk pasien kronis, misalnya reminder kontrol, konsultasi jarak jauh, atau kunjungan rumah.
- Evaluasi ketersediaan obat dan alat: pastikan apa yang dibutuhkan pasien kronis tersedia di klinik.



dr. Hesti Herlinawati

B. Metodologi

Untuk menjawab permintaan tentang faktor apa yang membuat angka rujukan ke RS di Madani jauh lebih tinggi dari angka rujukan di KMSC, maka perlunya perencanaan dan data yang akurat.

Perencanaan :

1. Data akan di ambil dari Rekam Medis Elektronik MyKlinik
2. Data yang diambil direntang yang sama yaitu 3 bulan, sesuai masa rujukan BPJS
3. Data diambil pada 1 Juli 2026 – 30 September 2026
4. Data yang diambil akan di bagi menjadi 2 list, List A dan List B
5. List A untuk hitung case mix dan denominator.
6. List B untuk klasifikasi jenis rujukan dan analisis alasan.
7. Hitung Case Mix dan Hitung Rate rujukan (umum dan perdiagnosis)
8. Bandingkan Madani vs KMSC
9. Kesimpulan dan Kemungkinan Faktor lain

C. Colecting Data Klinik Cahaya Madani

Data yang harus dikoleksi selama 3 (tiga bulan di myklinik sangat banyak > 6000 pasien. Dengan tenaga seadanya (saya sendiri), tanpa ada dana untuk hire orang lain dan kurang formalnya tugas yang diberikan, sehingga banyak informasi yang terhalang credential seperti jumlah kapitasi klinik, merupakan hambatan yang harus saya lalui

Menampilkan 1 s/d 10 dari 6,191 data

Koleksi data sebanayak itu saya tidak mampu, maka saya menggunakan alat bantu script python, saya lakukan otomatisasi colecting data dari myklinik. Waktu yang diperlukan untuk membuat program sekitar 6 jam, dengan kecepatan colecting data 20 detik/pasien, yang akhirnya selesai setelath 36 jam colecting data.

myklinik.log

```
[2026-10-12 22:26:20] [INFO] [INIT] === Script dimulai (MODE=FULL) ===
[2026-10-12 22:26:20] [INFO] [INIT] Rentang: 01-07-2026 s/d 01-07-2026
[2026-10-12 22:26:28] [INFO] [LOGIN] Kredensial terisi
[2026-10-12 22:26:29] [INFO] [LOGIN] Captcha: T7KQer
[2026-10-12 22:26:32] [INFO] [LOGIN] Tombol Login diklik
[2026-10-12 22:26:41] [INFO] [NAVIGASI] Menu 'Klinik R.Jalan' diklik
[2026-10-12 22:26:44] [INFO] [NAVIGASI] Menu 'SOAP & Diagnosa' diklik
[2026-10-12 22:26:46] [INFO] [NAVIGASI] Halaman SOAP ter-load
[2026-10-12 22:26:46] [INFO] [INIT] Mulai dari 01-07-2026, index pasien 5
[2026-10-12 22:26:46] [INFO] [HARI] ========== Mulai 01-07-2026 ==========
[2026-10-12 22:26:46] [INFO] [FILTER] Set tanggal: 01-07-2026
[2026-10-12 22:26:50] [INFO] [DETEKSI0] ADA DATA: 80
[2026-10-12 22:26:50] [INFO] [HARI] 01-07-2026 total: 80 pasien
[2026-10-12 22:26:50] [INFO] [HARI] Resume dari index 5 (sudah ada 5 di file)
[2026-10-12 22:26:51] [INFO] [PASIEN] Klik baris #6: GHIFFARY JA FAR SIDIK IBNU YACUB (MR 011247)
[2026-10-12 22:26:58] [INFO] [DETAIL] Halaman detail siap
[2026-10-12 22:26:58] [INFO] [ICD] Menunggu ICD10...
[2026-10-12 22:26:59] [INFO] [ICD] ICD PRIMARY (checked): J06
[2026-10-12 22:26:59] [INFO] [SIMPAN] List A #6: GHIFFARY JA FAR SIDIK IBNU YACUB (MR 011247) → listA_01072026.txt
[2026-10-12 22:26:59] [INFO] [NAVIGASI] Tombol 'Back' diklik
[2026-10-12 22:27:03] [INFO] [FILTER] Set tanggal: 01-07-2026
[2026-10-12 22:27:06] [INFO] [PASIEN] Klik baris #7: NAURA ALIKA KHAIRUNNISA (MR 008228)
[2026-10-12 22:27:13] [INFO] [DETAIL] Halaman detail siap
[2026-10-12 22:27:13] [INFO] [ICD] Menunggu ICD10...
[2026-10-12 22:27:13] [INFO] [ICD] ICD PRIMARY (checked): R50
[2026-10-12 22:27:13] [INFO] [SIMPAN] List A #7: NAURA ALIKA KHAIRUNNISA (MR 008228) → listA_01072026.txt
[2026-10-12 22:27:14] [INFO] [NAVIGASI] Tombol 'Back' diklik
[2026-10-12 22:27:17] [INFO] [FILTER] Set tanggal: 01-07-2026
[2026-10-12 22:27:21] [INFO] [PASIEN] Klik baris #8: MUHAMMAD SYAHDAN DAUD (MR 003685)
[2026-10-12 22:27:28] [INFO] [DETAIL] Halaman detail siap
```



dr. Hesti Herlinawati

NO	SOAP	REGISTER	TANGGAL	JAM	MR	NAMA PASIEN	PRAKTEK	DOKTER	POLIKLINIK	KONTROL	# PCARE BPJS	ACTION
1	-	061302	12-08-2026	09:14:06	011080	NADZEERA SHAQUEENA NUGROHO	PAGI	Virza Funny Annisa,A.Md.Keb	POLI K B		0	SOAP & DX Riwayat Rekam Medis
2	-	062245	26-08-2026	19:32:02	011587	RIZQI AKBARI PERSADA	SORE MALAM	dr. Yuni Indriani Hadi	POLI UMUM		A62	SOAP & DX Riwayat Rekam Medis
3	-	061985	22-08-2026	16:24:27	004680	ARIEF AFIEF	SORE MALAM	drg Ollanda Irenawati, MARS	POLI GIGI			SOAP & DX Riwayat Rekam Medis

Dalam colecting data, data kriteria ekslusi yang saya terapkan, yaitu pasien yang soapnya belum terisi akan dikeluarkan dari eksklusi, sehingga dari 6.191 yang terdaftar data yang akan dianalisa sebanyak **6.169** kunjungan.

Contoh data primer yang dikoleksi

List A :


```
 {
   "tanggal_kunjungan": "01-07-2026",
   "no_rm": "003151",
   "nama": "KIRANI EUISHANA RESWARI",
   "usia": "8",
   "jenis_kelamin": "PEREMPUAN",
   "jaminan": "BPJS",
   "diagnosis_kode": "B01",
   "diagnosis_desc": "Varicella [chickenpox]",
   "dokter": "dr. Yuni Indriani Hadi",
   "poli": "POLI UMUM",
   "rujuk": "tidak"
 },
```


List B :


```
 {
   "tanggal_kunjungan": "01-07-2026",
   "no_rm": "006522",
   "nama": "NURAHMAN",
   "usia": "52",
   "jenis_kelamin": "LAKI-LAKI",
   "jaminan": "BPJS",
   "subjective": "pandangan kabur +",
   "keluhan": "rujukan utk periksa mata dan
pembelian kacamata",
   "diagnosis_kode": "H54",
   "diagnosis_desc": "Blindness and low vision
Note: For definition of visual impairment categories
see table opposite. Excludes: amaurosis fugax
(G45.3)",
   "plan": "rujuk poli mata",
   "rs_tujuan": "RS ALI SIBROH MALISI",
   "spesialis_tujuan": "Mata",
   "tanggal_rujukan": "02-07-2026",
   "dpjp": "dr. Yuni Indriani Hadi",
   "jenis_rujukan": ""
 },
```


Data mentah dari myklinik tersebut akan di transform menjadi data sekunder yang baru bisa dianalisa. Contoh usia dikategorikan menjadi balita, anak, dewasa, lansia. Selaiin itu jenis rujukan disi secara manual sebanyak **1.103** data. Karena itu mungkin akan terjadi bias atau kesalahan dalam pehaman disini. Jika dari keluhan dan planing jelas seperti “perpanjang rujukan”, maka saya akan mendatanya sebagai “Rujukan Berulang”. Jika bunyinya seperti “sudah berobta belum sembuh”, maka saya akan mendatanya sebagai “Rujukan Baru”.



dr. Hesti Herlinawati

{
"tanggal_kunjungan": "01-07-2026",
"no_rm": "003151",
"nama": "KIRANI EUISHANA RESWARI",
"usia": "8",
"jenis_kelamin": "PEREMPUAN",
"jaminan": "BPJS",
"diagnosis_kode": "B01",
"diagnosis_desc": "Varicella [chickenpox]",
"dokter": "dr. Yuni Indriani Hadi",
"poli": "POLI UMUM",
"rujuk": "tidak",
"kategori_usia": "Anak-anak / Usia Sekolah",
"status_penyakit": "Akut",
"sifat_penyakit": "Menular",
"nama_hari": "Rabu",
"bulan_tahun": "Juli 2026",
"kategori_jaminan": "BPJS"
},

{
"tanggal_kunjungan": "01-07-2026",
"no_rm": "006522",
"nama": "NURAHMAN",
"usia": "52",
"jenis_kelamin": "LAKI-LAKI",
"jaminan": "BPJS",
"subjective": "pandangan kabur +",
"keluhan": "rujukan utk periksa mata dan pembelian kacamata",
"diagnosis_kode": "H54",
"diagnosis_desc": "Blindness and low vision Note: For definition of visual impairment categories see table opposite. Excludes: amaurosis fugax (G45.3)",
"plan": "rujuk poli mata",
"rs_tujuan": "RS ALI SIBROH MALISI",
"spesialis_tujuan": "Mata",
"tanggal_rujukan": "02-07-2026",
"dpjp": "dr. Yuni Indriani Hadi",
"jenis_rujukan": "Rujukan Baru",
"kategori_usia": "Dewasa / Usia Produktif",
"nama_hari": "Rabu",
"bulan_tahun": "Juli 2026",
"kategori_jaminan": "BPJS"
},

Berikut data sekunder yang sudah ditransform dari data primer. Karena permintaan tidak spesifik mengatakan angka rujukan BPJS, maka saya akan menganalisa pasien semua pasien. Berhubung saya mendapat kendala dalam informasi jumlah kapitasi camad, maka saya akan menggunakan angka imajinasi 10.000 kapitasi, karena itu rumor yang saya dengar.

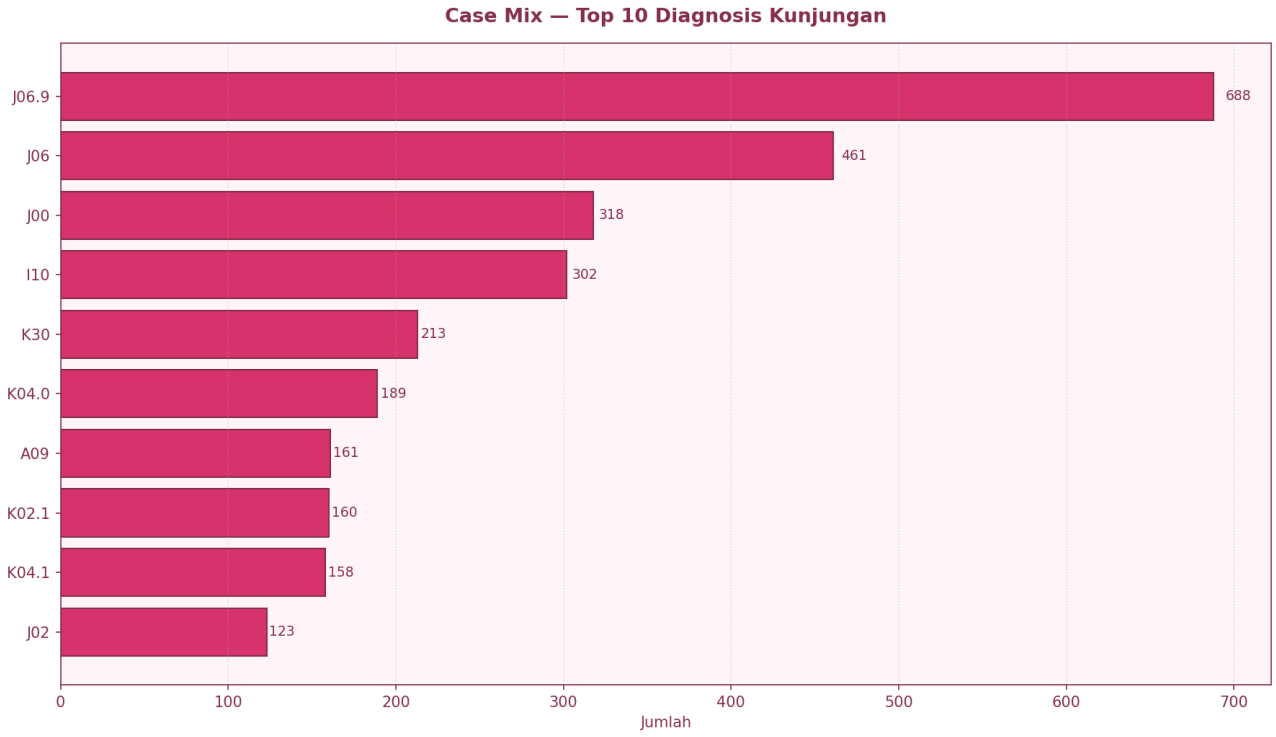


dr. Hesti Herlinawati

D. Analisa Data Klinik Cahaya Madani
D.1. Profil Kunjungan (Case Mix)

Kode	Diagnosa	Jumlah	%
J06.9	(ISPA akut)	688	11,15
J06	(ISPA atas)	461	7,47
J00	(Nasofaringitis akut)	318	5,15
I10	(Hipertensi esensial)	302	4,9
K30	(Dispepsia)	213	3,45
K04.0	(Pulpitis)	189	3,06
A09	(Diare)	161	2,61
K02.1	(Karies dentin)	160	2,59
K04.1	(Nekrosis pulpa)	158	2,56
J02	(Faringitis akut)	123	1,99
TOTAL		2773	44,95

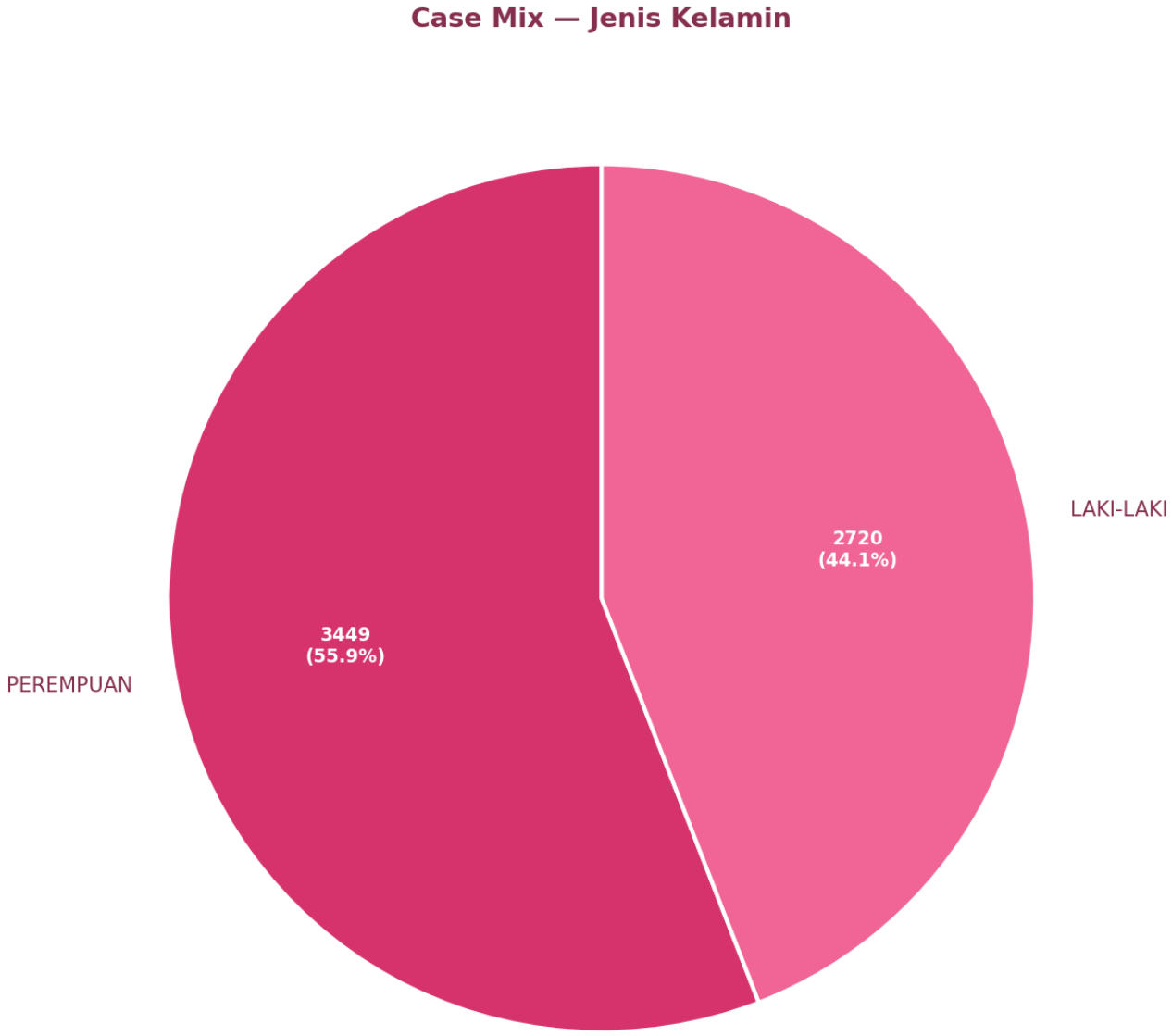
10 diagnosis terbanyak menyumbang 44,95% dari seluruh kunjungan (2.773 dari 6.169). Karakteristik: Didominasi penyakit akut menular (ISPA, diare) dan penyakit gigi. Hipertensi (I10) menjadi satu-satunya penyakit kronis di top 5.



Case mix FKTP ini sehat secara proporsional — didominasi penyakit akut ringan yang seharusnya ditangani primer. Proporsi kronis hanya 4,9% di top 10, yang mengindikasikan kronis berat sudah terfilter ke spesialis.



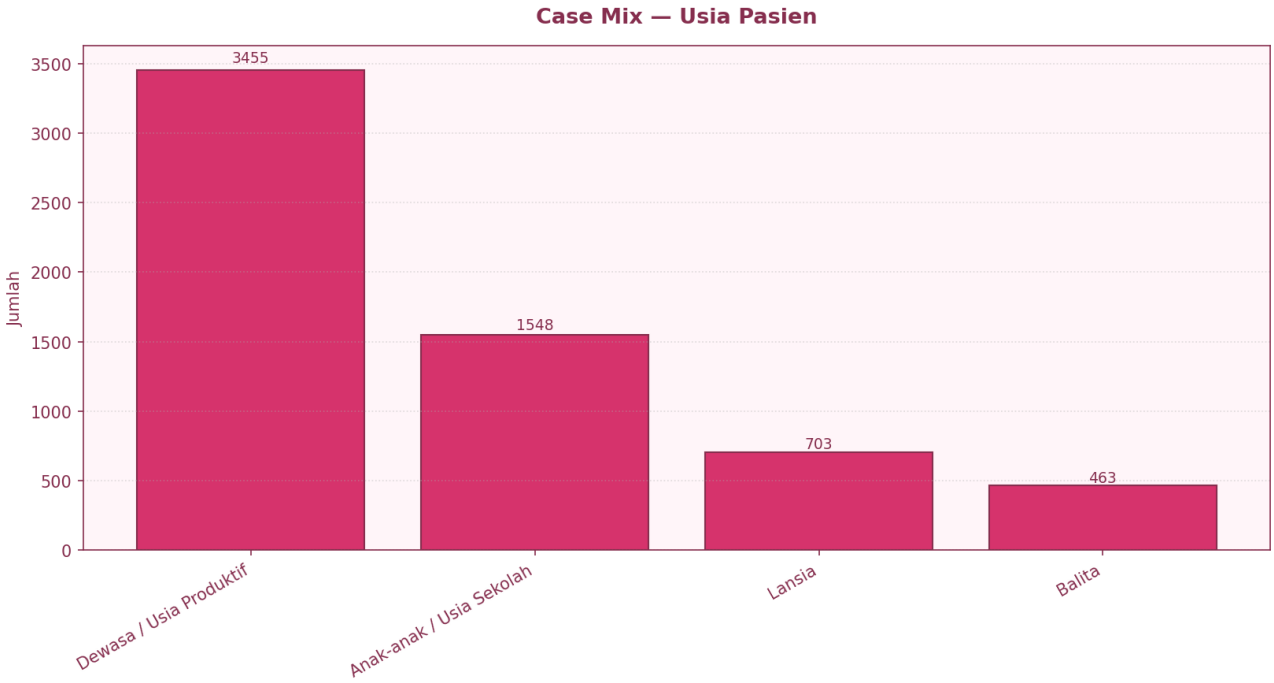
dr. Hesti Herlinawati



Perempuan dominan (55,9%) — selisih 11,8 poin dari laki-laki. Ini khas FKTP karena:
- Poli KIA (149 kunjungan) hampir seluruhnya perempuan (ibu hamil, KB, anak)
- Ibu rumah tangga lebih banyak waktu untuk berobat di jam kerja
- Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi, sehingga lansia perempuan lebih banyak
- Skrining & kontrol rutin lebih umum pada perempuan (kehamilan, KB, kanker serviks)



dr. Hesti Herlinawati

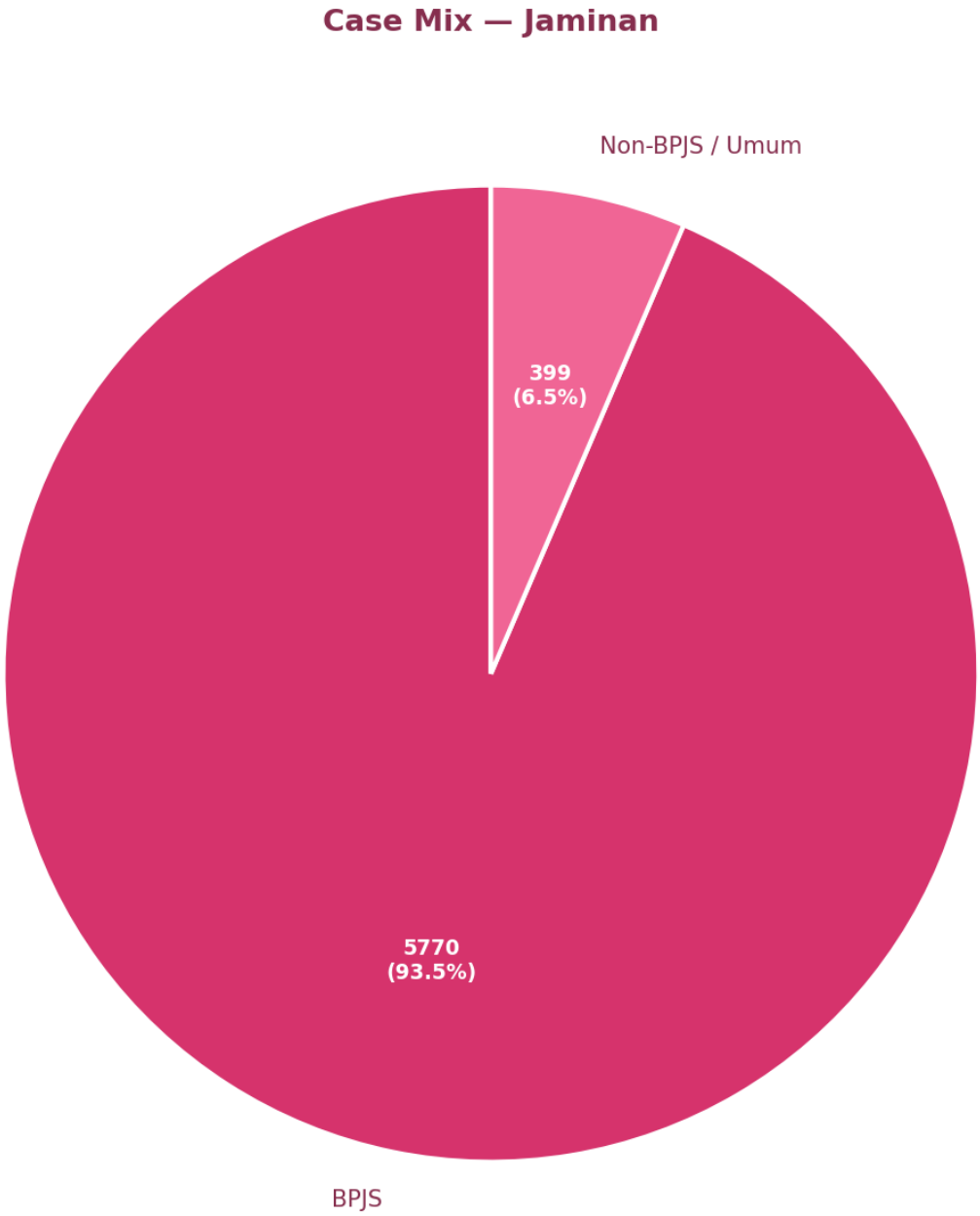


Interpretasi: Komposisi usia ini khas FKTP perkotaan — banyak pasien dewasa produktif (pekerja/ibu rumah tangga) dan anak sekolah. Lansia minoritas tapi paling sering dirujuk, karena beban penyakit kronis dan degeneratif. anak-anak relatif lebih mudah ditangani di FKTP





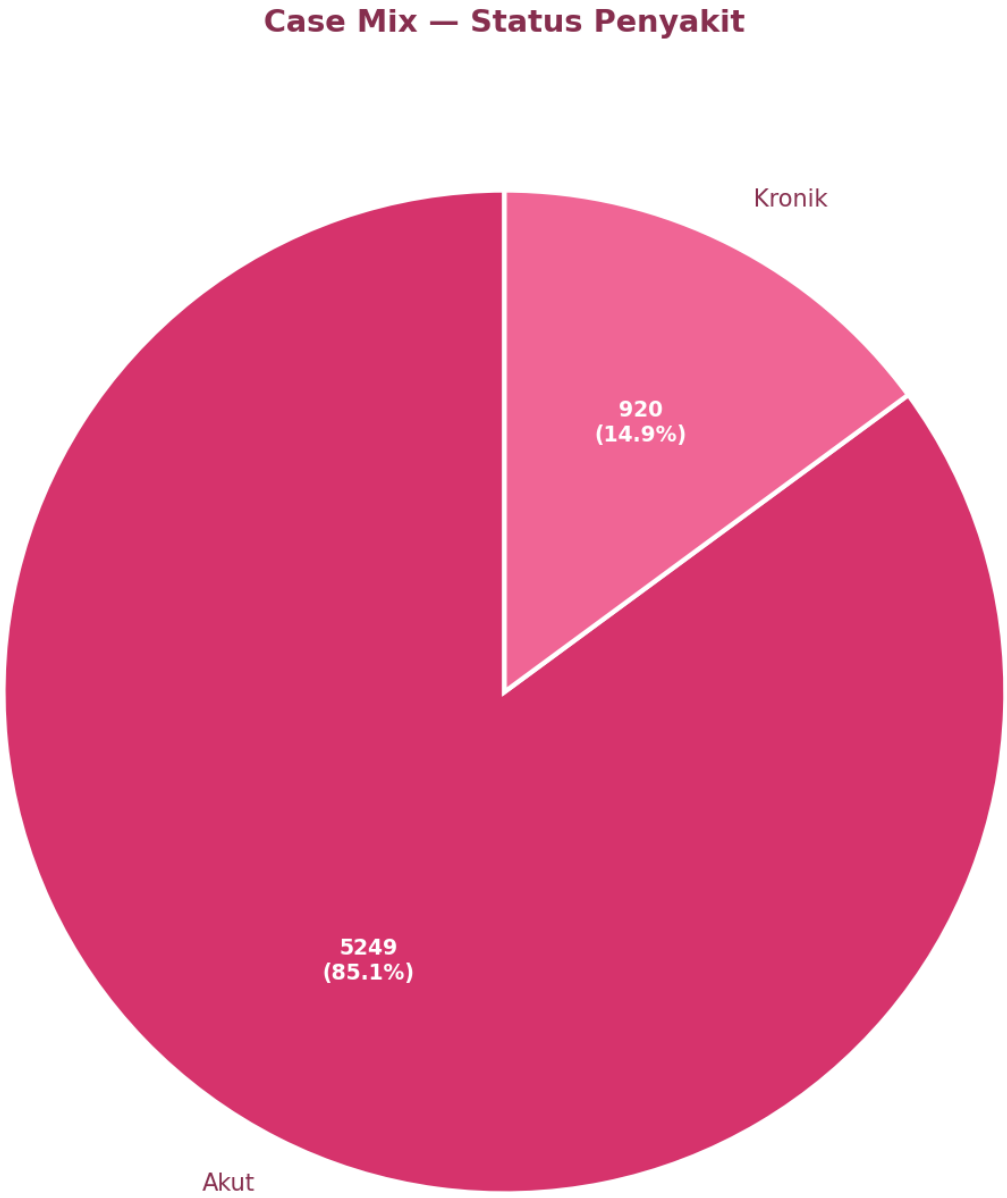
dr. Hesti Herlinawati



BPJS sangat dominan (93,5%) — mencerminkan bahwa klinik ini adalah FKTP mitra BPJS dengan 10.000 peserta terdaftar. Hanya 6,5% pasien umum/bayar sendiri. Implikasi : Ketergantungan tinggi pada BPJS — kebijakan BPJS (tarif, rujukan berjenjang) akan langsung berdampak pada operasional klinik.



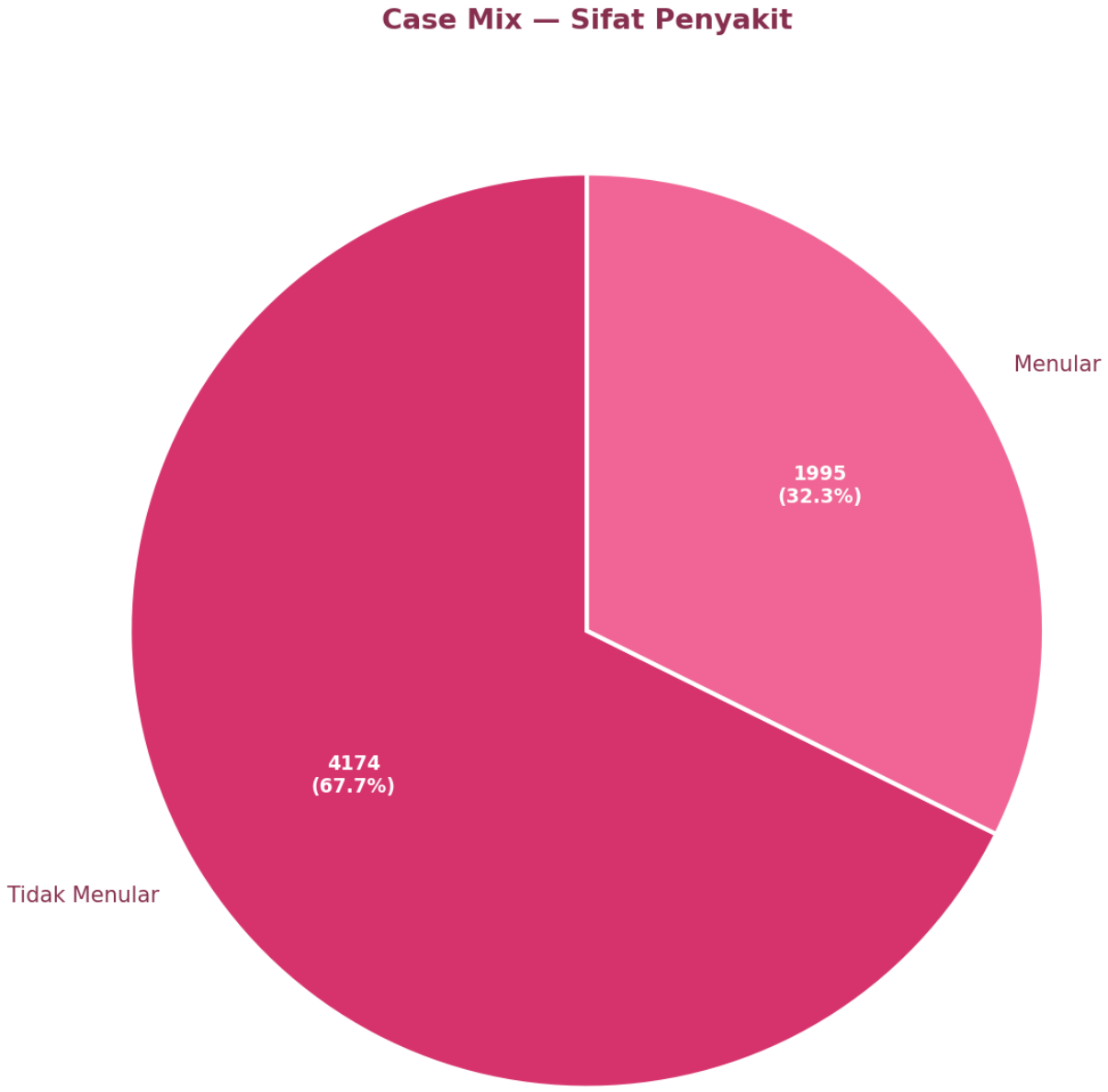
dr. Hesti Herlinawati



Didominasi penyakit akut (85,1%) — ini adalah karakteristik utama FKTP primer:
- ISPA, diare, demam, infeksi saluran kemih, dll.
- Sebagian besar self-limiting atau sembuh dengan terapi simtomatik
- Tidak memerlukan rujukan



dr. Hesti Herlinawati

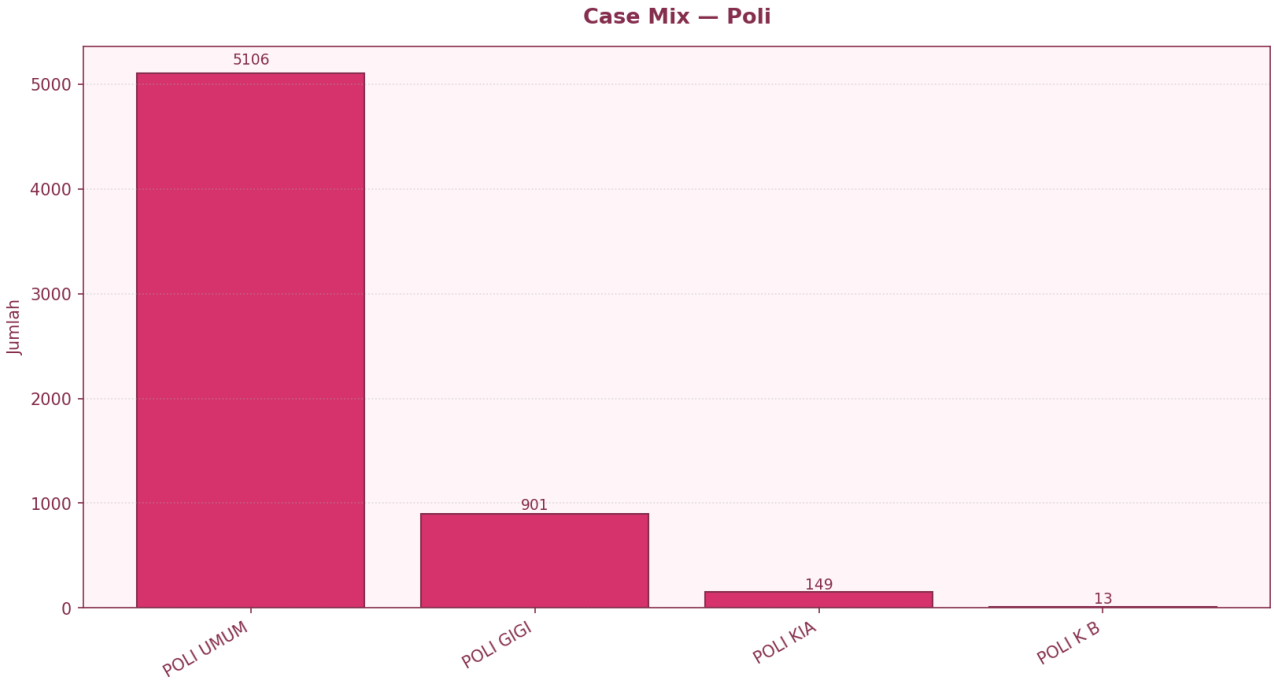


Penyakit tidak menular (PTM) 67,7% dan menular 32,3%.

Klasifikasi:
- Menular (1.995): ISPA (J06, J00, J02), diare (A09), TBC, infeksi kulit, dll.
- Tidak Menular (4.174): Hipertensi (I10), DM (E11), penyakit gigi (K04, K02), dispepsia (K30), gangguan muskuloskeletal (M54, M79), dll.



dr. Hesti Herlinawati



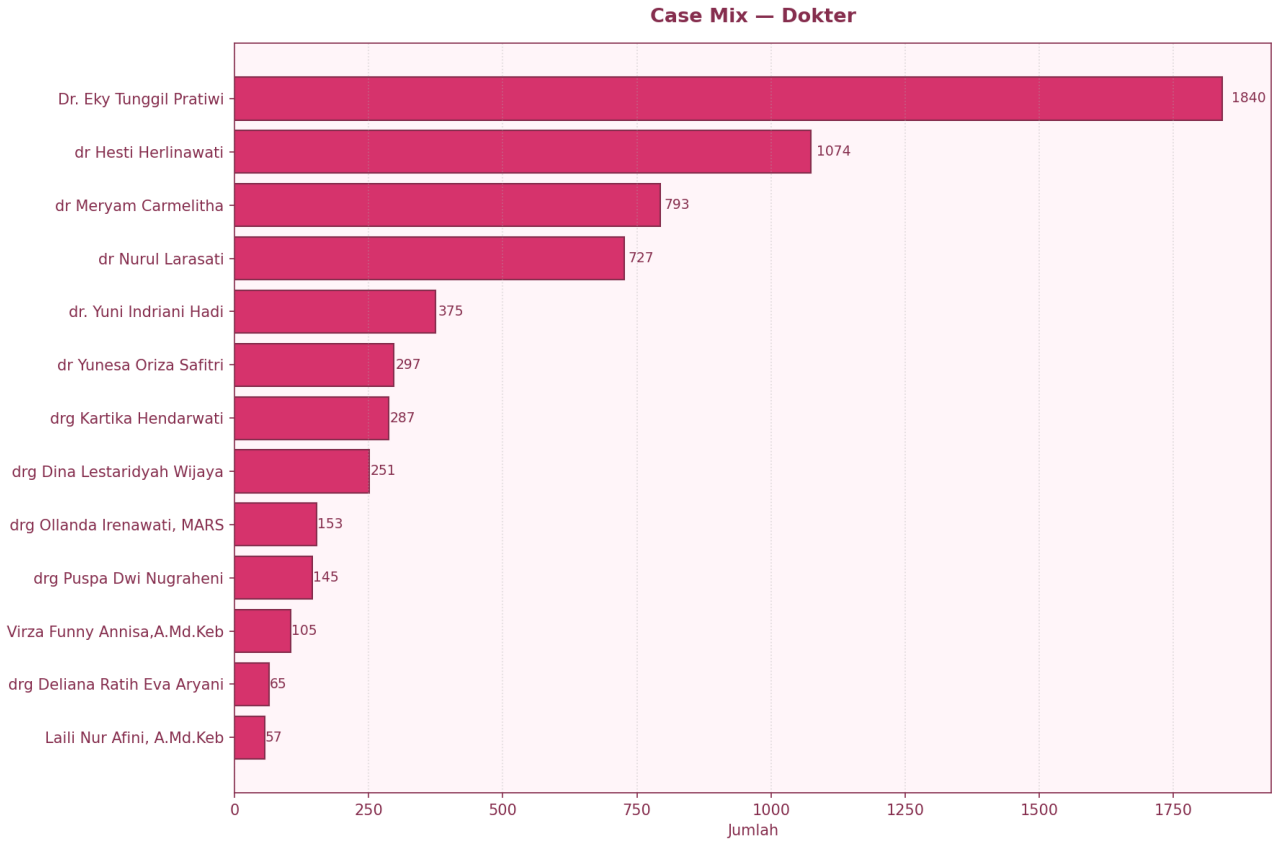
Poli Umum sangat dominan (82,8%) — hampir 5 dari 6 kunjungan. Ini tipikal FKTP:
- Pasien datang dengan keluhan umum (demam, batuk, pusing, sakit perut)
- Tidak perlu spesialis, cukup dokter umum
- Termasuk follow-up kronis (hipertensi, DM)

Poli Gigi 14,6% — signifikan untuk FKTP. Ini mencerminkan:
- Ketersediaan dokter gigi di klinik
- Permintaan tinggi untuk perawatan gigi (karies, pulpitis)
- BPJS menanggung perawatan gigi dasar

Poli KIA & KB kecil (2,6%) — meski kecil, punya karakteristik khusus:
- Poli KIA 84,21% rujukan berulang (ANC rutin)
- Poli KB hampir tidak pernah merujuk



dr. Hesti Herlinawati



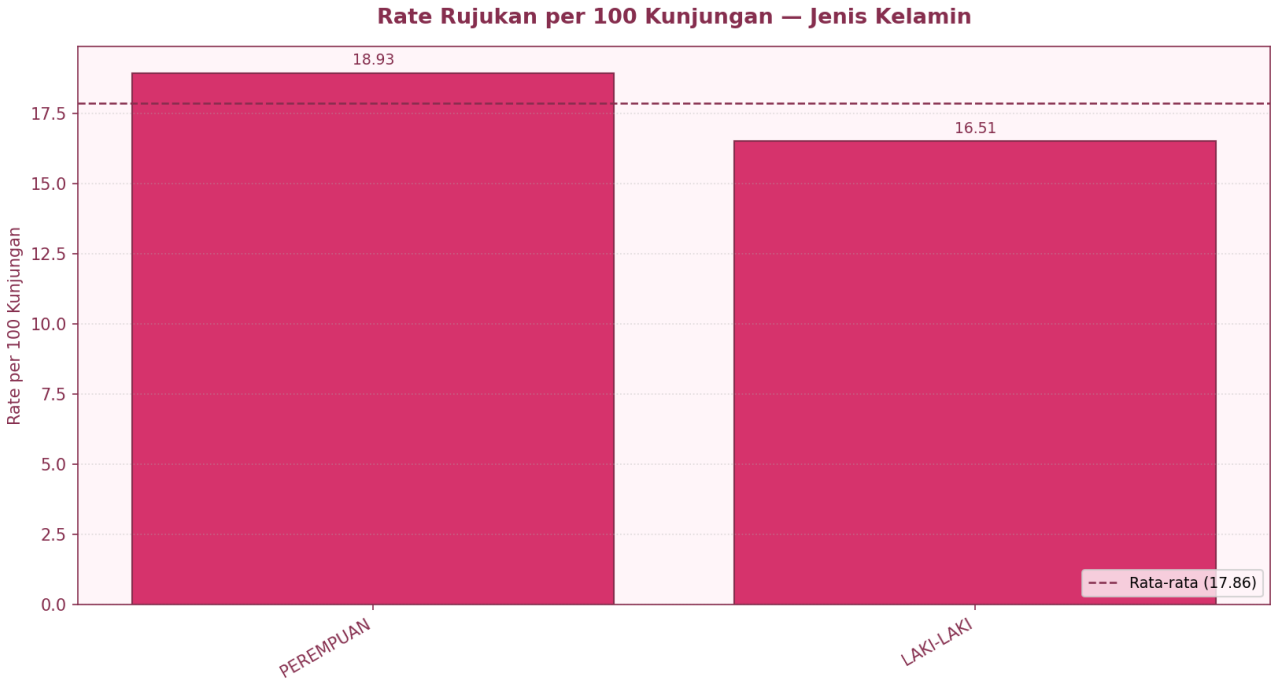
Konsentrasi tinggi: 4 dokter teratas menangani 71,9% kunjungan. Ini bisa jadi:
- Efisien — dokter senior dengan jam praktik lebih banyak
- Berisiko — ketergantungan pada individu tertentu; kalau berhalangan, kapasitas turun drastis

Pemisahan jelas dokter umum vs dokter gigi:
- Dokter umum (Eky, Hesti, Meryam, Nurul, Yuni, Yunesa): total 5.106 kunjungan = 82,8% (sesuai Poli Umum)
- Dokter gigi (Kartika, Dina, Ollanda, Puspa, Deliana): total 901 kunjungan = 14,6% (sesuai Poli Gigi)
- Bidan (Laili, Virza): total 162 kunjungan = 2,6% (Poli KIA & KB)



dr. Hesti Herlinawati

D.2. Rate Rujukan



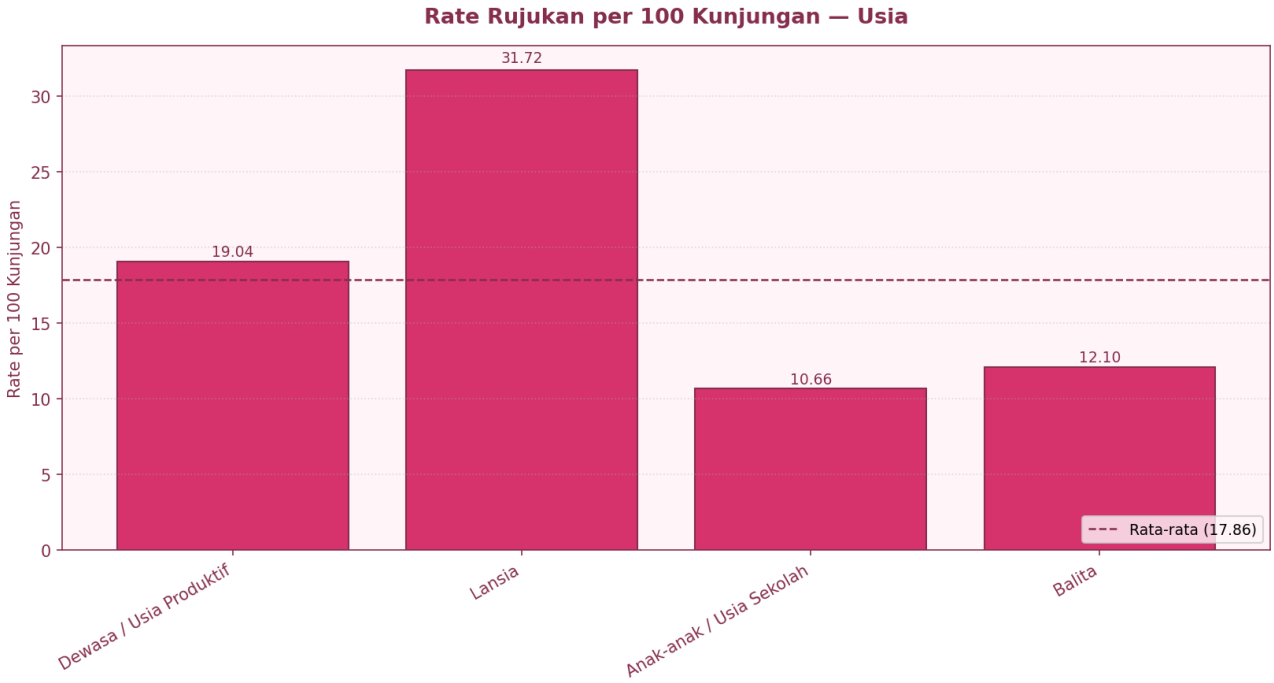
Perempuan memiliki rate rujukan 2,42 poin lebih tinggi dari laki-laki (18,93 vs 16,51). Meski selisihnya terlihat kecil, dalam konteks 6.169 kunjungan, ini berarti ~83 rujukan ekstra dari perempuan per periode.

Faktor penyebab:
- Poli KIA — ibu hamil yang butuh ANC lengkap (USG, lab) dirujuk rutin ke SpOG
- Lansia perempuan lebih banyak — karena angka harapan hidup lebih tinggi, beban penyakit kronis lebih besar
- Skrining & deteksi dini — perempuan lebih proaktif memeriksakan diri, sehingga lebih banyak kasus yang terdeteksi dan butuh rujukan lanjutan

Implikasi Audit:
Perbedaan ini wajar secara klinis. Yang perlu diaudit adalah apakah rujukan ANC (yang jadi penyumbang utama) memang esensial atau bisa dikurangi dengan peningkatan kapasitas USG/lab di klinik.



dr. Hesti Herlinawati



Lansia rate rujukan 31,72% — 1,78× rata-rata. Ini adalah temuan paling signifikan di seluruh analisis rate.

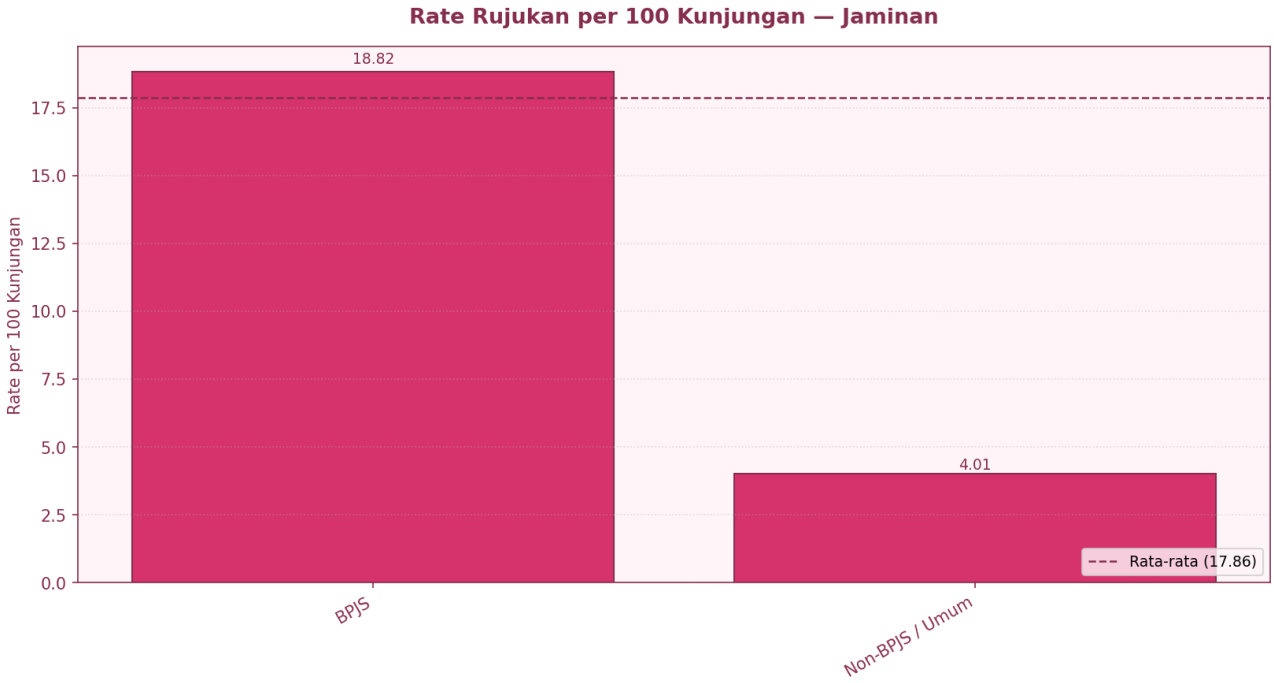
Mengapa lansia jauh lebih tinggi?
- Beban penyakit kronis & degeneratif — hipertensi, DM, PJK, gagal jantung, osteoarthritis
- Polifarmasi & komplikasi — butuh monitoring lab rutin, EKG, konsultasi spesialis
- Fragilitas — gejala ringan pada lansia bisa jadi pertanda penyakit serius, threshold rujuk lebih rendah
- Keterbatasan diagnostik FKTP — banyak kondisi lansia butuh pemeriksaan penunjang yang tidak tersedia

Anak-anak & Balita — rate terendah (10,66% dan 12,10%). Anak-anak umumnya:
- Penyakit akut self-limiting (ISPA, diare, demam)
- Respons cepat terhadap terapi simpel
- Tidak banyak komplikasi kronis

Implikasi Audit:
Lansia adalah target utama optimasi. Setiap penurunan 5 poin persen rate rujukan lansia akan menghemat ~35 rujukan per periode (dari 223 ke ~188). Strategi:
- Program Prolanis intensif untuk lansia kronis
- Skrining rutin di Posyandu Lansia
- Kunjungan rumah untuk pasien yang tidak kontrol
- Pelatihan dokter FKTP untuk tata laksana kronis



dr. Hesti Herlinawati



BPJS rate 18,82% vs Non-BPJS 4,01% — beda 4,7× lipat. Ini bukan berarti pasien BPJS "lebih sakit", tapi mencerminkan perbedaan struktural sistem:

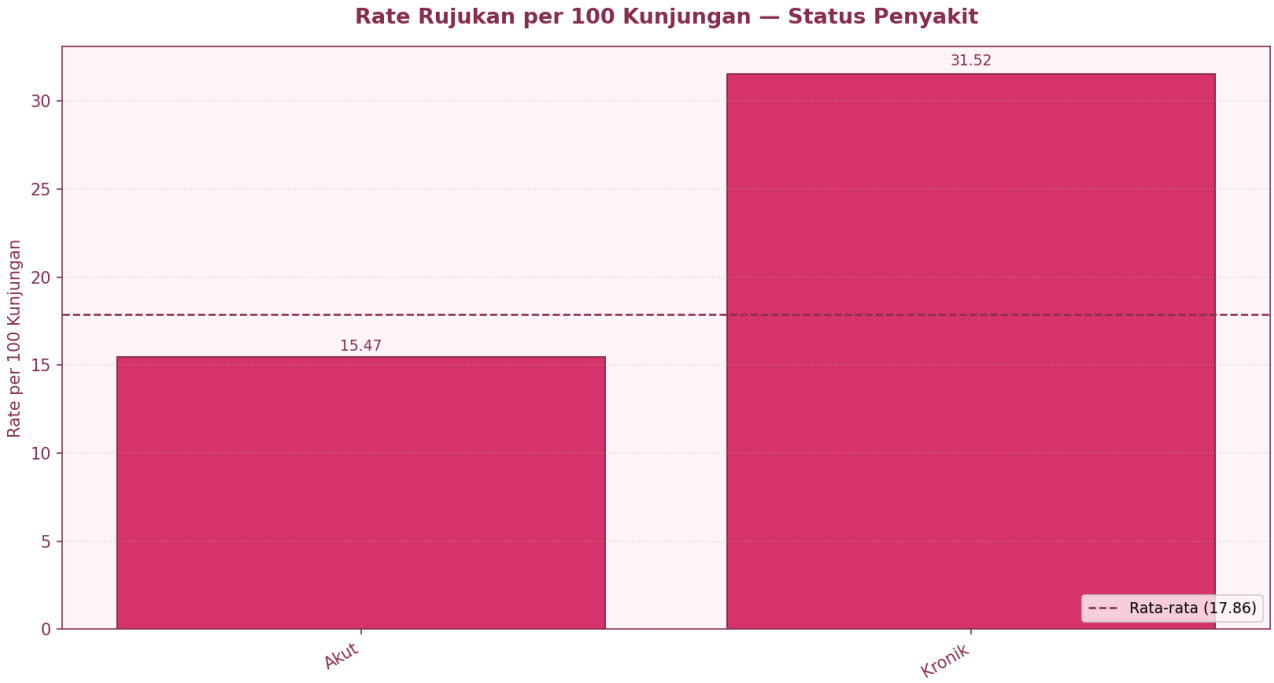
- Rujukan berjenjang BPJS — pasien BPJS wajib melalui FKTP untuk akses ke spesialis. Jadi semua rujukan formal tercatat di klinik.
- Pasien Non-BPJS — bebas langsung ke dokter spesialis/RS tanpa lewat FKTP. Rujukan yang tercatat di klinik hanya sebagian kecil (kasus yang kebetulan datang ke klinik dulu).
- Perbedaan case mix — pasien umum cenderung:
  - Kasus ringan (batuk pilek, kontrol ringan) yang tidak butuh rujukan
  - ATAU kasus kompleks yang sudah punya langganan dokter spesialis (tidak lewat FKTP)

Implikasi Audit:

- Rate rujukan yang relevan untuk audit internal BPJS adalah 18,82% (mode BPJS), bukan 17,86% (all)
- Tingginya rate BPJS bukan masalah — ini konsekuensi desain sistem rujukan berjenjang
- Yang perlu diaudit: apakah rujukan BPJS efisien? Apakah ada rujukan yang seharusnya bisa ditangani FKTP?



dr. Hesti Herlinawati



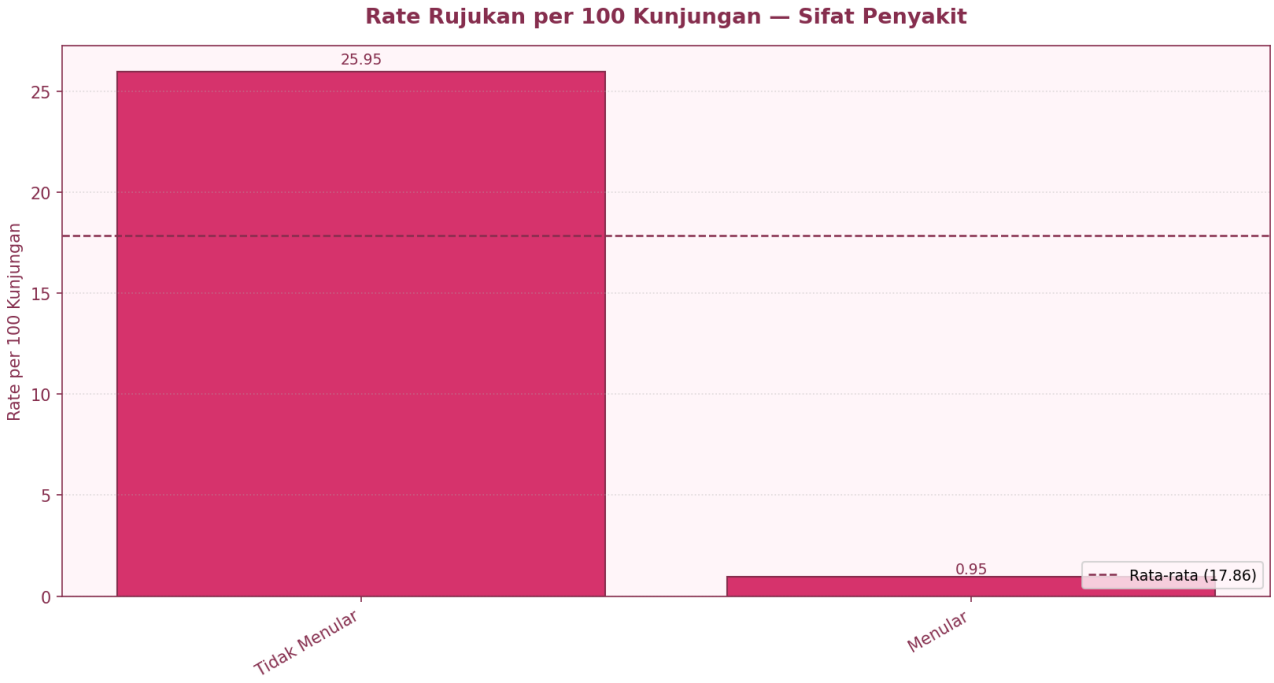
Penyakit kronis rate 31,52% — 2,04× penyakit akut (15,47%). Ini adalah temuan kedua paling signifikan setelah lansia.

Mengapa kronis jauh lebih tinggi?
- Butuh pemeriksaan penunjang berkala — HbA1c, profil lipid, EKG, ekokardiografi, funduskopi
- Komplikasi multi-organ — DM → nefropati, retinopati, neuropati; hipertensi → jantung, ginjal, stroke
- Manajemen kompleks — titrasi obat, evaluasi respons terapi
- Keterbatasan FKTP — tidak semua alat penunjang tersedia

Implikasi Audit:
- 920 kunjungan kronis → 290 rujukan. Kalau bisa turunkan rate ke 25%, hemat ~60 rujukan per periode
- Diagnosis kronis penyumbang utama: I11, I15, E11.6, I25, E11.8, I50.0 (semua di top 10 diagnosis rujukan)
- Strategi: Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang lebih intensif



dr. Hesti Herlinawati



Kontras ekstrem: PTM 25,95% vs Menular 0,95% — beda 27× lipat.

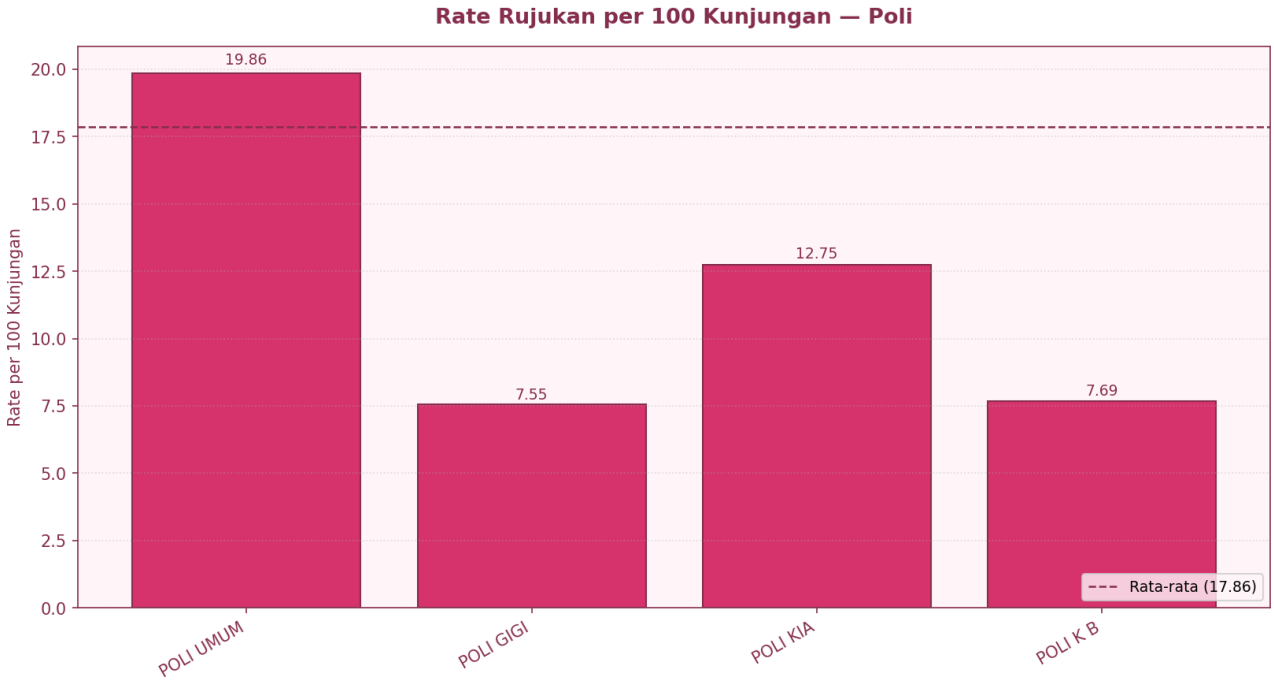
Temuan kunci:
- Penyakit menular hampir tidak pernah dirujuk (0,95%) — FKTP sangat mampu menangani ISPA, diare, infeksi kulit, dll.
- Penyakit tidak menular sangat sering dirujuk (25,95%) — PTM adalah penyumbang utama beban rujukan

Paradoks yang menarik: Penyakit menular sering dianggap lebih berbahaya (wabah, pandemi), tapi dalam konteks FKTP, justru PTM yang menjadi beban rujukan. Ini karena:
- Penyakit menular akut → sembuh, tidak butuh spesialis
- PTM kronis → manajemen jangka panjang, sering butuh spesialis untuk komplikasi

Implikasi Audit:
- 19 rujukan menular dari 1.995 kunjungan — hampir sempurna. Ini kekuatan FKTP yang harus dipertahankan.
- 1.083 rujukan tidak menular — 98,3% dari total rujukan. Fokus audit harus di sini.



dr. Hesti Herlinawati



Poli Umum rate tertinggi (19,86%) — konsisten dengan perannya sebagai gerbang utama:
- Menangani semua keluhan umum
- Menerima pasien kronis rujukan balik dari spesialis
- Melakukan rujukan ketika butuh spesialis

Poli Gigi rate terendah (7,55%) — karakteristik rujukan gigi:
- Umumnya sekali tindakan (ekstraksi, penambalan, endodontik)
- Tindakan selesai → tidak perlu rujukan lanjutan
- Yang dirujuk: kasus yang butuh spesialis (bedah mulut, endodonsi)

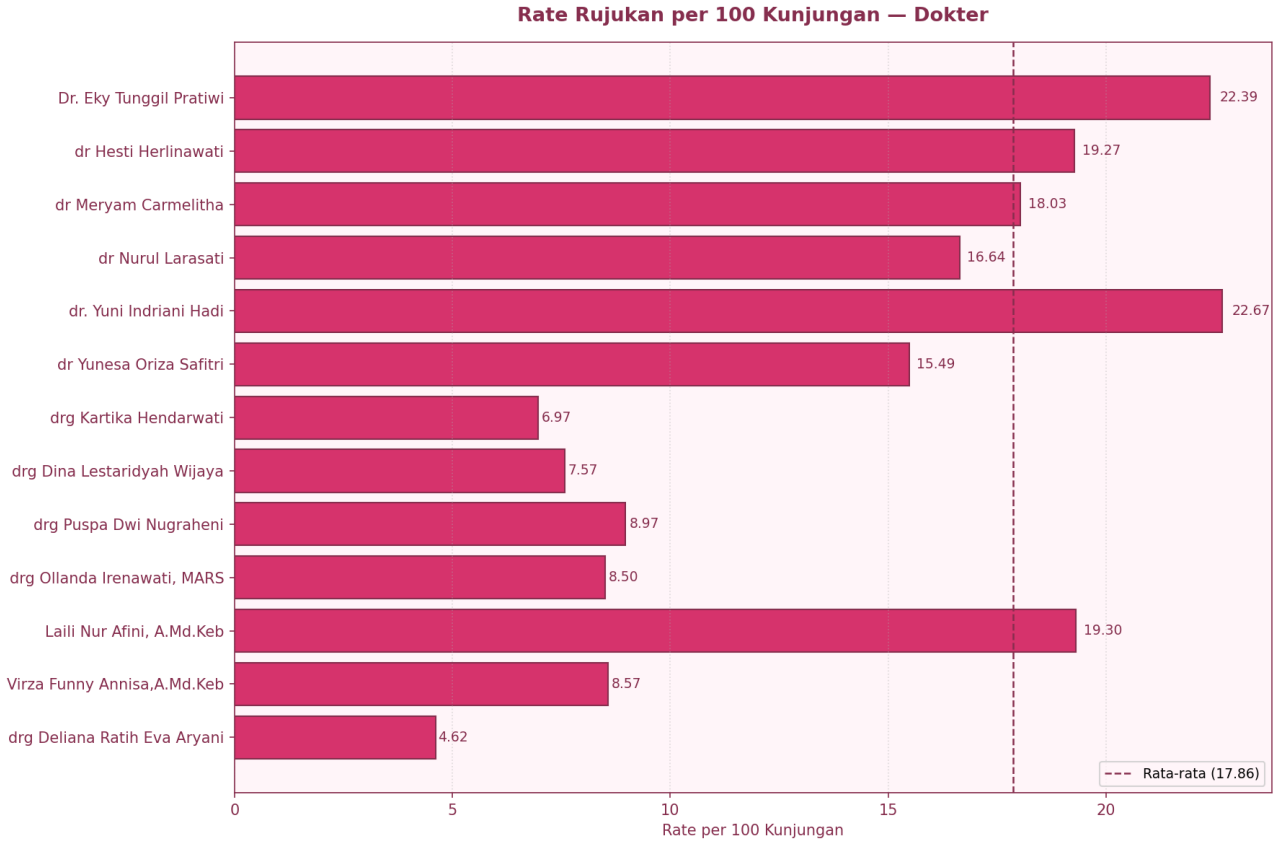
Poli KIA (12,75%) — di tengah:
- ANC normal → tidak dirujuk
- ANC risiko tinggi / butuh USG detail → dirujuk ke SpOG
- Kontrasepsi rumit → dirujuk

Poli KB rate terendah kedua (7,69%) — hampir semua KB bisa dikelola di FKTP. 1 rujukan dari 13 kunjungan (kasus khusus).

Implikasi Audit:
- Poli Umum adalah tempat audit utama — 1.014 dari 1.102 rujukan (92%) berasal dari sini
- Fokus: apakah 19,86% ini wajar, atau ada rujukan yang bisa dicegah?
- Poli Gigi & KB — sudah optimal, tidak perlu intervensi



dr. Hesti Herlinawati



Faktor 1 — Case mix berbeda:
- Dokter dengan pasien kronis lebih banyak → rate lebih tinggi
- Dokter gigi → rate rendah karena case mix-nya (tindakan sekali)
- Bidan → tergantung populasi KIA (ANC risiko tinggi vs normal)

Faktor 2 — Threshold klinis:
- Dokter A mungkin lebih konservatif (coba terapi dulu, rujuk kalau gagal)
- Dokter B mungkin lebih cepat merujuk (karena pertimbangan risiko, atau jam praktik terbatas)

Faktor 3 — Volume & pengalaman:
- Dokter dengan volume tinggi (Eky, 1.840 kunjungan) punya sampel besar — rate bisa stabil
- Dokter dengan volume rendah (Deliana, 65 kunjungan) — rate bisa fluktuatif

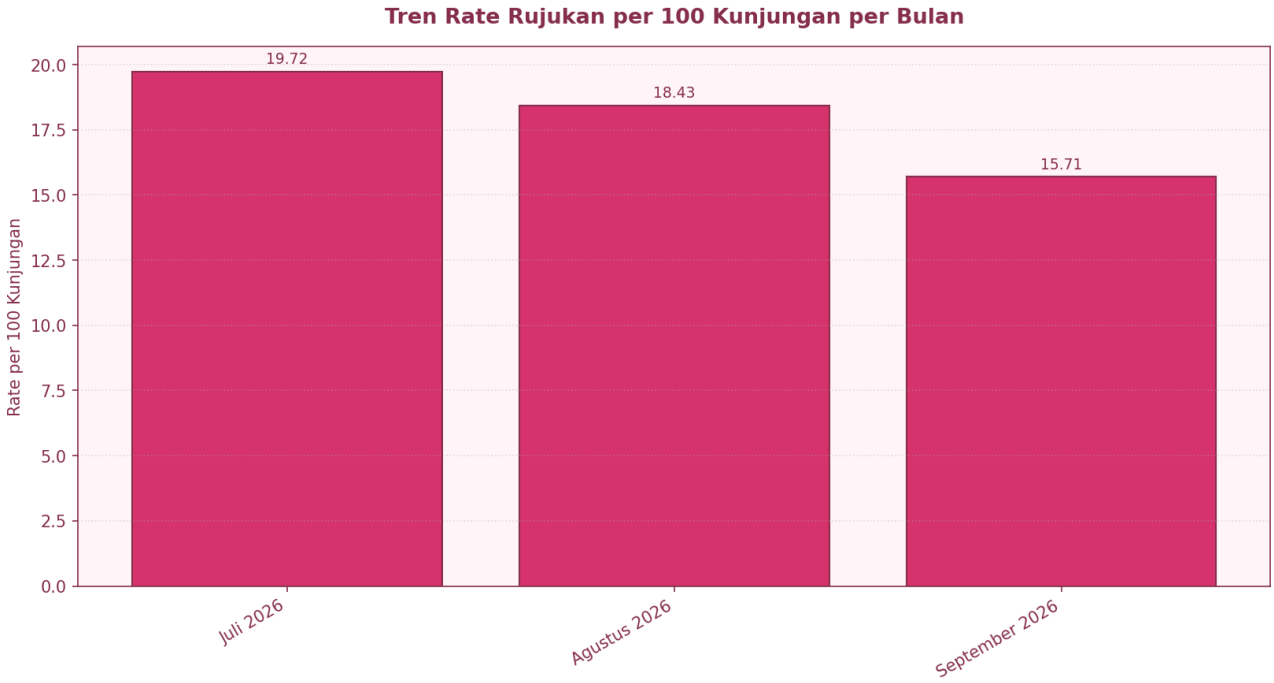
Analisis spesifik:
- dr. Yuni (22,67%) dan Dr. Eky (22,39%) — dua rate tertinggi. Perlu di-review: apakah keduanya menangani lebih banyak kasus kompleks, atau memang lebih cepat merujuk?
- Dokter gigi (4,62%–8,97%) — wajar, sesuai karakter tindakan gigi
- dr Yunesa (15,49%) — paling rendah di kelompok dokter umum, mungkin lebih banyak kasus ringan atau threshold lebih tinggi

Implikasi Audit:

- Standardisasi kriteria rujukan — perlu pedoman klinis yang jelas agar tidak ada perbedaan tak terjelaskan
- Peer review — dokter dengan rate ekstrem (±2 SD dari rata-rata) perlu di-review kasus per kasus
- Kalibrasi — pertemuan rutin untuk membahas kasus borderline



dr. Hesti Herlinawati



Temuan kunci: Di September, kunjungan naik 15% tapi rujukan justru turun 2%. Inilah yang membuat rate turun drastis.

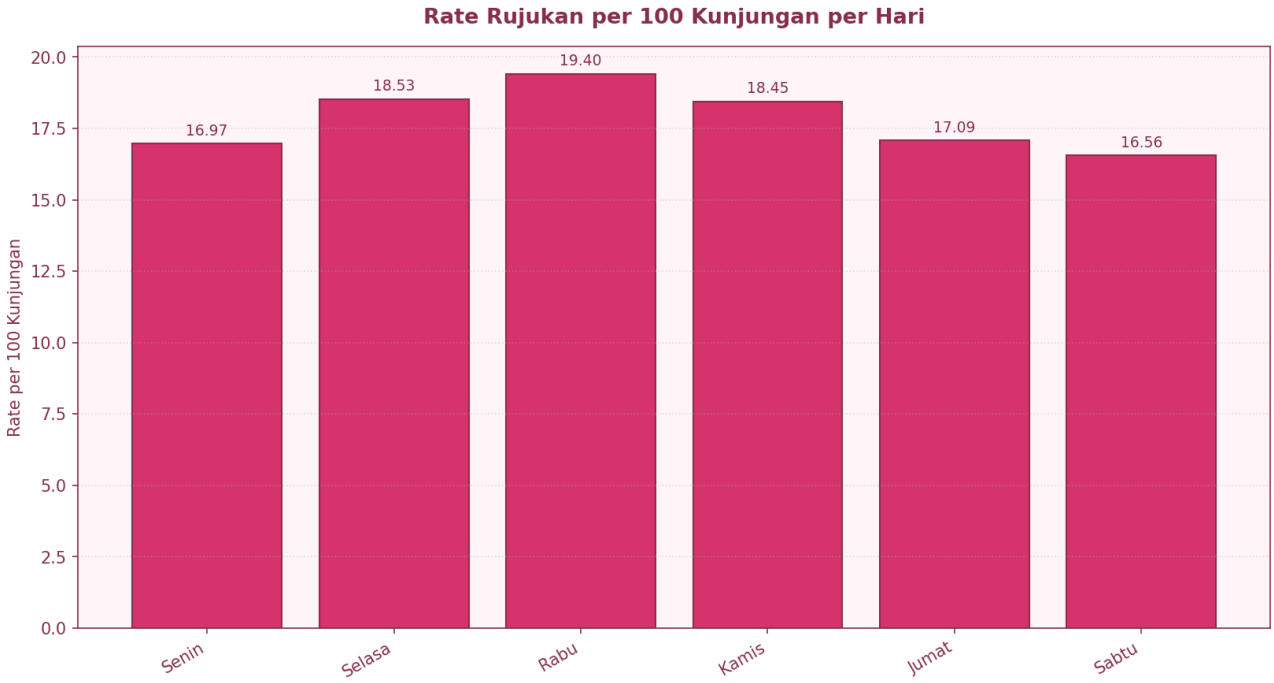
Penjelasan (dari Bagian E nanti): Kenaikan kunjungan September sepenuhnya didorong oleh lonjakan ISPA (J06.9, J06, J00). Karena ISPA hampir tidak pernah dirujuk (rate <0,1%), ini secara otomatis menurunkan rate rujukan agregat — meski kualitas rujukan tidak berubah.

Kesimpulan penting:
- Penurunan rate bukan (sepenuhnya) karena kualitas membaik — sebagian besar artifisial
- Kalau ingin mengukur kualitas rujukan yang sesungguhnya, perlu analisis case-mix adjusted atau fokus ke diagnosis kronis saja
- Yang tetap valid: jumlah rujukan absolut turun dari 394 → 351 (turun 11%) selama 3 bulan

Implikasi Audit:
- Jangan cepat puas dengan "rate turun" — perlu verifikasi apakah ini perbaikan nyata atau efek komposisi
- Lihat tren rujukan absolut lebih informatif daripada rate saja
- Fokus: apakah rujukan kronis (I11, E11, I25) juga turun?



dr. Hesti Herlinawati



1. Senin — kunjungan tertinggi, rate terendah
- Pasien baru/akut ringan banyak datang Senin (setelah akhir pekan)
- Kasus-kasus "weekend effect" — demam, batuk, diare yang muncul Sabtu-Minggu, baru berobat Senin
- Kasus ringan ini tidak dirujuk → menurunkan rate

2. Rabu — kunjungan moderat, rate tertinggi
- Jadwal dokter spesialis di RS tujuan — mungkin spesialis tertentu praktik Rabu, sehingga dokter FKTP sengaja merujuk pasien di hari itu
- Jadwal dokter FKTP — mungkin dokter dengan case-mix kronis praktik Rabu
- Ketersediaan penunjang di RS lebih baik hari Rabu (lab, radiologi)

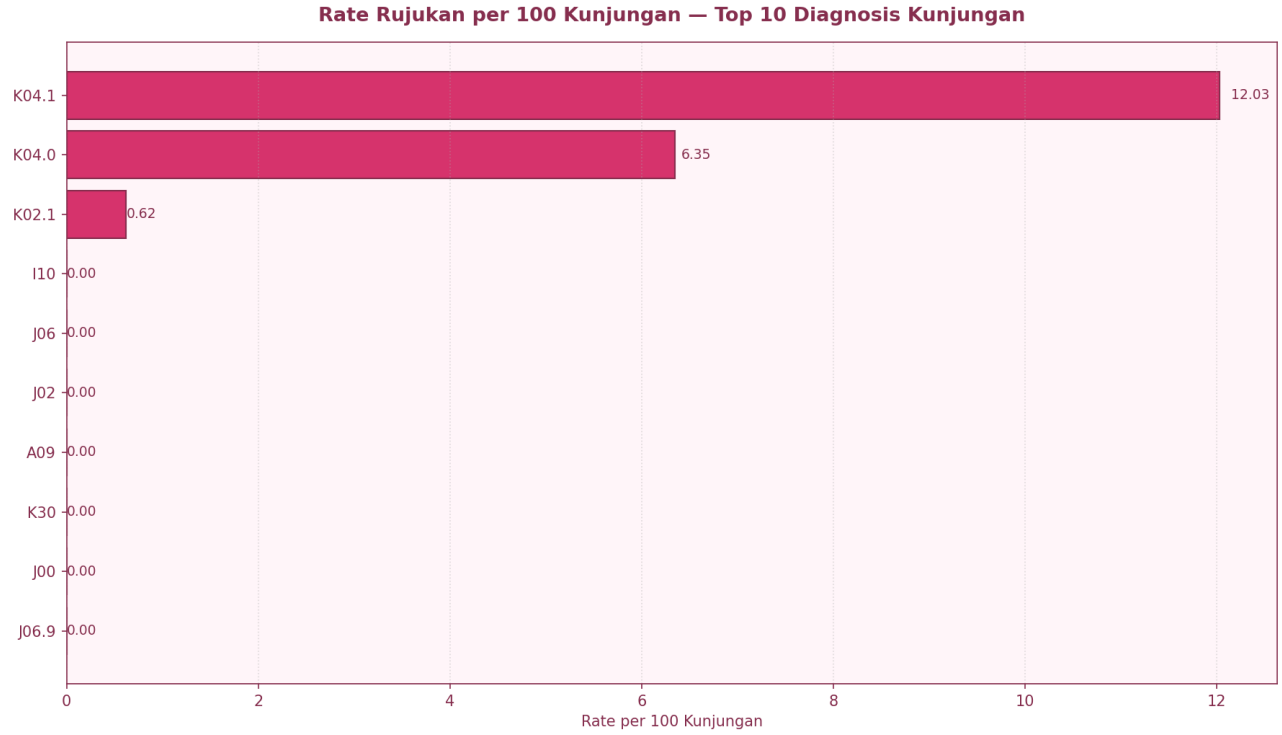
3. Sabtu — kunjungan moderat, rate terendah
- Sabtu klinik tetap buka (dari data ada Sabtu). Rate rendah karena:
- Pasien yang datang Sabtu mungkin kasus ringan (yang tidak bisa ke klinik hari kerja)
- Ketersediaan RS tujuan pada Sabtu terbatas → dokter FKTP menahan rujukan ke hari kerja
- Dokter spesialis banyak yang tidak praktik Sabtu

Pola harian ini punya implikasi operasional:
- Beban rujukan tidak merata — Rabu paling tinggi
- Perlu diselidiki: apakah ini karena case mix (pasien Rabu lebih kompleks) atau jadwal sistem (RS tujuan)?
- Peluang optimasi: kalau penyebabnya jadwal, bisa diatur redistribusi

Implikasi Audit:
- Audit internal perlu mempertimbangkan hari — dokter yang praktik Rabu mungkin punya rate lebih tinggi bukan karena perilaku, tapi karena jadwal
- Kemitraan RS — koordinasi jadwal spesialis dengan FKTP bisa meratakan beban rujukan
- Analisis heatmap (grafik 41 dan 42) akan mengungkap pola poli × hari dan spesialis × hari



dr. Hesti Herlinawati



Ini adalah rate rujukan dilihat dari diagnosis kunjungan. Menjawab: "Kalau pasien datang dengan diagnosis X, seberapa besar kemungkinan dirujuk?"

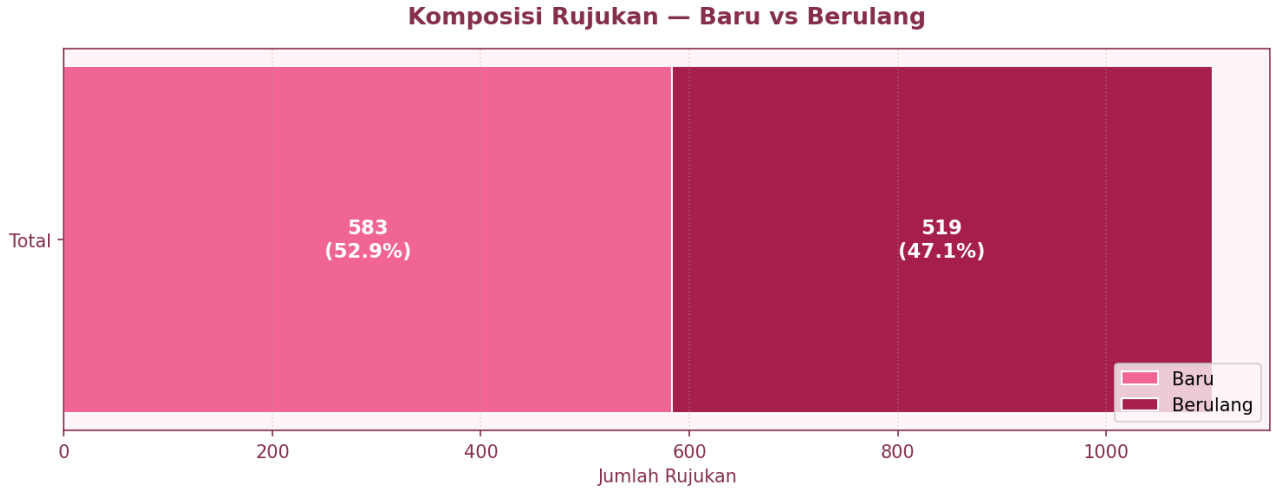
Pola ekstrem:
- 3 diagnosis dengan rate >0%: K04.1 (12,03%), K04.0 (6,35%), K02.1 (0,62%) — semuanya diagnosis gigi
- 7 diagnosis dengan rate 0%: I10, J06, J02, A09, K30, J00, J06.9 — semua penyakit akut/infeksi ringan & hipertensi esensial

Implikasi:
- K04.1 (nekrosis pulpa) — rate 12,03%, tertinggi. Wajar: nekrosis pulpa butuh perawatan saluran akar (PSA) yang tidak selalu tersedia di FKTP → dirujuk ke Gigi Endodonsi
- K04.0 (pulpitis) — rate 6,35%. Pulpitis awal bisa ditangani (penambalan), pulpitis lanjut butuh PSA → sebagian dirujuk
- K02.1 (karies dentin) — rate 0,62%. Karies bisa ditambal di FKTP → hampir tidak pernah dirujuk
- Semua diagnosis non-gigi rate 0% — menandakan FKTP sangat mampu menangani:
  - ISPA (J06, J06.9, J00, J02) → 1.590 kunjungan, 0 rujukan
  - Diare (A09) → 161 kunjungan, 0 rujukan
  - Dispepsia (K30) → 213 kunjungan, 0 rujukan
  - Hipertensi esensial (I10) → 302 kunjungan, 0 rujukan

Temuan penting:
- Hipertensi esensial (I10) → 0 rujukan dari 302 kunjungan. Artinya: FKTP sudah mengelola hipertensi tanpa komplikasi dengan sangat baik. Yang dirujuk adalah I11 (hipertensi dengan komplikasi) — masuk top 2 diagnosis rujukan (48 kasus).
- ISPA → 0 rujukan dari 1.590 kunjungan. Kekuatan FKTP yang harus dipertahankan.



dr. Hesti Herlinawati



Ini adalah rate rujukan dilihat dari jenis rujukan (baru vs berulang). Kedua baris memakai denominator yang sama (total kunjungan 6.169) supaya bisa dibandingkan.

Perbandingan:
- Baru: 583/6.169 = 9,45%
- Berulang: 519/6.169 = 8,41%
- Total: 1.102/6.169 = 17,86%

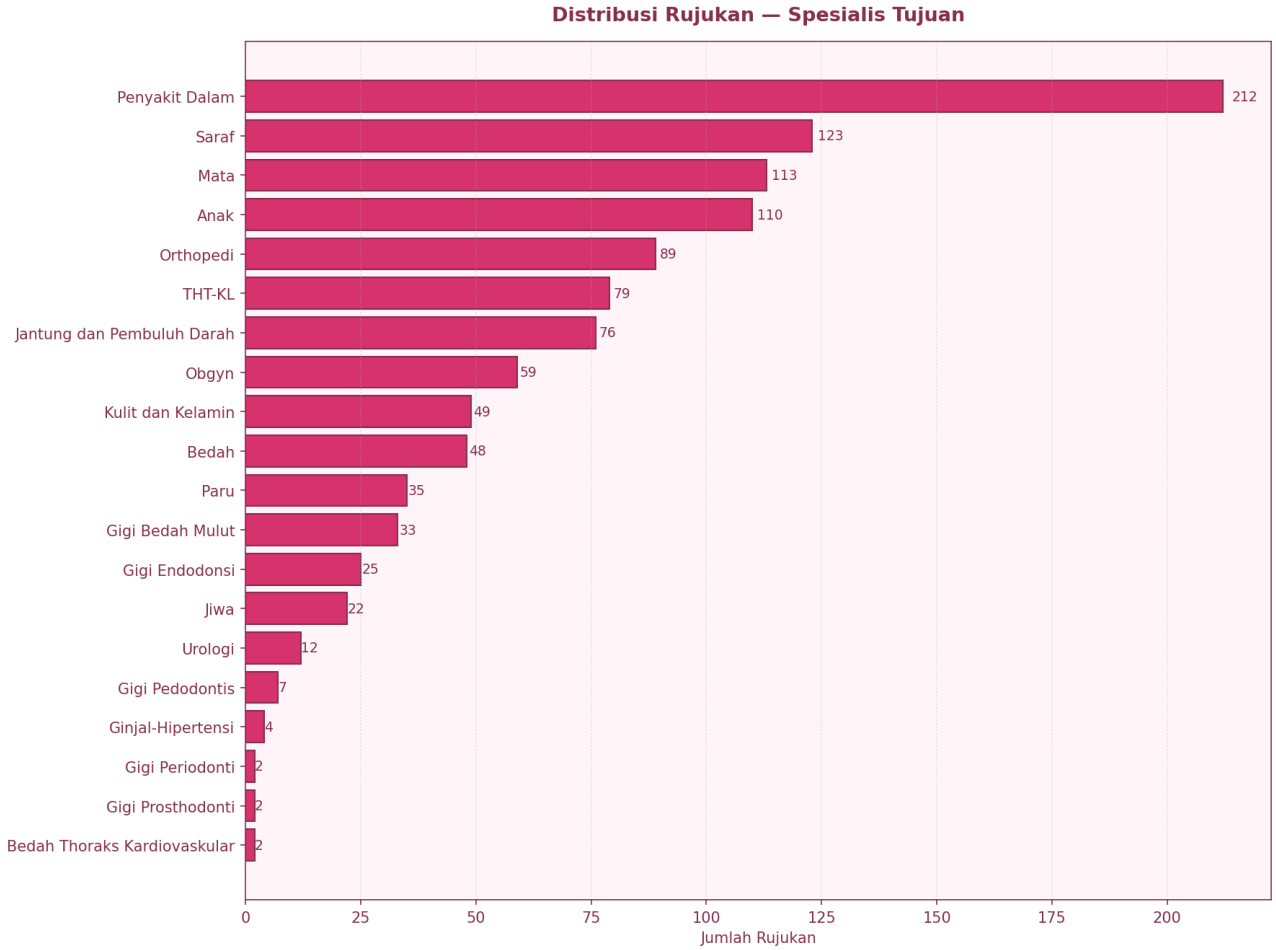
Artinya: Dari setiap 100 kunjungan, 9,45 menghasilkan rujukan baru dan 8,41 menghasilkan rujukan berulang. Hampir seimbang (52,9% : 47,1%).

Implikasi:
- Rujukan berulang 8,41% dari seluruh kunjungan — hampir setengah beban rujukan
- Kalau berhasil turunkan rate rujukan berulang dari 8,41% → 6%, akan hemat ~140 rujukan per periode
- Fokus optimasi: pasien kronis yang rutin dirujuk



dr. Hesti Herlinawati

D.3. Distribusi Rujukan



Karakteristik:

🥇 Penyakit Dalam (212, 19,2%)
Menangani semua penyakit kronis dewasa: DM, hipertensi, jantung, ginjal, hati
82,55% berulang — mayoritas pasien kontrol rutin
Diagnosis terkait: I11, E11.6, E11.8, I15, I25

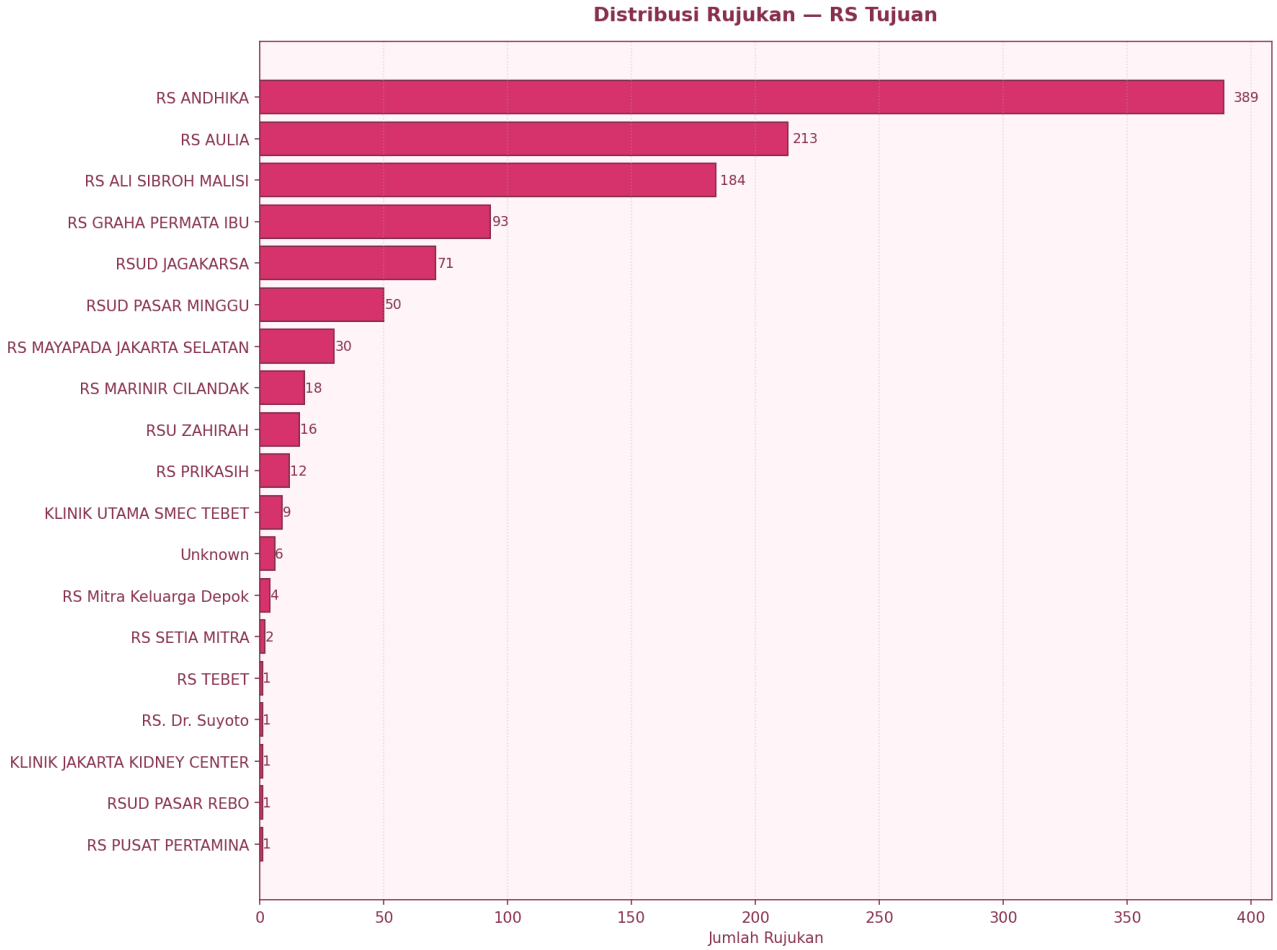
🥈 Saraf (123, 11,2%)
Stroke, neuropati DM, epilepsy, nyeri kronis, vertigo
58,54% berulang

🥉 Mata (113, 10,2%)
Didorong H54.2 (low vision) — diagnosis rujukan #1
16,81% berulang — mayoritas kasus baru (katarak, refraksi, low vision baru)

Implikasi Audit:
- Fokus optimasi di Penyakit Dalam, Saraf, Jantung, Paru
- Mata & THT — tidak perlu dioptimasi, rujukannya kasus baru yang butuh tindakan spesifik



dr. Hesti Herlinawati



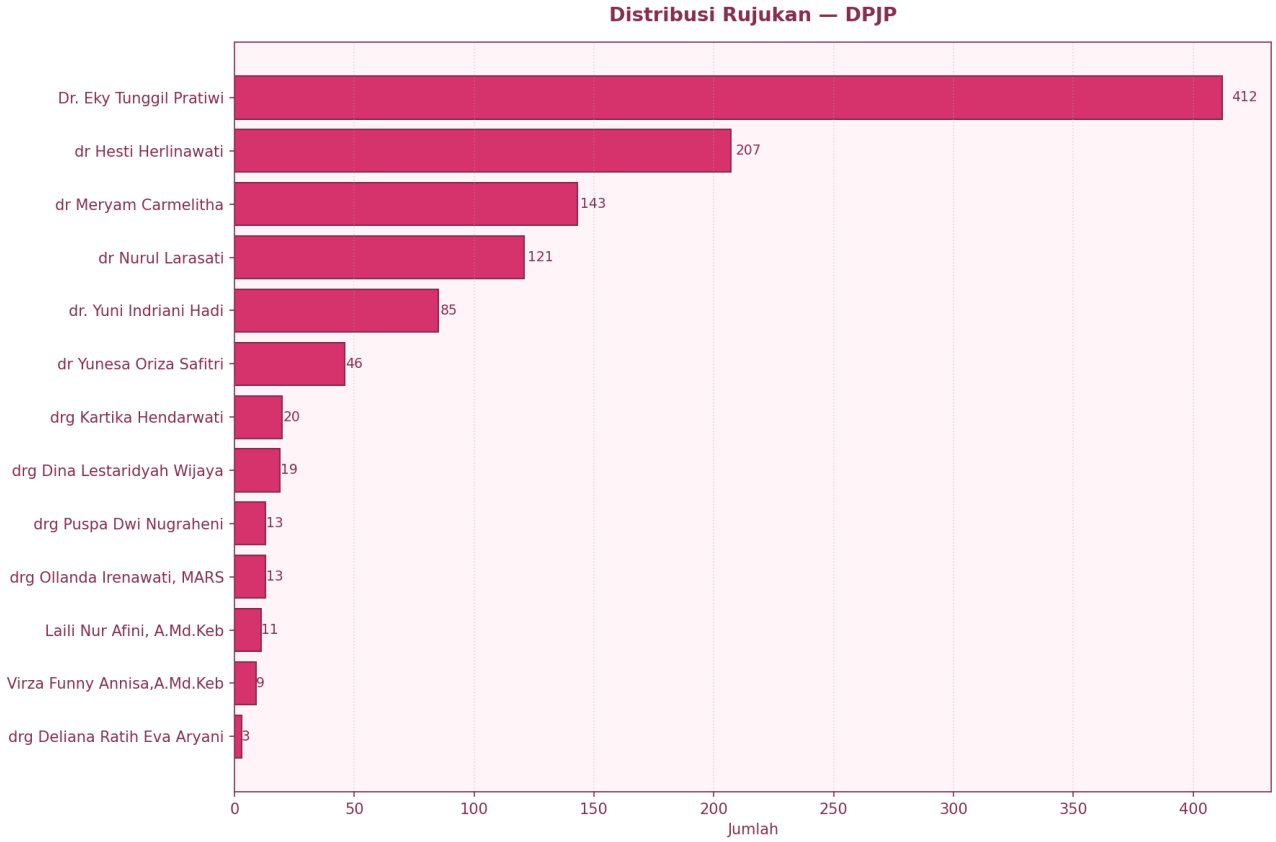
Konsentrasi tinggi: 3 RS teratas menampung 71,3% rujukan (786 dari 1.102).

Analisis 3 RS utama:
🥇 RS Andhika (389, 35,3%)
🥈 RS Aulia (213, 19,3%)
🥉 RS Ali Sibroh Malisi (184, 16,7%)

Implikasi Audit:
- Kemitraan strategis dengan 3 RS utama — jalur cepat, feedback rujukan
- RS Zahirah (81% berulang) — RS tujuan khusus kronis. Bisa diatur sistem rujukan kolektif/jadwal bersama
- RS Graha Permata Ibu (27% berulang) — mayoritas rujukan baru
- 6 rujukan "Unknown" — perlu perbaikan data input rujukan (khususnya non-BPJS)



dr. Hesti Herlinawati



Konsentrasi sangat tinggi: 5 dokter teratas menyumbang 87,8% rujukan (968 dari 1.102).

Kaitan volume kunjungan vs kontribusi rujukan:

Dokter	Kunjungan	Rujukan	Selisih
dr. Eky	29,83	37,39	+7,56
dr Hesti	17,41	18,78	+1,37
dr Meryam	12,85	12,98	+0,13
dr Nurul	11,78	10,98	-0,80
dr. Yuni	6,08	7,71	+1,63

Temuan:
- dr. Eky — over-represented (+7,56), merujuk lebih sering per kunjungan
- dr. Yuni — over-represented (+1,63), konsisten dengan rate 22,67% (tertinggi)
- dr Nurul — under-represented, lebih sedikit merujuk per kunjungan

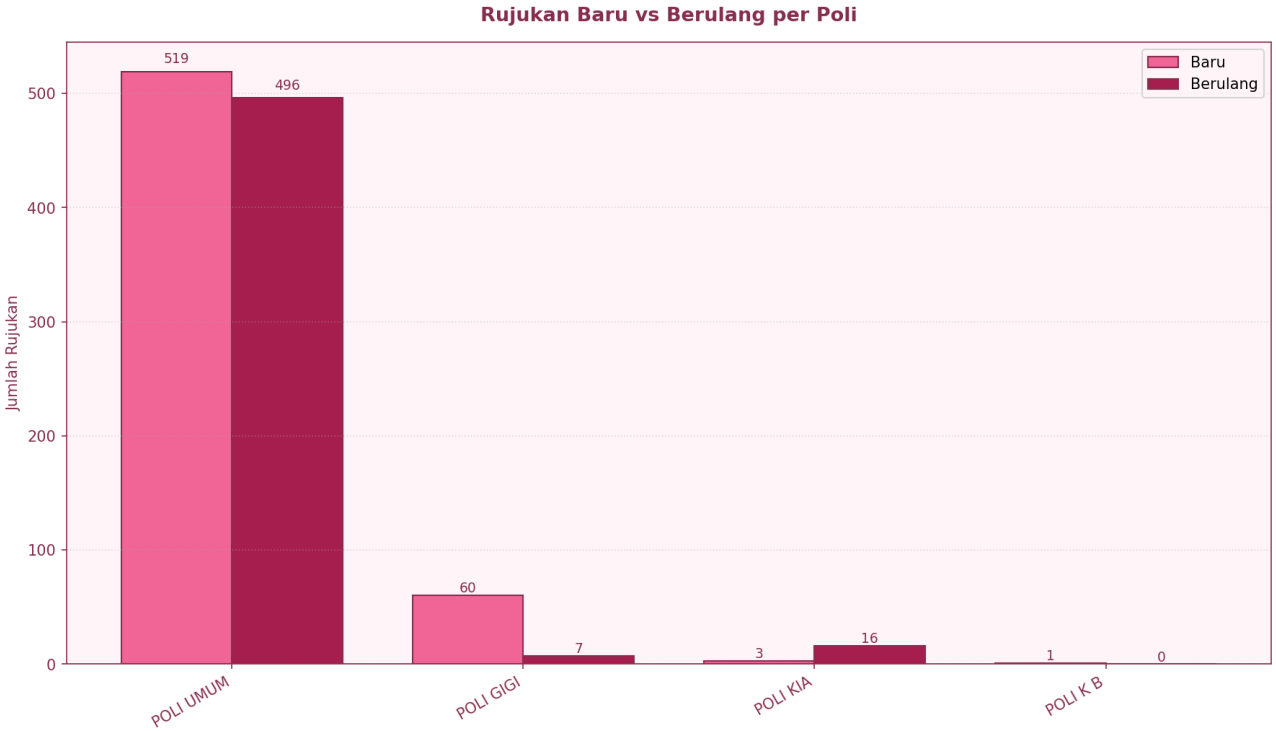
Dokter gigi & bidan:
- Total 15 dokter (gigi+bidan) = 75 rujukan (6,8%)
- Sesuai karakter layanan yang jarang merujuk

Implikasi Audit:
- Konsentrasi rujukan pada 5 dokter — bisa efisien atau berisiko
- dr. Eky dan dr. Yuni — perlu peer review
- Perbedaan % kunjungan vs % rujukan — indikator dokter "over-rujuk" atau "under-rujuk"



dr. Hesti Herlinawati

D.4. Rujukan Baru dan Berulang



1. Poli Umum — Seimbang (48,87%)
- 519 baru, 496 berulang — hampir 1:1
- Mencerminkan dualitas Poli Umum:
  - Separuh rujukan = kasus baru (penyakit akut, diagnosis pertama)
  - Separuh = pasien kronis yang kontrol rutin ke spesialis
- Ini area audit utama — 1.015 rujukan berasal dari Poli Umum

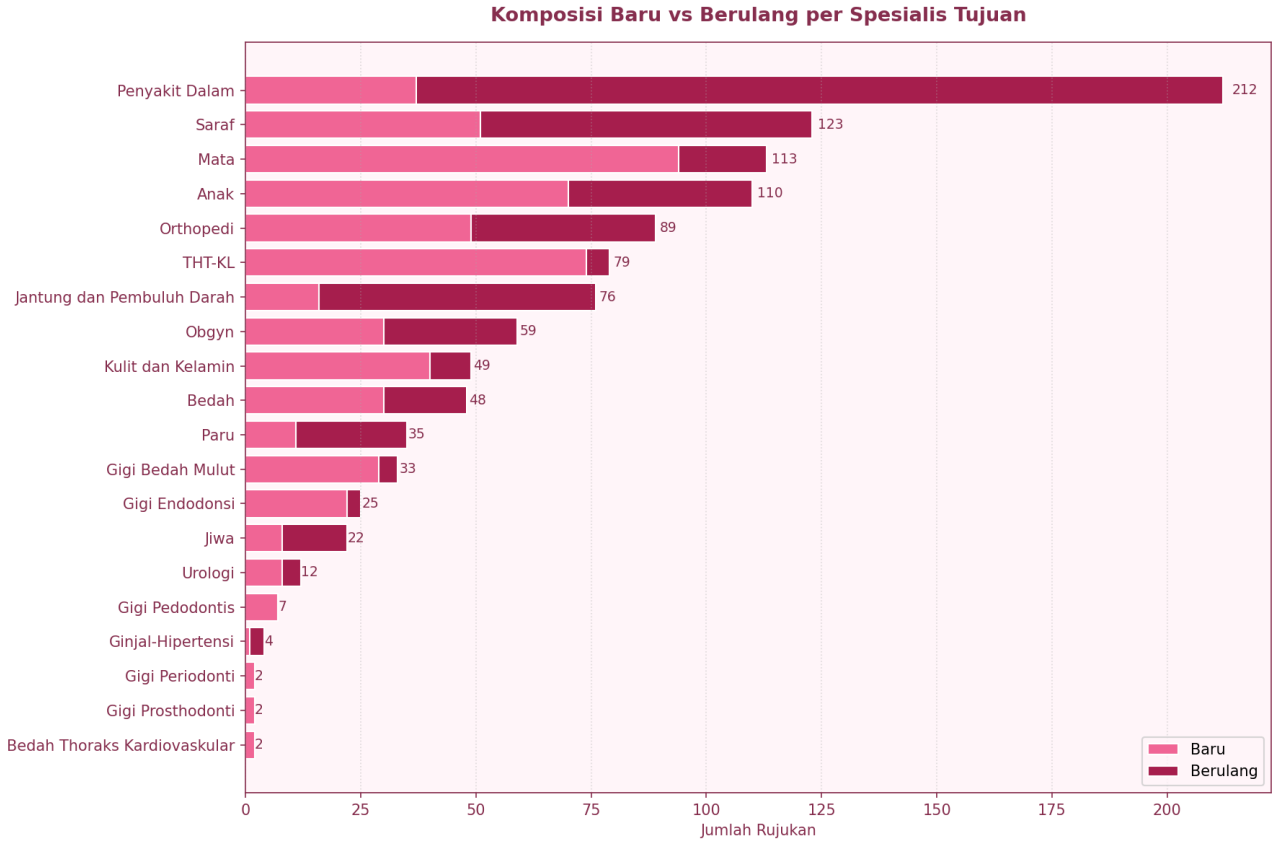
2. Poli KIA — Sangat Tinggi (84,21%)
- Hanya 3 baru, 16 berulang
- Hampir semua rujukan KIA adalah berulang
- Penyebab: ANC (Antenatal Care) rutin — ibu hamil dirujuk ke SpOG secara berkala (trimester 1, 2, 3) untuk USG, lab, konsultasi
- Wajar — ANC memang kunjungan berulang. Tidak perlu dioptimasi.

3. Poli Gigi — Sangat Rendah (10,45%)
- 60 baru, 7 berulang
- 90% rujukan gigi adalah kasus baru
- Karakter tindakan gigi: sekali tindakan selesai (ekstraksi, penambalan, PSA)
- Wajar — tidak perlu dioptimasi

Implikasi Audit:
- Poli Umum adalah tempat intervensi (1.015 dari 1.102 rujukan = 92%)
- Poli KIA & Gigi — pola wajar, tidak perlu diubah
- Target: Turunkan % berulang Poli Umum dari 48,87% → 40% dalam 6 bulan



dr. Hesti Herlinawati

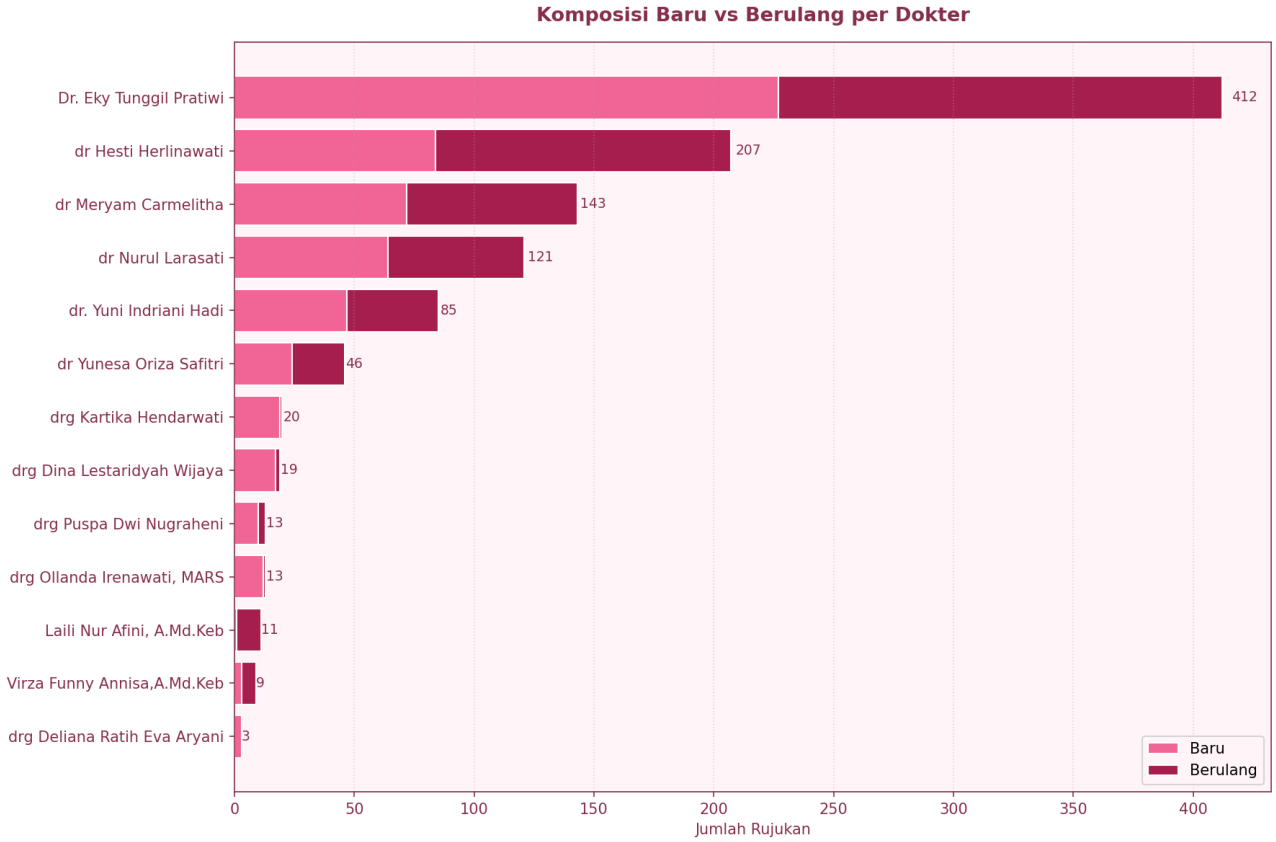


Keduanya volume besar (113 & 79 rujukan) tapi % berulang sangat rendah (16,81% & 6,33%). Mengapa?
- Mata: Rujukan didominasi H54.2 (low vision) — 57 kasus, mayoritas kasus baru yang baru terdeteksi. Juga katarak yang perlu operasi sekali.
- THT-KL: Rujukan untuk gangguan pendengaran, vertigo, sinusitis kronis — umumnya sekali konsultasi + terapi, tidak perlu balik.
- Kesimpulan: Spesialis akut/tindakan tidak perlu dioptimasi — rujukannya memang esensial.

Implikasi Audit:
- Fokus pada 6 spesialis kronis (PD, Jantung, Paru, Jiwa, Saraf, Ginjal)
- Penyakit Dalam = prioritas #1 (212 rujukan, 82,55% berulang)
- Jantung = prioritas #2 (76 rujukan, 78,95% berulang)
- Total beban dari 2 spesialis ini = 288 rujukan (26% dari total), dengan 235 berulang
- Kalau bisa dipangkas 30% dari 235 = ~70 rujukan berulang per periode



dr. Hesti Herlinawati

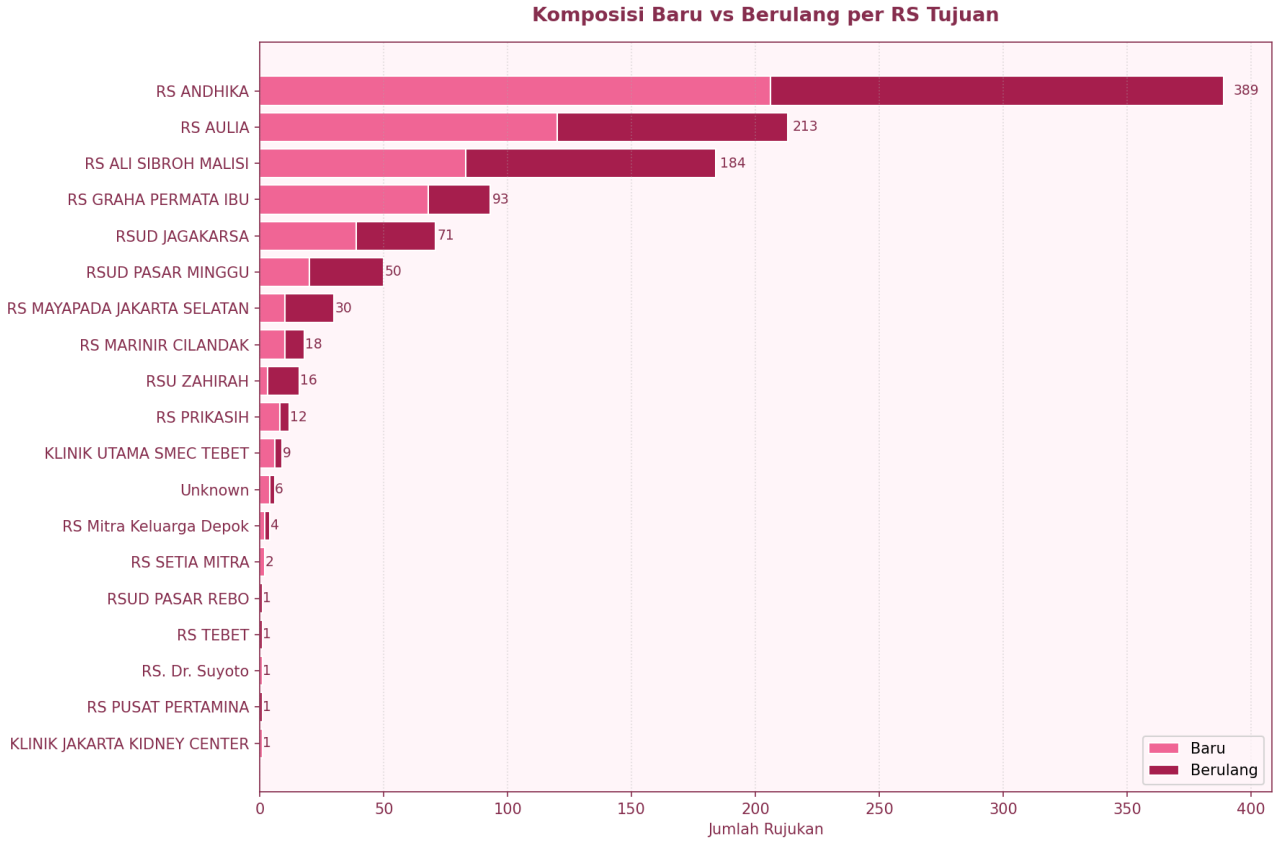


Interpretasi: Dokter dengan % berulang tinggi mungkin menangani lebih banyak pasien kronis — bukan berarti mereka "salah rujuk". Perlu analisis case mix per dokter untuk konfirmasi.
- dr Hesti (59,42%) — tertinggi di dokter umum. Dari 207 rujukan, 123 berulang. Perlu di-review: apakah case mix beliau memang banyak kronis, atau threshold rujuk beliau lebih rendah?
- dr. Eky (44,90%) — paling banyak rujukan (412), tapi % berulang sedang. Artinya: separuh lebih rujukan beliau adalah kasus baru. Volume tinggi tapi tidak "over-rujuk kronis".
- dr. Yuni (44,71%) — % berulang rendah, tapi rate tinggi (22,67%). Artinya: beliau banyak merujuk kasus baru.

Implikasi Audit:
- dr Hesti dan dr Meryam — % berulang tinggi, perlu di-review kasus per kasus
- Dr. Eky — volume besar tapi % berulang sedang, relatif seimbang
- Bidan — pola wajar (ANC)
- Perlu case mix per dokter untuk interpretasi yang benar



dr. Hesti Herlinawati

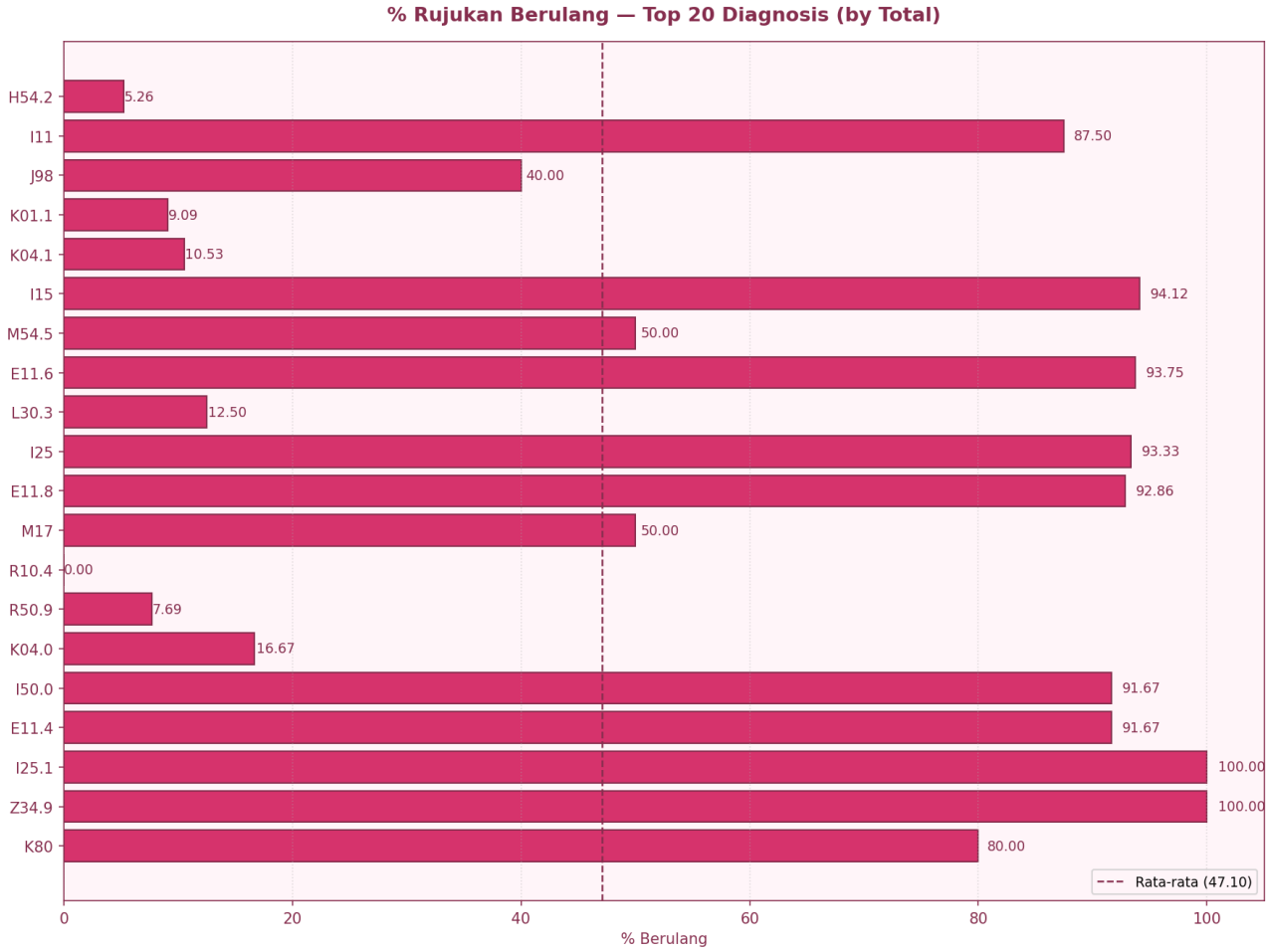


RSU Zahirah (81,25% berulang) — meski hanya 16 rujukan, pola ekstrem ini menarik. Kalau ini untuk pasien dialisis rutin (CKD stage 5), maka:
- Rujukan ini esensial (pasien harus dialisis rutin)
- Tidak bisa dioptimasi — pasien memang butuh RS
- Rekomendasi: buat sistem rujukan kolektif atau jadwal bersama untuk mengurangi beban administratif

Implikasi Audit:
- Kemitraan dengan 3 RS utama (Andhika, Aulia, Ali Sibroh) — fokus optimasi kronis
- RS Zahirah — RS rujukan kronis khusus. Perlu pendekatan berbeda (jadwal kolektif)
- RS Graha Permata Ibu — mayoritas kasus baru. Kemitraan untuk obgyn/anak
- 5 RS dengan 1 rujukan (Tebet, Pertamina, Pasar Rebo, Dr. Suyoto, Kidney Center) — analisis tidak bermakna, sampel terlalu kecil



dr. Hesti Herlinawati



Semua diagnosis kronis dengan n≥10 memiliki % berulang ≥90%:
- I25.1, I15, E11.6, I25, E11.8, I50.0, E11.4, N18.5 — semuanya jantung, DM, hipertensi, ginjal
- Artinya: begitu pasien didiagnosis kronis dan dirujuk, hampir pasti akan dirujuk lagi

Implikasi: Ini bukan "salah rujuk" — ini sifat alami penyakit kronis yang butuh kontrol rutin. Tapi:
- Pertanyaan audit: Apakah semua kontrol ini harus di spesialis? Atau bisa dibagi: kontrol rutin di FKTP, evaluasi berkala di spesialis?
- Model yang bisa dipertimbangkan: Shared care — pasien kontrol di FKTP 2×, di spesialis 1× per 3 bulan

Diagnosis akut dengan n≥6 semua memiliki % berulang 0%:
- R10.4, H93.1, L98, R07.4, H02.9 — nyeri, tinnitus, kelainan kulit, kelopak mata
- Artinya: rujukan untuk diagnosis ini selalu kasus baru
- Wajar — setelah ditangani, pasien tidak perlu balik lagi

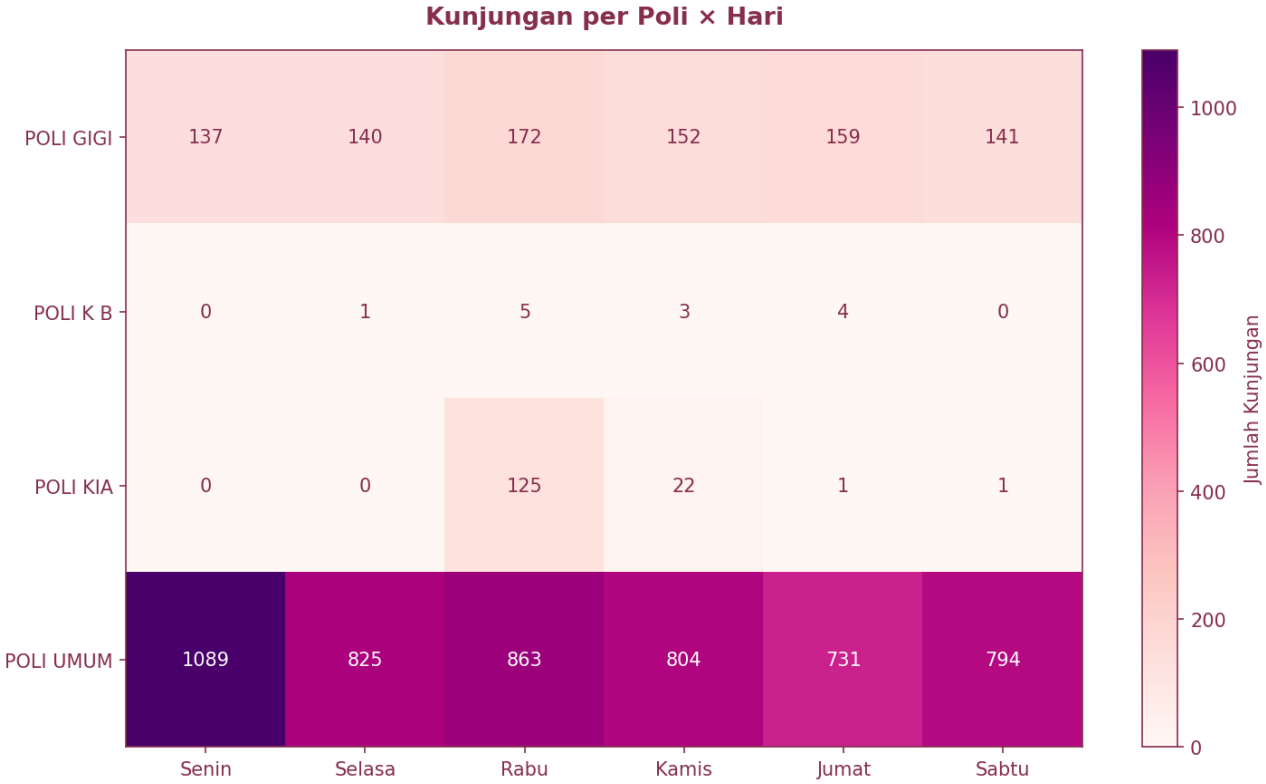
- Z34.9 (Kehamilan normal) — 100% berulang (10 dari 10). Ini ANC rutin — ibu hamil dirujuk 3-4× selama kehamilan. Wajar.
- K80 (Kolelitiasis) — 80% berulang. Menarik: batu empedu butuh tindakan bedah yang mungkin dijadwalkan beberapa kali konsultasi. Wajar.

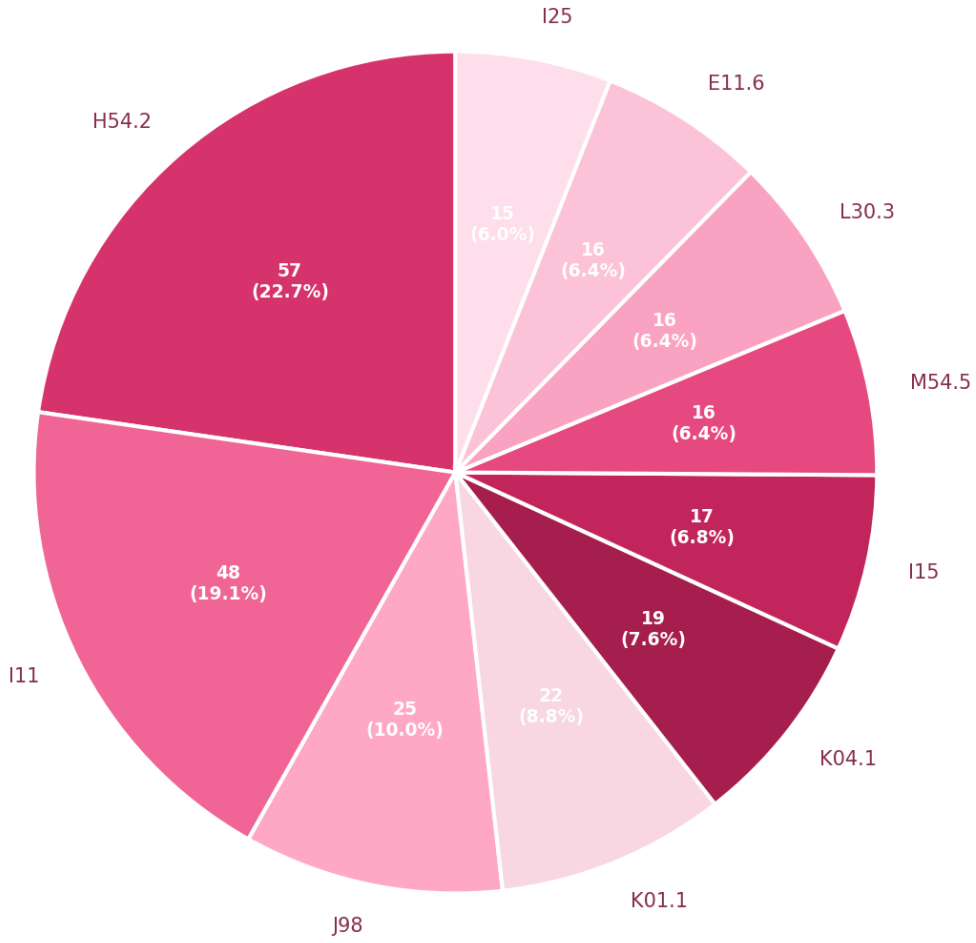
Implikasi Audit:
- Diagnosis kronis (I25, I15, E11.6, I50.0, N18.5) = beban utama rujukan berulang
- Fokus pada 4 kelompok: jantung (I25, I25.1, I50.0), hipertensi (I15), DM (E11.), ginjal (N18.5)
- Diagnosis akut tidak perlu perhatian — pola wajar



dr. Hesti Herlinawati

D.5. LAIN-LAIN







dr. Hesti Herlinawati

Kesimpulan Awal

Rate rujukan CAMAD 17,86% tidak alarm, tapi tidak ideal. Masalah sebenarnya bukan angka rate itu sendiri, melainkan 47,1% rujukan berulang yang terkonsentrasi di Penyakit Dalam (82,55%) dan Jantung (78,95%). Fokus audit ke depan bukan "turunkan rate", tapi "optimasi rujukan kronis" melalui shared care, Prolanis intensif, dan standardisasi kriteria rujukan. Kekuatan FKTP dalam menangani ISPA dan penyakit menular harus dipertahankan. Target realistis: turunkan rujukan berulang dari 47% → 40% dalam 6 bulan, dengan dampak ~78 rujukan dihemat per kuartal.



dr. Hesti Herlinawati

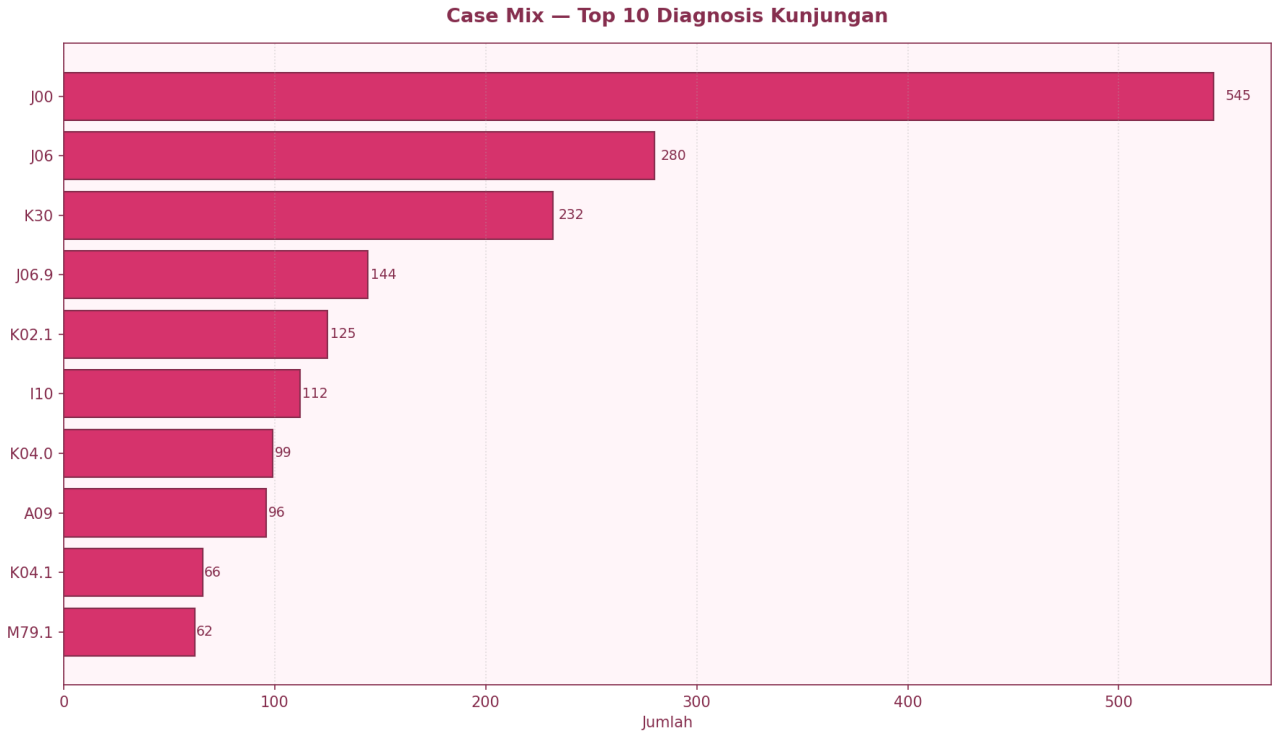
E. Analisa Data Klinik Mutiara Sehat Cinere (KMSC)

Periode analisis: 1 Juli – 30 September 2026. Total 3.837 kunjungan, 2.116 pasien unik, 649 rujukan. Kapitasi KMSC 5.000 peserta (perkiraan).

E.1. Profil Kunjungan (Case Mix)

Kode	Diagnosa	Jumlah	%
J00	Nasofaringitis akut	545	14,20
J06	ISPA	280	7,30
K30	Dispepsia	232	6,05
J06.9	ISPA akut	144	3,75
K02.1	Karies dentin	125	3,26
I10	Hipertensi esensial	112	2,92
K04.0	Pulpitis	99	2,58
A09	Diare	96	2,50
K04	Nekrosis pulpa	66	1,72
M79.1	Myalgia	62	1,62
TOTAL		1.761	45,90

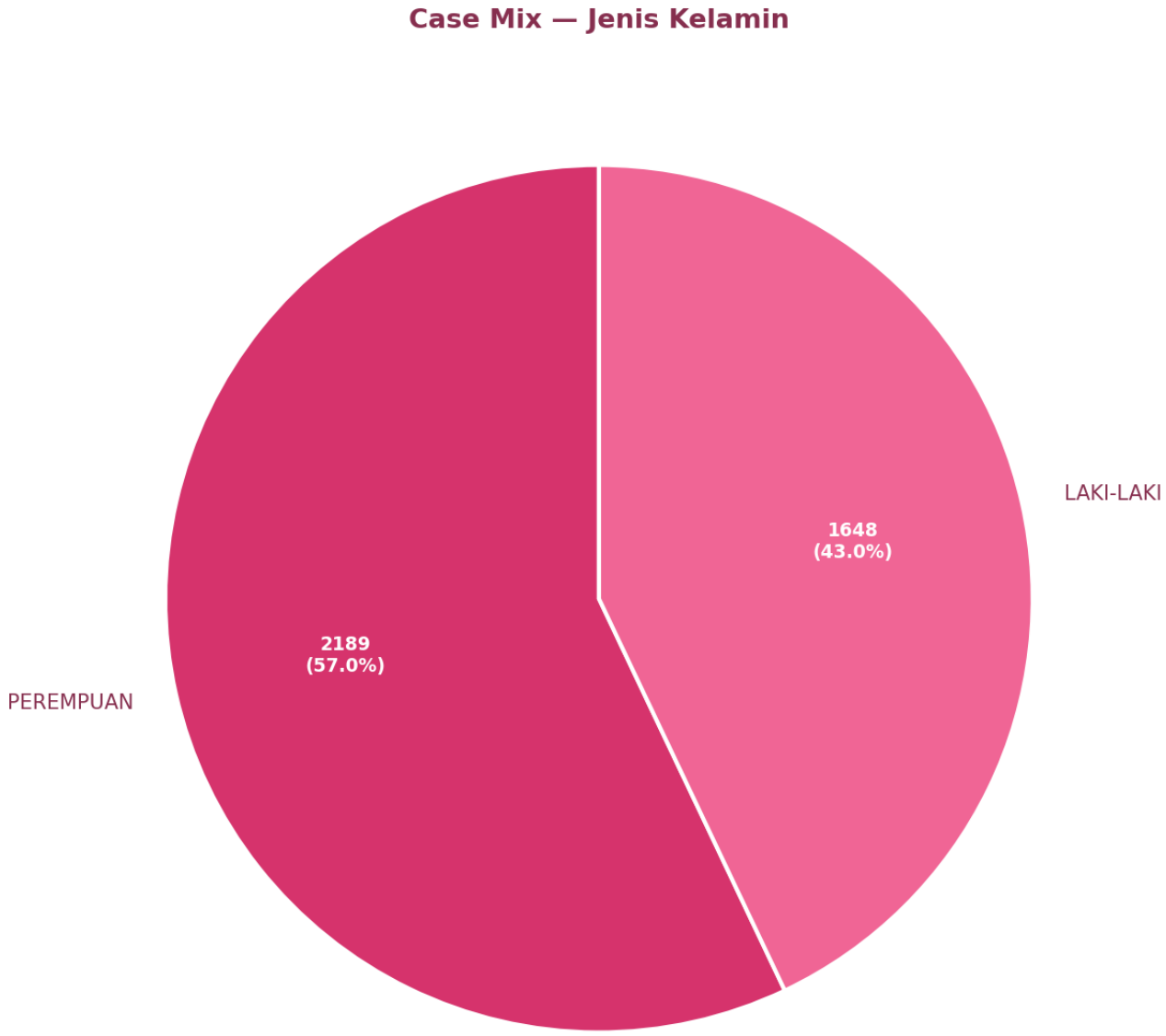
10 diagnosis terbanyak menyumbang 45,90% dari seluruh kunjungan (1.761 dari 3.837). Karakteristik: didominasi penyakit akut menular (ISPA, diare) dan penyakit gigi. Hipertensi (I10) menjadi satu-satunya penyakit kronis di top 10.



Case Mix FKTP di dominasi penyakit akut dimana, proporsi kronis 2,92 % di top 10. yang mengindetensikan kronis berat sudah terfilter ke spesialis



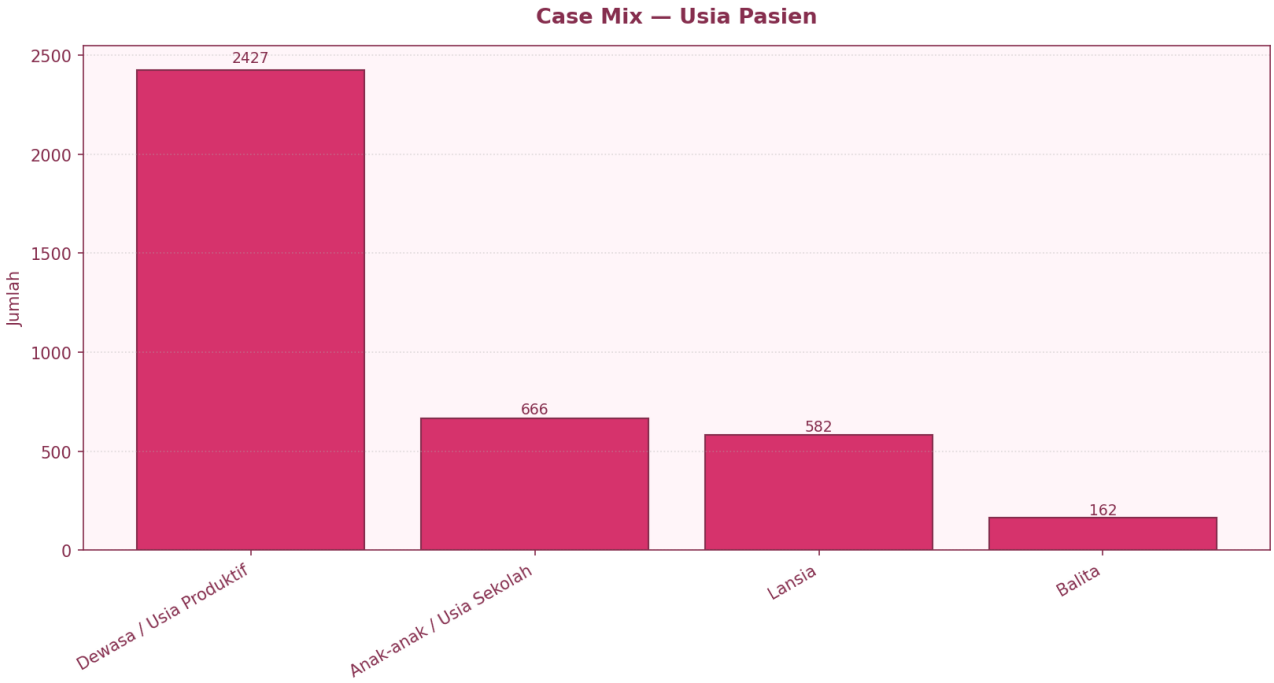
dr. Hesti Herlinawati



Perempuan dominan — selisih 14,10 poin dari laki-laki. Ini khas FKTP karena:
- Poli KIA (40 kunjungan) hampir seluruhnya perempuan (ibu hamil, KB, anak), ibu rumah tangga
- lebih banyak waktu untuk berobat di jam kerja
- angka harapan hidup perempuan lebih tinggi sehingga lansia perempuan lebih banyak, dan
- skrining/kontrol rutin lebih umum pada perempuan (kehamilan, KB, kanker serviks).



dr. Hesti Herlinawati

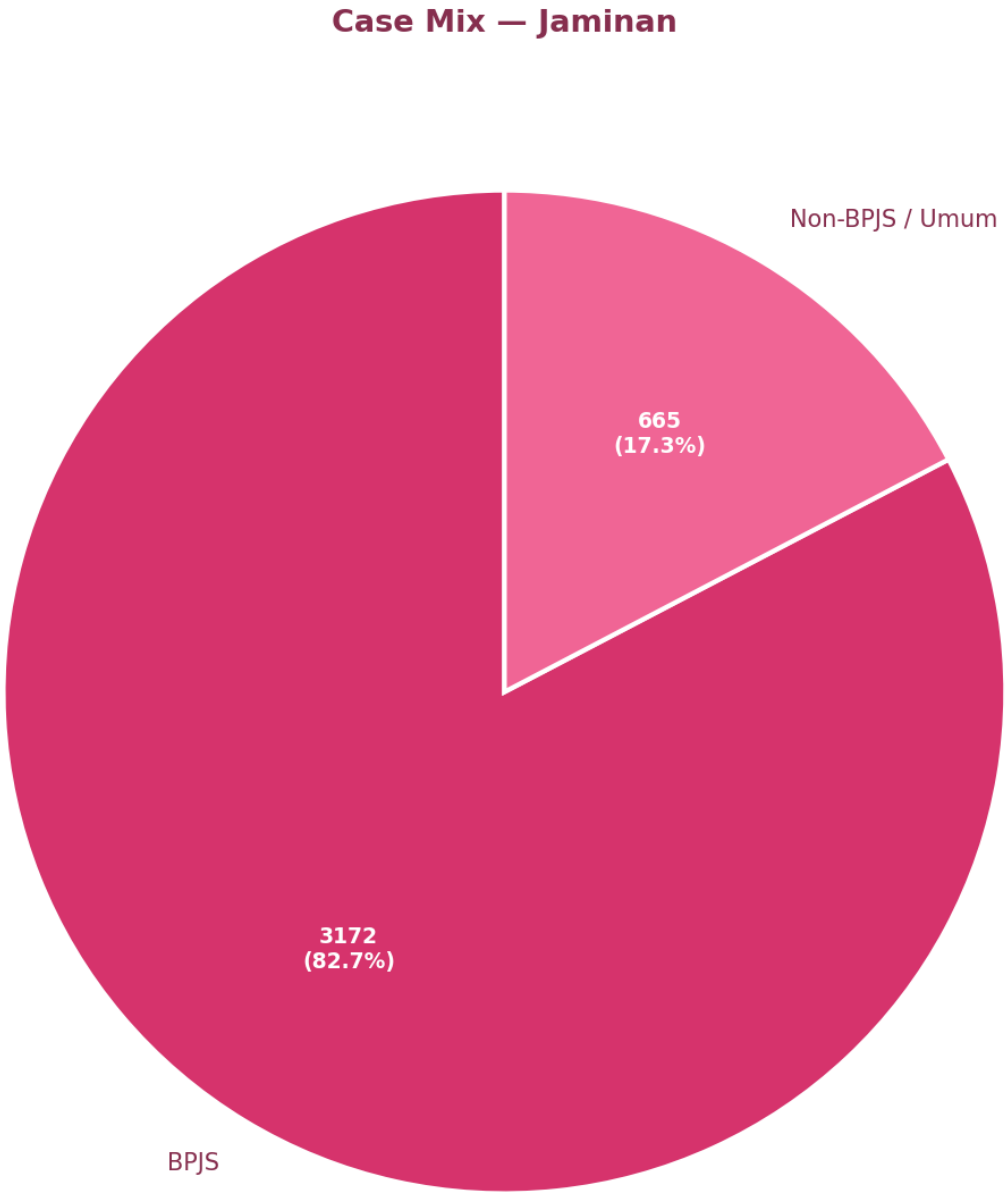


Interpretasi: Komposisi usia ini menempatkan dewasa produktif sebagai kelompok terbesar (63,25%), disusul anak sekolah (17,36%) dan lansia (15,17%). Lansia minoritas tapi paling sering dirujuk, karena beban penyakit kronis dan degeneratif. Anak-anak relatif lebih mudah ditangani di FKTP.





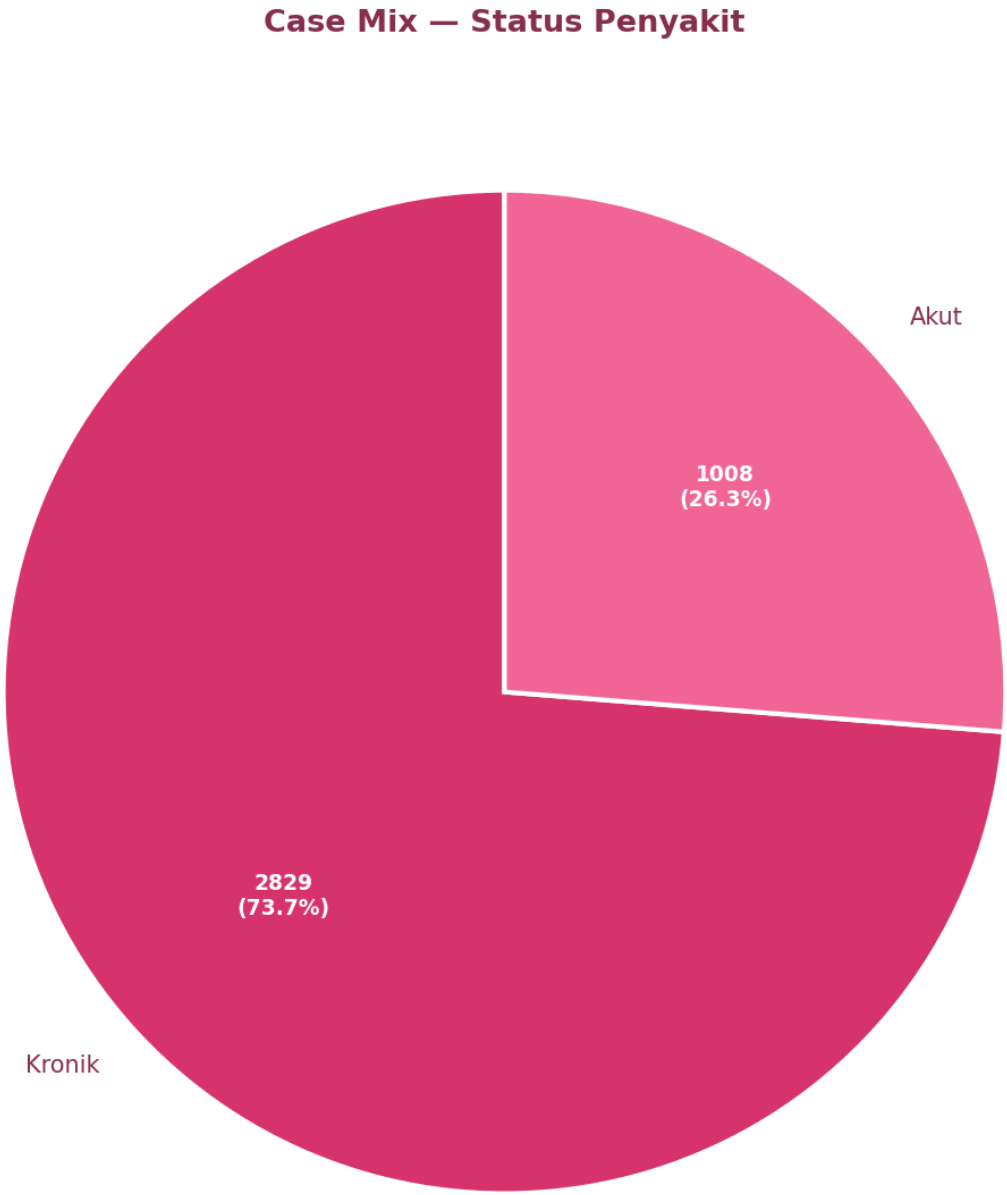
dr. Hesti Herlinawati



BPJS dominan — mencerminkan bahwa klinik ini adalah FKTP mitra BPJS dengan 5.000 peserta terdaftar. Hampir 1 dari 6 pasien adalah umum/bayar sendiri. Implikasi: Ketergantungan tinggi pada BPJS — kebijakan BPJS (tarif, rujukan berjenjang) akan langsung berdampak pada operasional klinik, namun proporsi Non-BPJS yang cukup besar (17,33%) memberi ruang layanan mandiri.



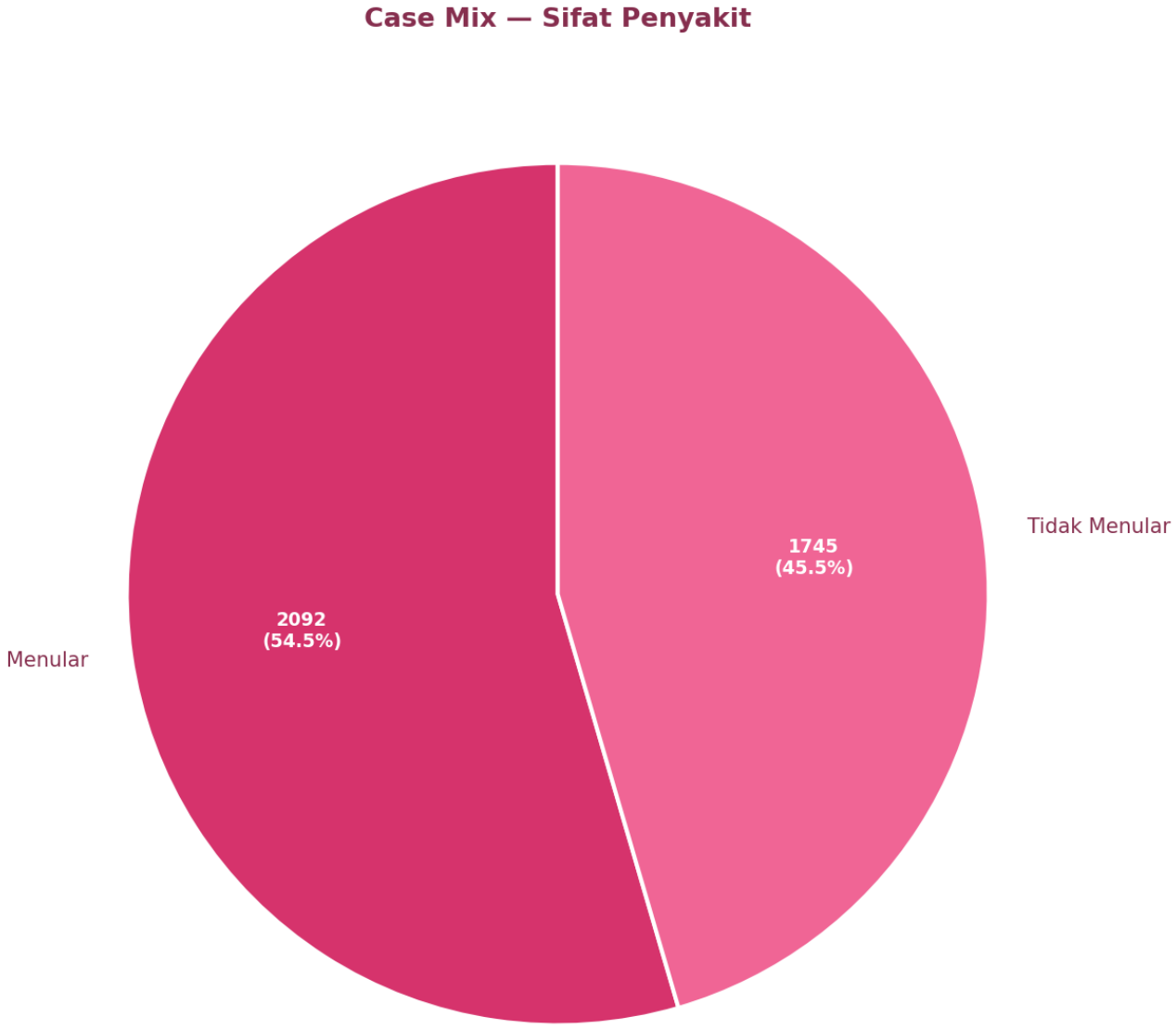
dr. Hesti Herlinawati



Karakteristik: Kronik mendominasi kunjungan (hampir tiga per empat). Namun hipertensi esensial (I10) hanya 2,92% dari kunjungan — beban kronik tersebar di banyak kode diagnosis lain (E11, I11, I15, I25, dan seterusnya) yang tidak masuk top 10 kunjungan.



dr. Hesti Herlinawati

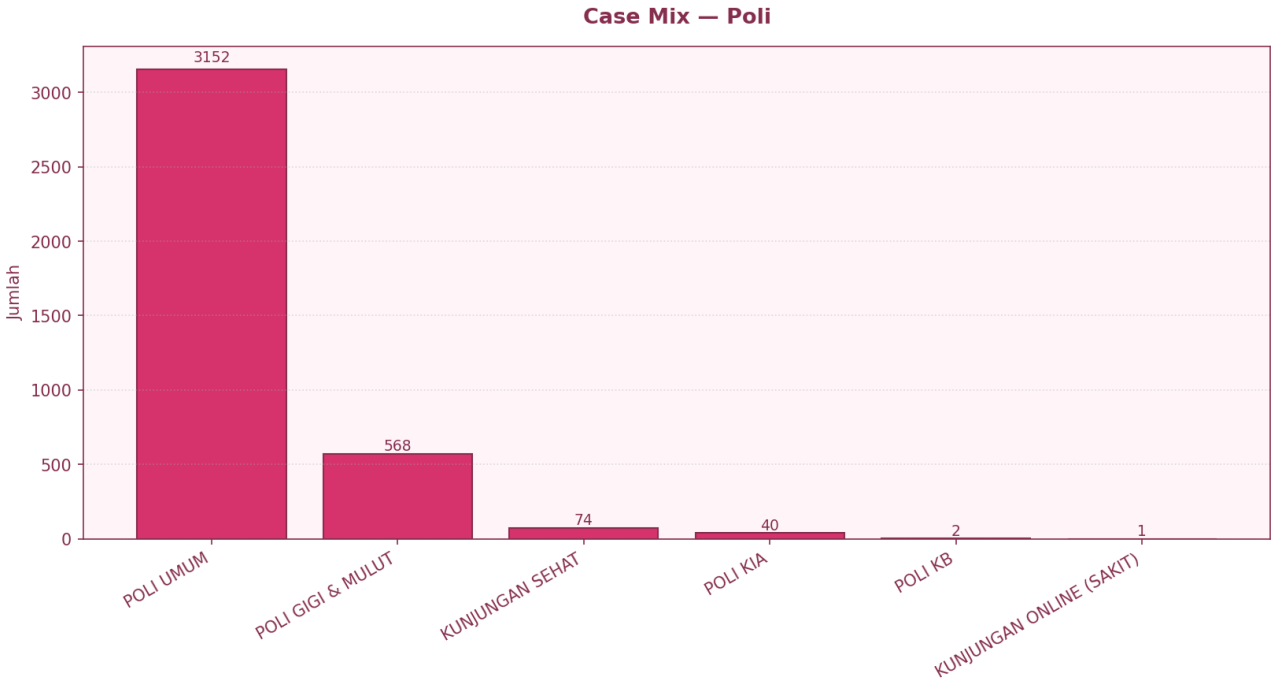


Menular 2.092 (54,52%) dan tidak menular 1.745 (45,48%).

Menular (2.092): ISPA (J00, J06, J06.9), diare (A09), TBC, infeksi kulit, dll.
Tidak Menular (1.745): Hipertensi (I10), DM (E11), penyakit gigi (K04, K02), dispepsia (K30), gangguan muskuloskeletal (M79), dll.



dr. Hesti Herlinawati



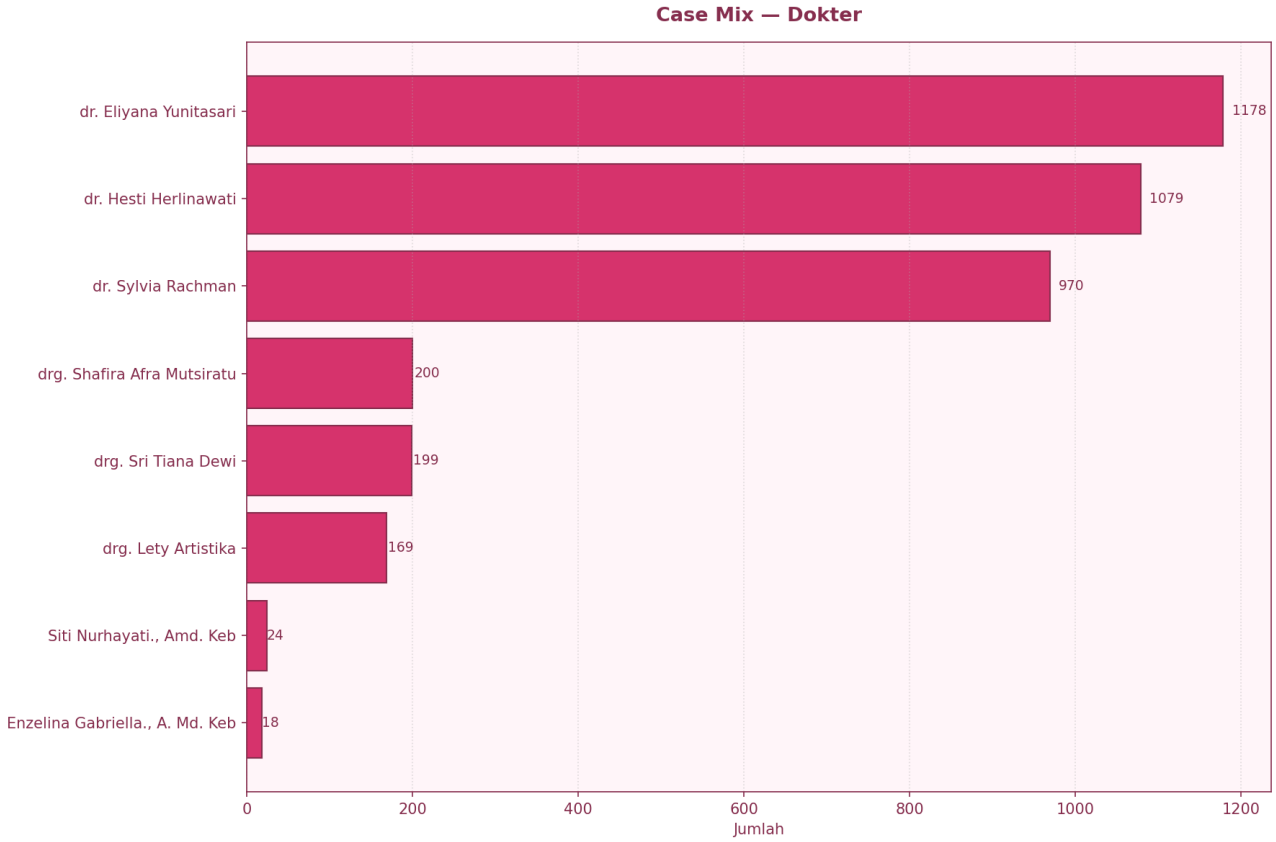
Poli Umum sangat dominan (82,15%) — hampir 5 dari 6 kunjungan. Ini tipikal FKTP: pasien datang dengan keluhan umum (demam, batuk, pusing, sakit perut), tidak perlu spesialis, cukup dokter umum, termasuk follow-up kronis (hipertensi, DM).

Poli Gigi & Mulut 14,80% — signifikan untuk FKTP. Ini mencerminkan ketersediaan dokter gigi di klinik, permintaan tinggi untuk perawatan gigi (karies, pulpitis), dan BPJS menanggung perawatan gigi dasar.

Poli KIA & KB kecil (1,04% dan 0,05%) — meski kecil, punya karakteristik khusus. Kunjungan Sehat (74) dan Kunjungan Online (1) adalah kategori tersendiri dalam sistem KMSC.



dr. Hesti Herlinawati



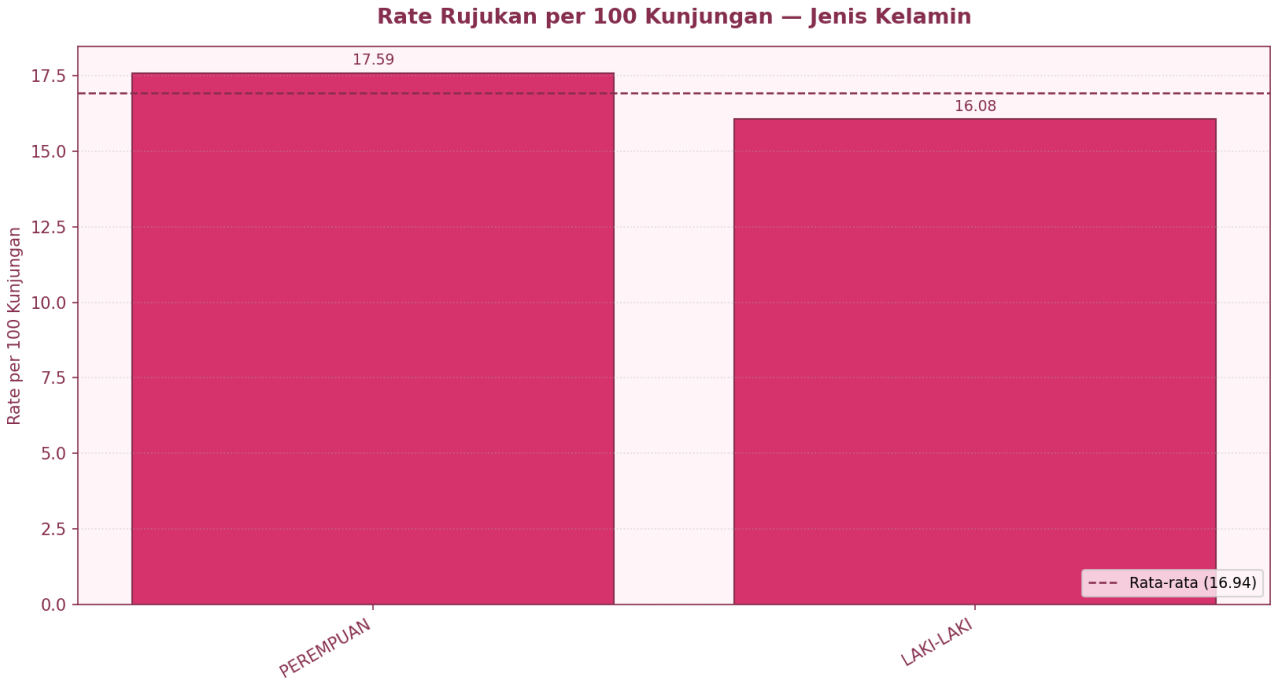
Konsentrasi tinggi: 3 dokter teratas menangani 84,10% kunjungan. Ini bisa jadi
- efisien — dokter senior dengan jam praktik lebih banyak — atau
- berisiko — ketergantungan pada individu tertentu; kalau berhalangan, kapasitas turun drastis.

Pemisahan jelas dokter umum vs dokter gigi:
- Dokter umum (Eliyana, Hesti, Sylvia): total 3.227 kunjungan = 84,10% (sesuai Poli Umum)
- Dokter gigi (Shafira, Sri Tiana, Lety): total 568 kunjungan = 14,80% (sesuai Poli Gigi & Mulut)
- Bidan (Siti Nurhayati, Enzelina): total 42 kunjungan = 1,10% (Poli KIA & KB)



dr. Hesti Herlinawati

E.2. Rate Rujukan



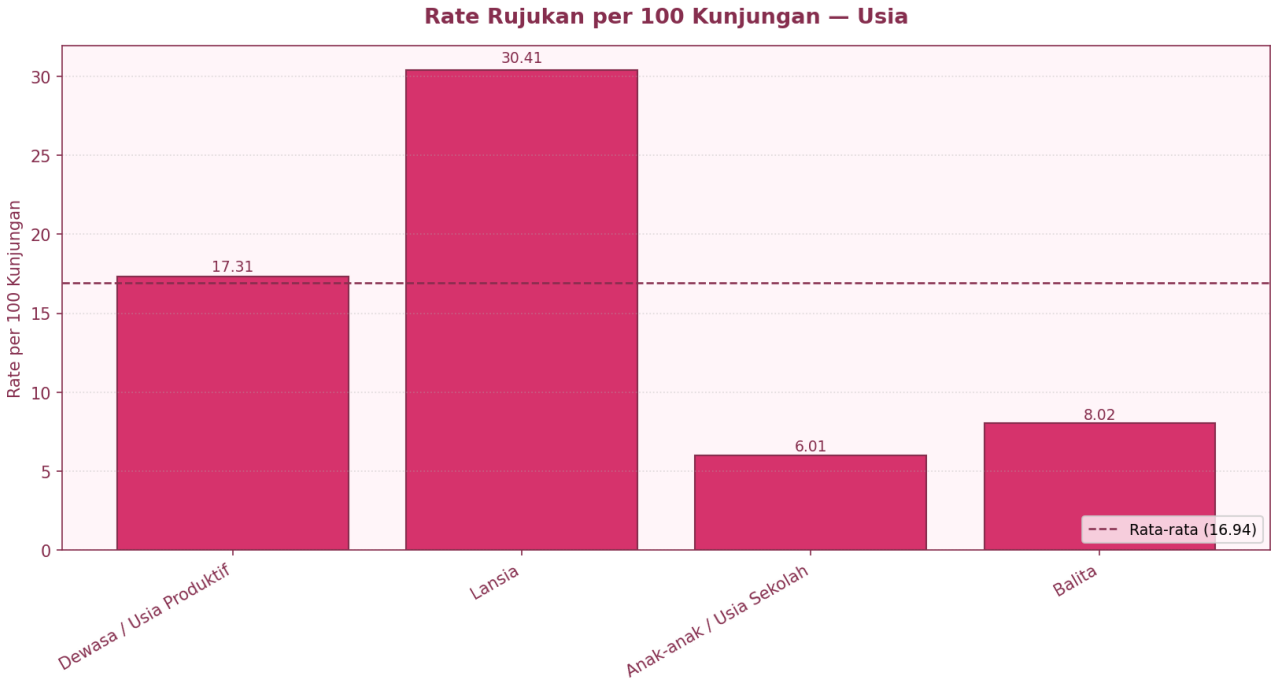
Perempuan 17,59 per 100 kunjungan (385 rujukan dari 2.189 kunjungan), laki-laki 16,08 (265 dari 1.648). Perempuan memiliki rate rujukan 1,51 poin lebih tinggi dari laki-laki. Meski selisihnya terlihat kecil, dalam konteks 3.837 kunjungan, ini berarti ~54 rujukan ekstra dari perempuan per periode.

Faktor penyebab:
- Poli KIA — ibu hamil yang butuh ANC lengkap (USG, lab) dirujuk rutin ke SpOG
- Lansia perempuan lebih banyak — karena angka harapan hidup lebih tinggi, beban penyakit kronis lebih besar
- Skrining & deteksi dini — perempuan lebih proaktif memeriksakan diri, sehingga lebih banyak kasus yang terdeteksi dan butuh rujukan lanjutan

Implikasi Audit:
Perbedaan ini wajar secara klinis. Yang perlu diaudit adalah apakah rujukan ANC (yang jadi penyumbang utama) memang esensial atau bisa dikurangi dengan peningkatan kapasitas USG/lab di klinik.



dr. Hesti Herlinawati



Lansia rate rujukan 30,41% — 1,80× rata-rata. Ini adalah temuan paling signifikan di seluruh analisis rate.

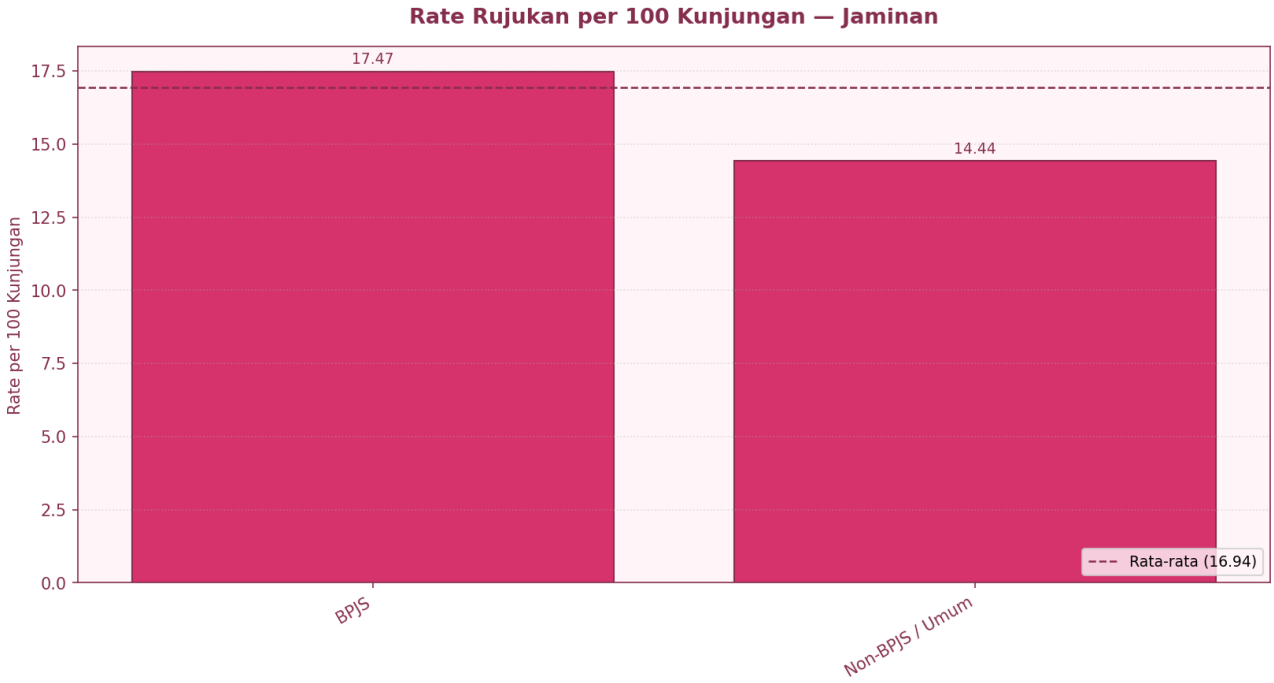
Mengapa lansia jauh lebih tinggi?
- Beban penyakit kronis & degeneratif — hipertensi, DM, PJK, gagal jantung, osteoarthritis
- Polifarmasi & komplikasi — butuh monitoring lab rutin, EKG, konsultasi spesialis
- Fragilitas — gejala ringan pada lansia bisa jadi pertama penyakit serius, threshold rujuk lebih rendah
- Keterbatasan diagnostik FKTP — banyak kondisi lansia butuh pemeriksaan penunjang yang tidak tersedia

Anak-anak & Balita — rate terendah (6,01% dan 8,02%).
- Anak-anak umumnya: penyakit akut self-limiting (ISPA, diare, demam)
- respons cepat terhadap terapi simpel
- tidak banyak komplikasi kronis.

Implikasi Audit:
Lansia adalah target utama optimasi. Setiap penurunan 5 poin persen rate rujukan lansia akan menghemat ~29 rujukan per periode. Strategi:
- Program Prolanis intensif untuk lansia kronis
- Skrining rutin di Posyandu Lansia
- Kunjungan rumah untuk pasien yang tidak kontrol
- Pelatihan dokter FKTP untuk tata laksana kronis



dr. Hesti Herlinawati



BPJS 17,47% vs Non-BPJS 14,44% — beda 3,03 poin. Ini bukan berarti pasien BPJS "lebih sakit", tapi mencerminkan perbedaan struktural sistem:

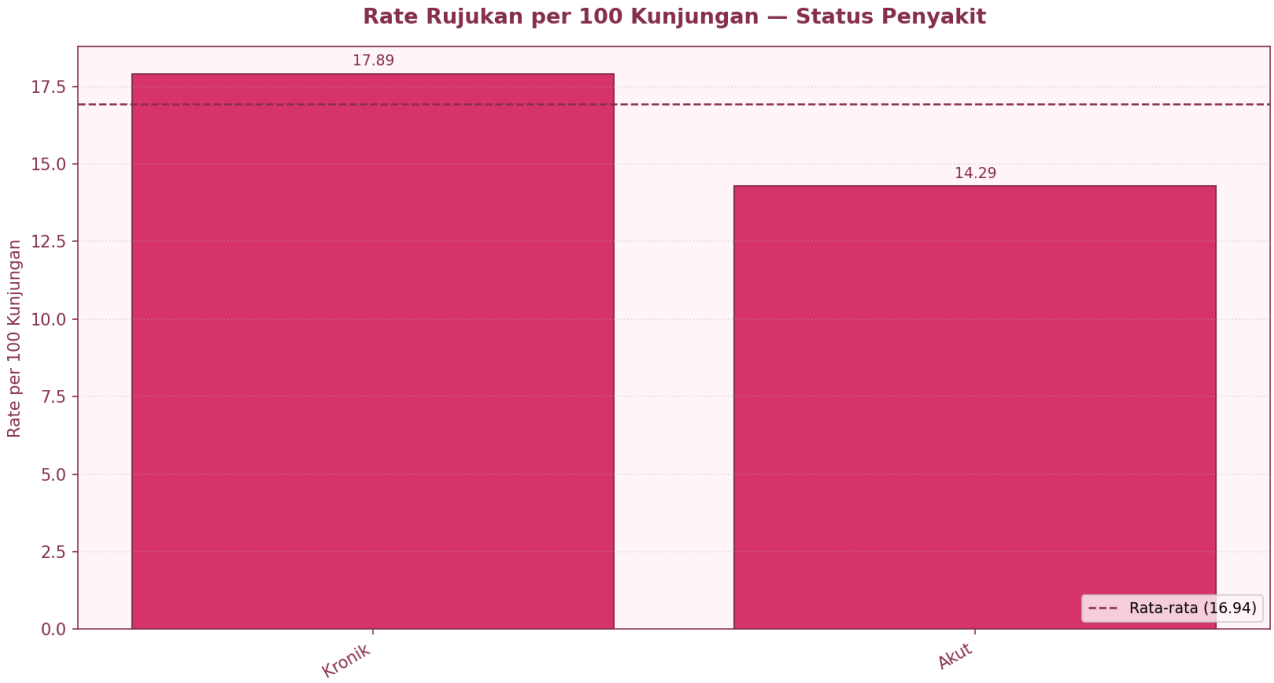
- Rujukan berjenjang BPJS — pasien BPJS wajib melalui FKTP untuk akses ke spesialis. Jadi semua rujukan formal tercatat di klinik.
- Pasien Non-BPJS — bebas langsung ke dokter spesialis/RS tanpa lewat FKTP. Rujukan yang tercatat di klinik hanya sebagian kecil (kasus yang kebetulan datang ke klinik dulu).
- Perbedaan case mix — pasien umum cenderung:
  - kasus ringan (batuk pilek, kontrol ringan) yang tidak butuh rujukan, ATAU
  - kasus kompleks yang sudah punya langganan dokter spesialis (tidak lewat FKTP).

Implikasi Audit:

- Rate rujukan yang relevan untuk audit internal BPJS adalah 17,47% (mode BPJS), bukan 16,91% (all)
- Tingginya rate BPJS bukan masalah — ini konsekuensi desain sistem rujukan berjenjang
- Yang perlu diaudit: apakah rujukan BPJS efisien? Apakah ada rujukan yang seharusnya bisa ditangani FKTP?



dr. Hesti Herlinawati



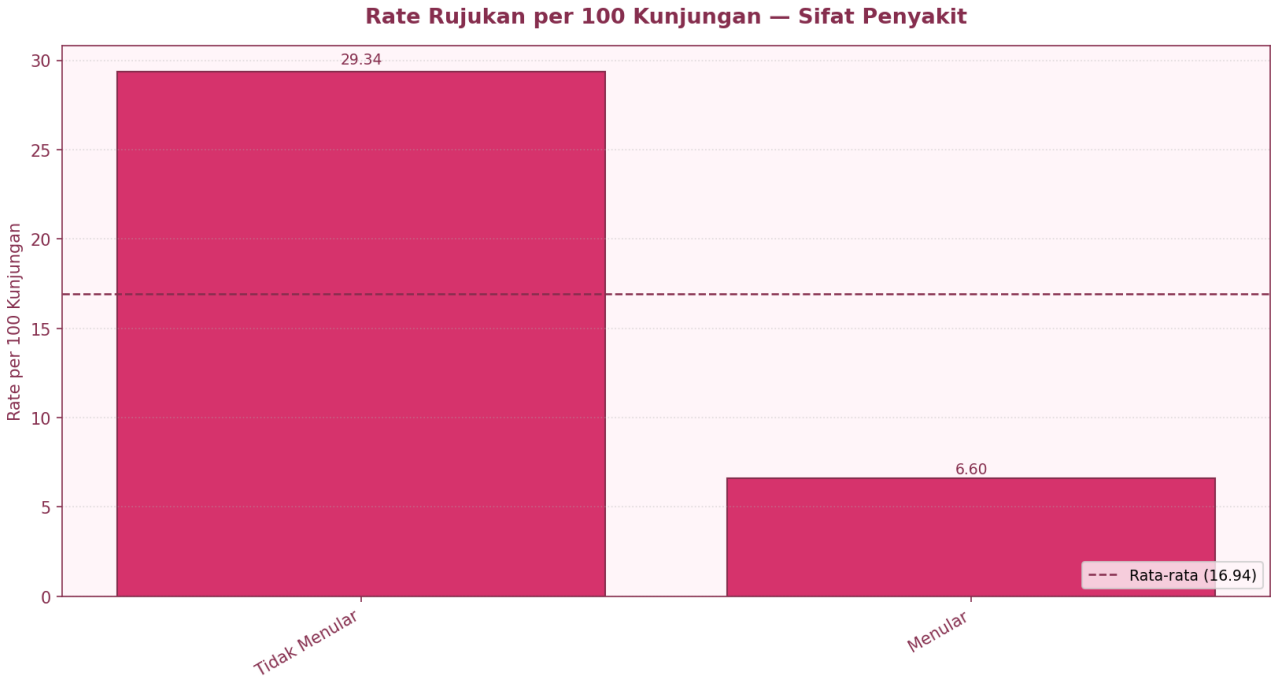
Penyakit kronis rate 17,89% — 1,25× penyakit akut (14,29%). Kronik menyumbang 506 dari 650 rujukan (77,8%).

Mengapa kronis jauh lebih tinggi?
- Butuh pemeriksaan penunjang berkala — HbA1c, profil lipid, EKG, ekokardiografi, funduskopi
- Komplikasi multi-organ — DM → nefropati, retinopati, neuropati; hipertensi → jantung, ginjal, stroke
- Manajemen kompleks — titrasi obat, evaluasi respons terapi
- Keterbatasan FKTP — tidak semua alat penunjang tersedia

Implikasi Audit:
- 2.829 kunjungan kronis → 506 rujukan. Kalau bisa turunkan rate ke 15%, hemat ~80 rujukan per periode
- Diagnosis kronis penyumbang utama: I11, I15, E11.6, I25, E11.8, I50.0 (semua di top 10 diagnosis rujukan)
- Strategi: Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang lebih intensif



dr. Hesti Herlinawati



Kontras ekstrem: PTM 29,34% vs Menular 6,60% — beda 22,74 poin.

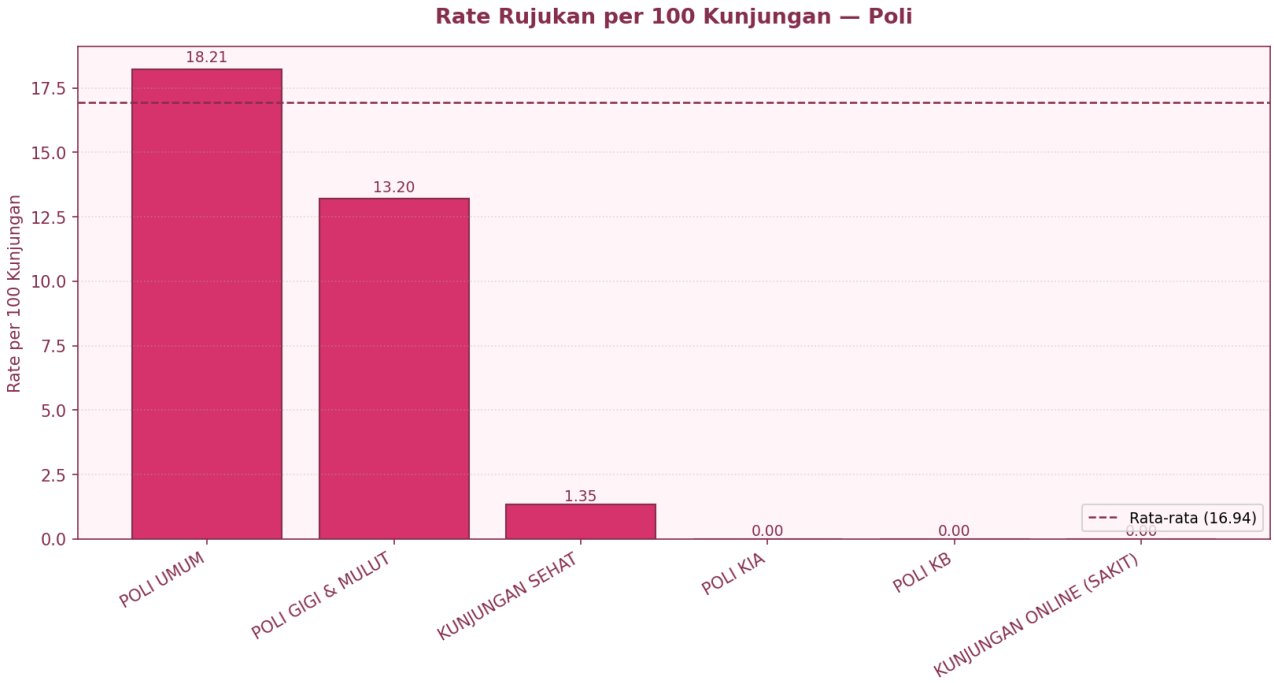
Temuan kunci:
- Penyakit menular jarang dirujuk (6,60%) — FKTP sangat mampu menangani ISPA, diare, infeksi kulit, dll.
- Penyakit tidak menular sangat sering dirujuk (29,34%) — PTM adalah penyumbang utama beban rujukan

Paradoks yang menarik: Penyakit menular sering dianggap lebih berbahaya (wabah, pandemi), tapi dalam konteks FKTP, justru PTM yang menjadi beban rujukan. Ini karena:
- Penyakit menular akut → sembuh, tidak butuh spesialis
- PTM kronis → manajemen jangka panjang, sering butuh spesialis untuk komplikasi

Implikasi Audit:
- 138 rujukan menular dari 2.092 kunjungan — hampir sempurna. Ini kekuatan FKTP yang harus dipertahankan.
- 512 rujukan tidak menular — 78,8% dari total rujukan. Fokus audit harus di sini.



dr. Hesti Herlinawati



Poli Umum rate tertinggi (18,21%) — konsisten dengan perannya sebagai gerbang utama:
- menangani semua keluhan umum
- menerima pasien kronis rujukan balik dari spesialis
- melakukan rujukan ketika butuh spesialis.

Poli Gigi & Mulut rate 13,20% — karakteristik rujukan gigi:
- umumnya sekali tindakan (ekstraksi, penambalan, endodontik)
- tindakan selesai → tidak perlu rujukan lanjutan
- yang dirujuk: kasus yang butuh spesialis (bedah mulut, endodonsi).

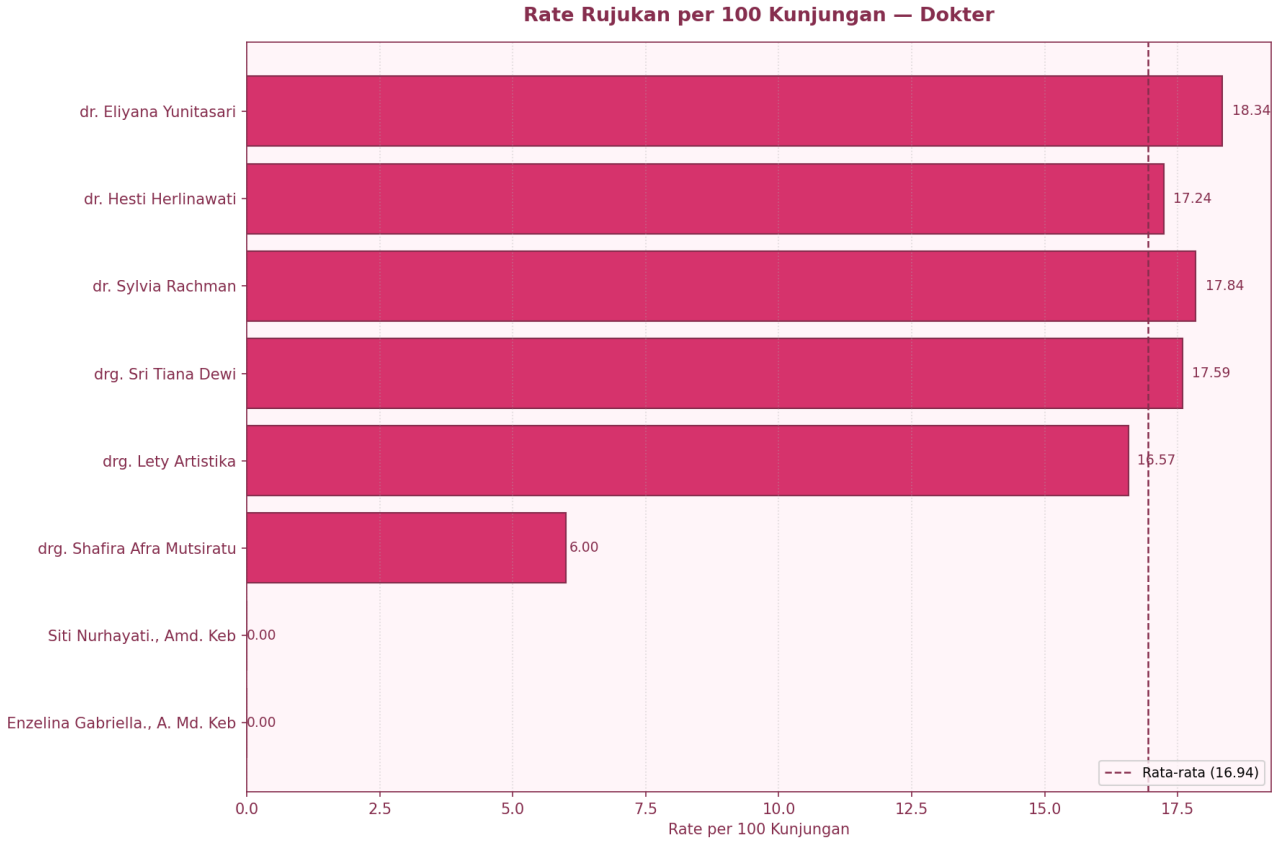
Kunjungan Sehat rate 1,35% — dari 74 kunjungan, hanya 1 yang dirujuk:
- Hampir seluruh kunjungan sehat tidak memerlukan rujukan
- Wajar — kunjungan sehat bersifat skrining/kontrol tanpa keluhan, sehingga tidak ada indikasi rujukan

Poli KIA (0%) — di KMSC tidak ada rujukan dari Poli KIA.

Implikasi Audit:
- Poli Umum adalah tempat audit utama — 574 dari 649 rujukan (88,4%) berasal dari sini
- Fokus: apakah 18,21% ini wajar, atau ada rujukan yang bisa dicegah?
- Poli Gigi & Mulut — rate 13,20%, dengan K04.0 (24,24%) dan K04.1 (16,67%) sebagai penyumbang utama



dr. Hesti Herlinawati



Faktor 1 — Case mix berbeda:
- Dokter dengan pasien kronis lebih banyak → rate lebih tinggi
- Dokter gigi → rate di kisaran 6,00–17,59%, sesuai case mix-nya
- Bidan → 0% karena populasi KIA di KMSC tidak dirujuk

Faktor 2 — Threshold klinis:
- Dokter A mungkin lebih konservatif (coba terapi dulu, rujuk kalau gagal)
- Dokter B mungkin lebih cepat merujuk (karena pertimbangan risiko, atau jam praktik terbatas)

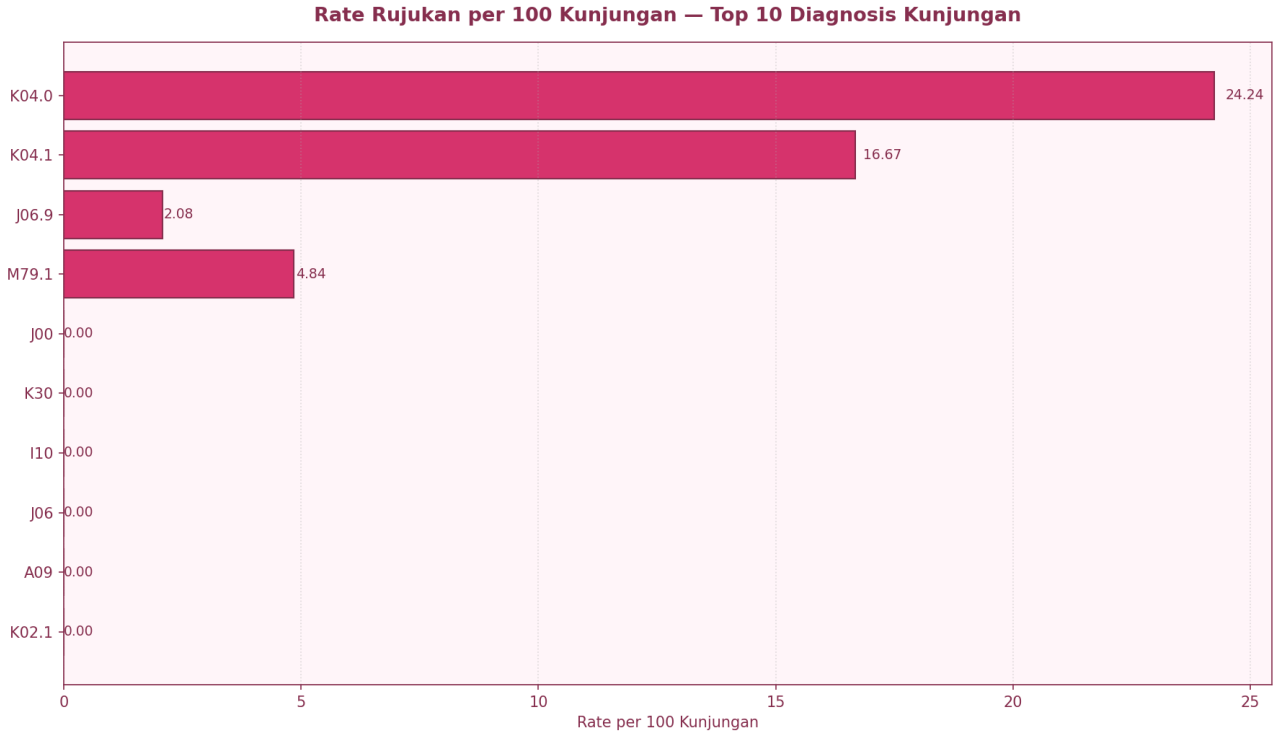
Faktor 3 — Volume & pengalaman:
- Dokter dengan volume tinggi (Eliyana, 1.178 kunjungan) punya sampel besar — rate bisa stabil
- Dokter dengan volume rendah (Shafira, 200 kunjungan) — rate bisa fluktuatif

Analisis spesifik:
- dr. Eliyana (18,34%) dan dr. Sylvia (17,84%) — dua rate tertinggi di dokter umum. Perlu di-review: apakah keduanya menangani lebih banyak kasus kompleks, atau lebih cepat merujuk?
- dr. Hesti (17,24%) — rate terendah di dokter umum, tetapi % berulang tertinggi (63,44%)
- drg. Shafira (6,00%) — paling rendah di seluruh dokter, mungkin lebih banyak kasus karies
- drg. Sri Tiana (17,59%) dan drg. Lety (16,57%) — setara dengan dokter umum, karena menangani kasus gigi kompleks

Implikasi Audit:
- Standardisasi kriteria rujukan — perlu pedoman klinis yang jelas agar tidak ada perbedaan tak terjelaskan
- Peer review — dokter dengan rate ekstrem (±2 SD dari rata-rata) perlu di-review kasus per kasus
- Kalibrasi — pertemuan rutin untuk membahas kasus borderline



dr. Hesti Herlinawati



Ini adalah rate rujukan dilihat dari diagnosis kunjungan. Menjawab: "Kalau pasien datang dengan diagnosis X, seberapa besar kemungkinan dirujuk?"

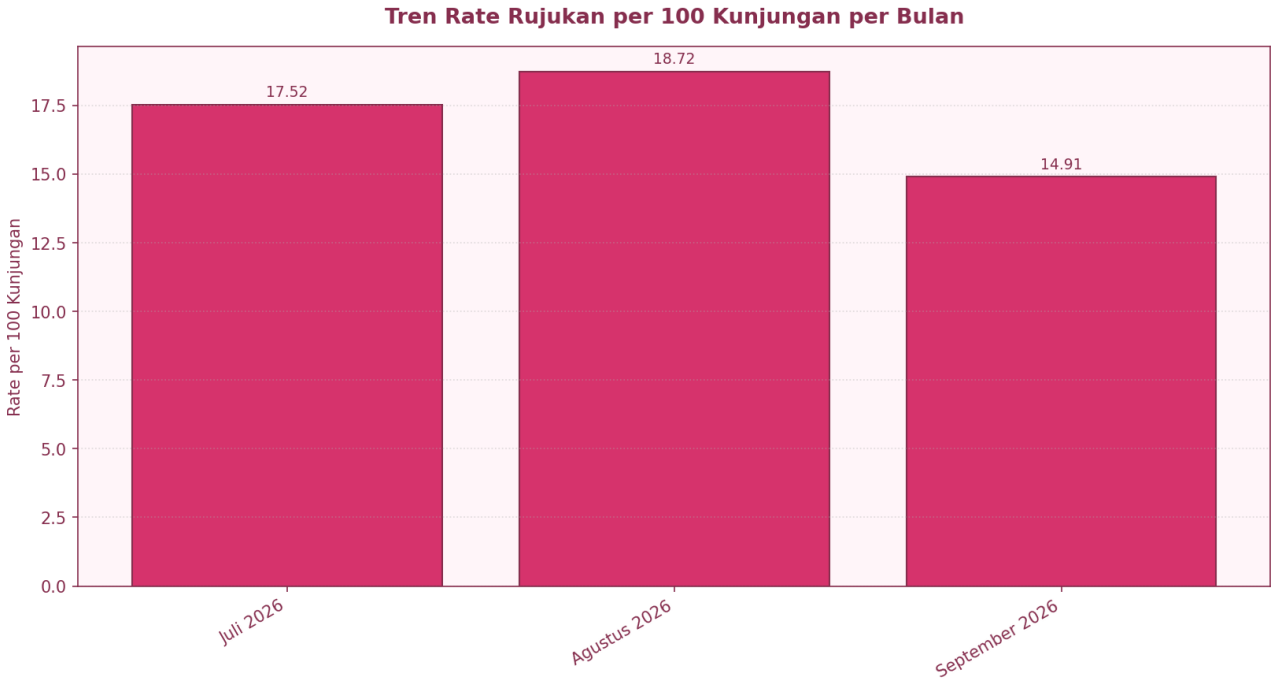
Pola ekstrem:
- 4 diagnosis dengan rate >0%: K04.0 (24,24%), K04.1 (16,67%), M79.1 (4,84%), J06.9 (2,08%)
- 6 diagnosis dengan rate 0%: J00, K30, I10, J06, A09, K02.1 — semua penyakit akut/infeksi ringan & hipertensi esensial

Implikasi:
- K04.0 (pulpitis) — rate 24,24%, tertinggi. Wajar: pulpitis lanjut butuh perawatan saluran akar (PSA) yang tidak selalu tersedia di FKTP → dirujuk ke Gigi Endodonsi
- K04.1 (nekrosis pulpa) — rate 16,67%. Nekrosis pulpa butuh PSA → dirujuk
- K02.1 (karies dentin) — rate 0%. Karies bisa ditambal di FKTP → tidak pernah dirujuk
- Semua diagnosis non-gigi rate 0% — menandakan FKTP sangat mampu menangani: ISPA (J06, J06.9, J00) → 969 kunjungan, 0 rujukan; diare (A09) → 96 kunjungan, 0 rujukan; dispepsia (K30) → 232 kunjungan, 0 rujukan; hipertensi esensial (I10) → 112 kunjungan, 0 rujukan

Temuan penting:
- Hipertensi esensial (I10) → 0 rujukan dari 112 kunjungan. Artinya: FKTP sudah mengelola hipertensi tanpa komplikasi dengan sangat baik. Yang dirujuk adalah I11 (hipertensi dengan komplikasi) — masuk top 2 diagnosis rujukan (31 kasus).
- ISPA → 0 rujukan dari 969 kunjungan. Kekuatan FKTP yang harus dipertahankan.



dr. Hesti Herlinawati



Temuan kunci: Di September, kunjungan naik 21% tapi rujukan justru turun tipis. Inilah yang membuat rate turun drastis.

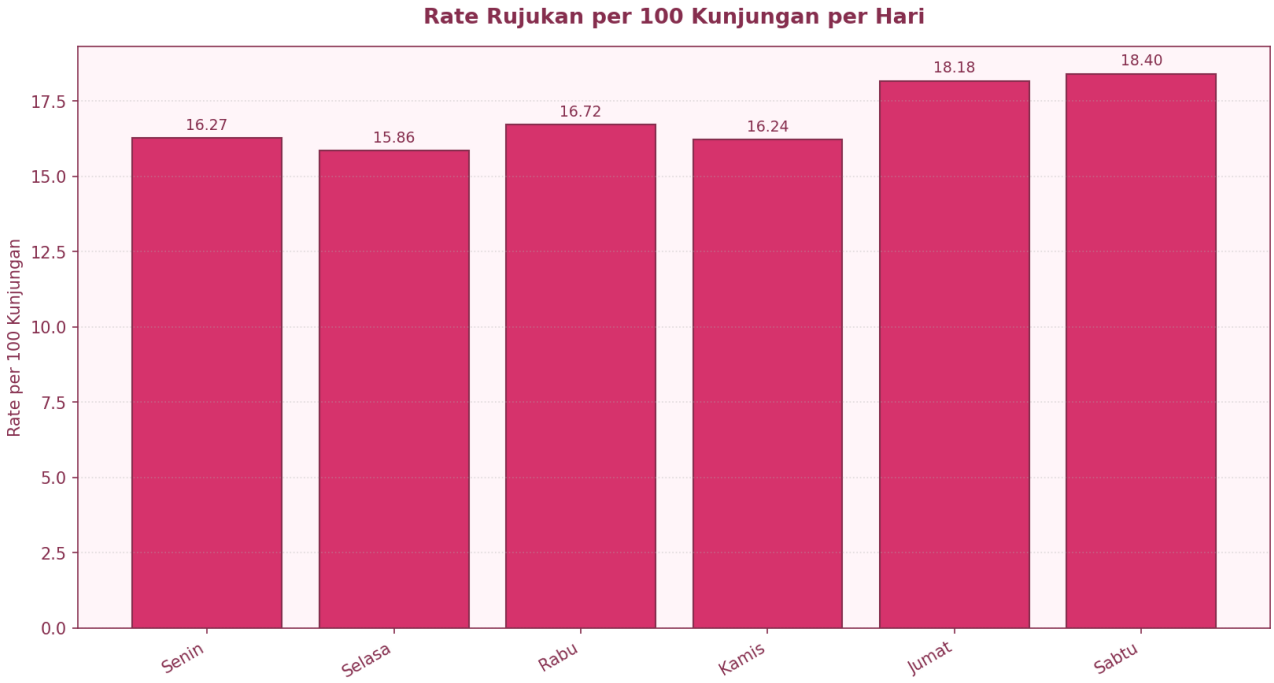
Penjelasan: Kenaikan kunjungan September sepenuhnya didorong oleh lonjakan ISPA (J06.9, J06, J00). Karena ISPA hampir tidak pernah dirujuk (rate 2,08% untuk J06.9; 0% untuk J06 dan J00), ini secara otomatis menurunkan rate rujukan agregat — meski kualitas rujukan tidak berubah.

Kesimpulan penting:
- Penurunan rate bukan (sepenuhnya) karena kualitas membaik — sebagian besar artifisial
- Kalau ingin mengukur kualitas rujukan yang sesungguhnya, perlu analisis case-mix adjusted atau fokus ke diagnosis kronis saja
- Yang tetap valid: jumlah rujukan absolut relatif stabil (213 → 222 → 214)

Implikasi Audit:
- Jangan cepat puas dengan "rate turun" — perlu verifikasi apakah ini perbaikan nyata atau efek komposisi
- Lihat tren rujukan absolut lebih informatif daripada rate saja
- Fokus: apakah rujukan kronis (I11, E11, I25) juga turun?



dr. Hesti Herlinawati



Sabtu — rate tertinggi (18,40%)
- dr. Hesti praktik Sabtu, dengan % berulang tertinggi (63,44%)
- Pasien yang datang Sabtu mungkin kasus yang sudah tertunda dari hari kerja

Jumat — rate kedua tertinggi (18,18%)
- dr. Sylvia praktik Jumat
- Menjelang akhir pekan, dokter mungkin lebih cepat merujuk agar pasien mendapat penanganan sebelum Sabtu/Minggu

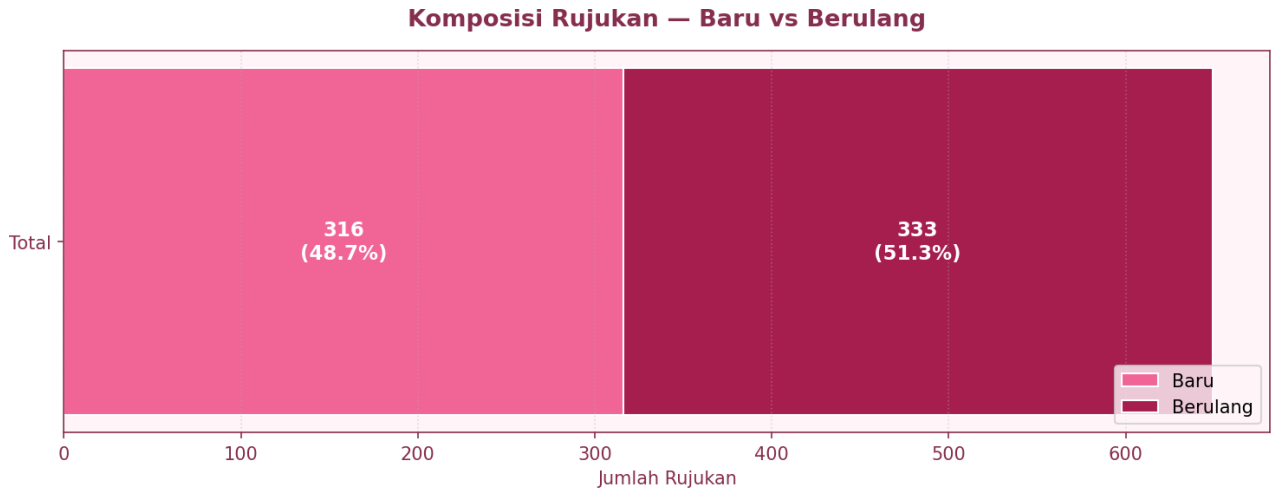
Selasa — rate terendah (15,86%)
- dr. Sylvia juga praktik Selasa
- Tidak ada korelasi langsung antara jadwal dokter dan rate hari

Pola harian ini punya implikasi operasional:
- Beban rujukan tidak merata — Sabtu dan Jumat paling tinggi
- Perlu diselidiki: apakah ini karena case mix (pasien Sabtu lebih kompleks) atau jadwal sistem (RS tujuan)?
- Peluang optimasi: kalau penyebabnya jadwal, bisa diatur redistribusi

Implikasi Audit:
- Audit internal perlu mempertimbangkan hari — dokter yang praktik Sabtu/Jumat mungkin punya rate lebih tinggi bukan karena perilaku, tapi karena jadwal
- Kemitraan RS — koordinasi jadwal spesialis dengan FKTP bisa meratakan beban rujukan
- Analisis heatmap (grafik 41 dan 42) akan mengungkap pola poli × hari dan spesialis × hari



dr. Hesti Herlinawati



Ini adalah rate rujukan dilihat dari jenis rujukan (baru vs berulang). Kedua baris memakai denominator yang sama (total kunjungan 3.837) supaya bisa dibandingkan.

Perbandingan:
- Baru: 316/3.837 = 8,24%
- Berulang: 333/3.837 = 8,68%
- Total: 649/3.837 = 16,91%

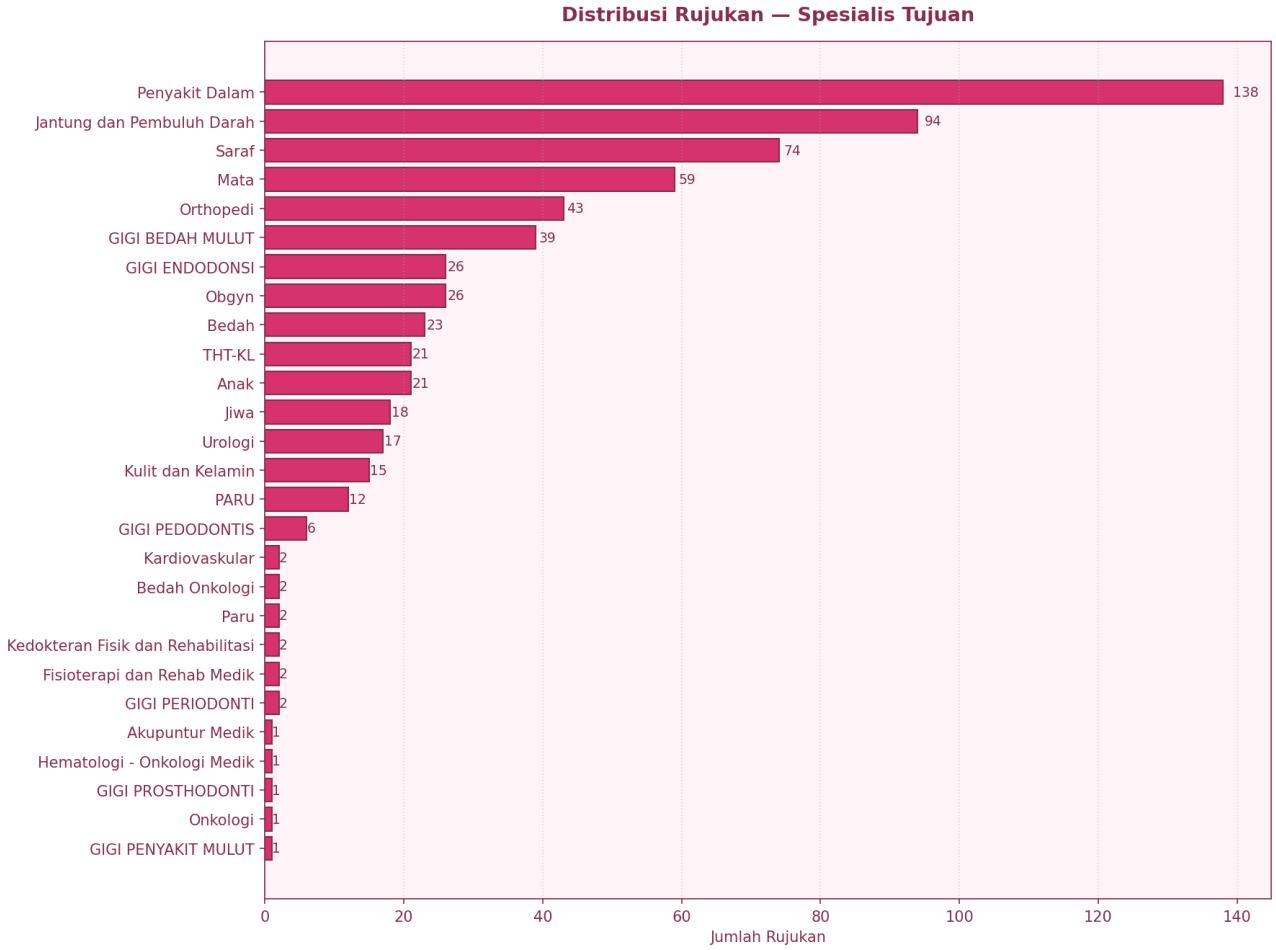
Artinya: Dari setiap 100 kunjungan, 8,24 menghasilkan rujukan baru dan 8,68 menghasilkan rujukan berulang. Hampir seimbang, dengan rujukan berulang sedikit lebih dominan (48,7% : 51,3%).

Implikasi:
- Rujukan berulang 8,68% dari seluruh kunjungan — lebih dari setengah beban rujukan
- Kalau berhasil turunkan rate rujukan berulang dari 8,68% → 6%, akan hemat ~103 rujukan per periode (333 − 6% × 3.837 = 333 − 230 = 103)
- Fokus optimasi: pasien kronis yang rutin dirujuk



dr. Hesti Herlinawati

E.3. Distribusi Rujukan



Penyakit Dalam (138, 21,26%)
Menangani semua penyakit kronis dewasa: DM, hipertensi, jantung, ginjal, hati
72,46% berulang — mayoritas pasien kontrol rutin
Diagnosis terkait: I11, E11.6, E11.4, I25.9, I11.9

Jantung dan Pembuluh Darah (94, 14,48%)
Spesialis kedua terbanyak, dengan 87,23% berulang
Penyumbang utama rujukan berulang
Diagnosis terkait: I25, I50, I11, I15

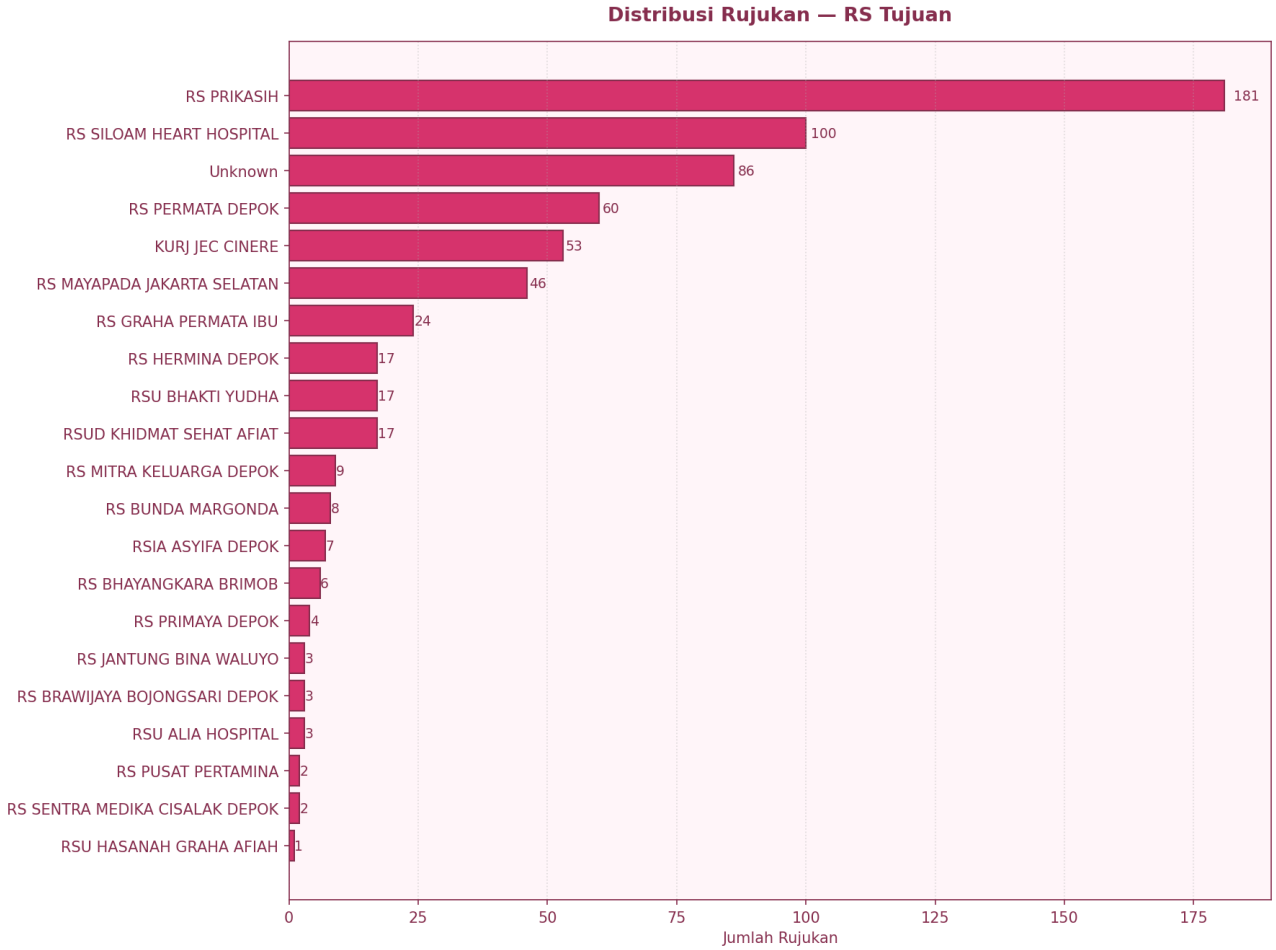
Saraf (74, 11,40%)
Stroke, neuropati DM, epilepsi, nyeri kronis, vertigo
47,30% berulang

Mata (59, 9,09%)
Didorong H54.2 (low vision) — diagnosis rujukan #1
22,03% berulang — mayoritas kasus baru (katarak, refraksi, low vision baru)

Implikasi Audit:
- Fokus optimasi di Penyakit Dalam, Jantung, Paru
- Mata & THT — tidak perlu dioptimasi, rujukannya kasus baru yang butuh tindakan spesifik



dr. Hesti Herlinawati



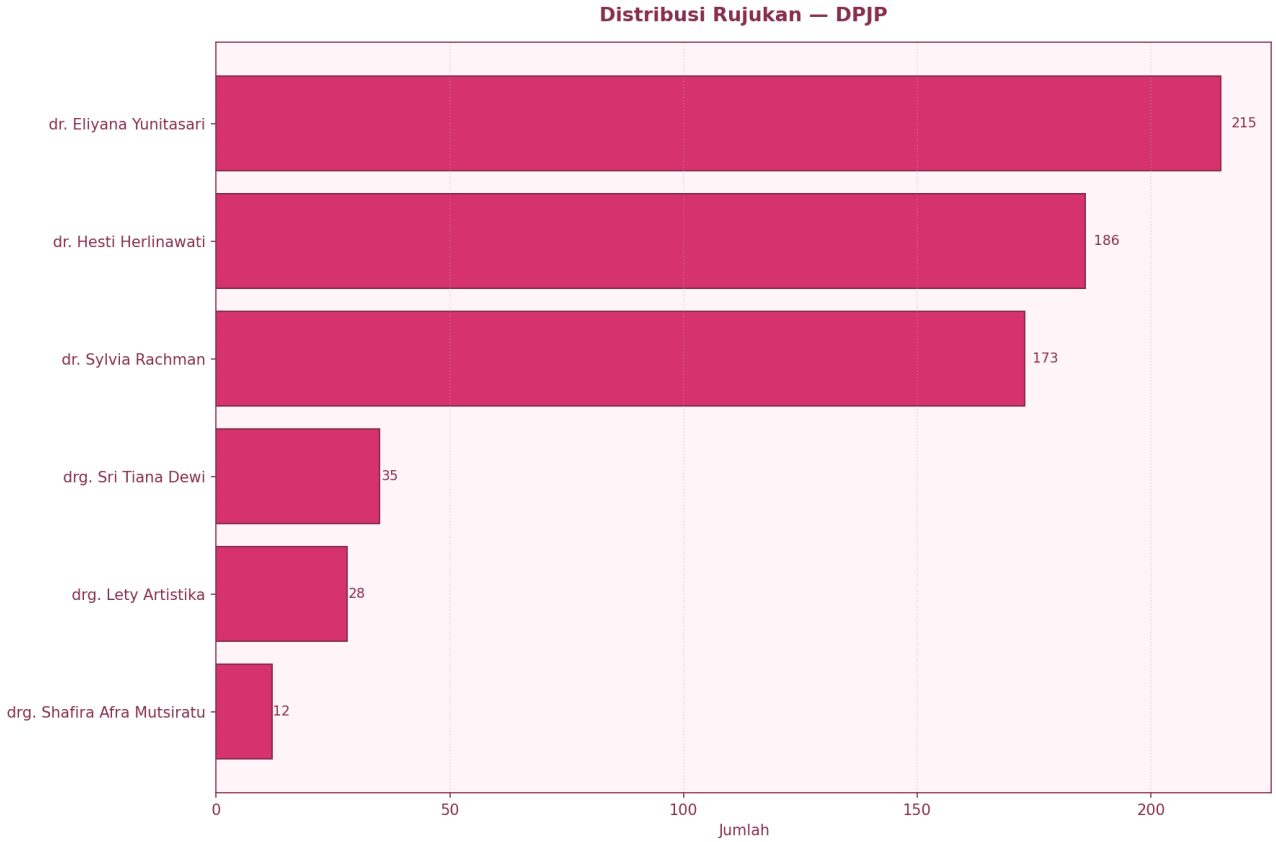
Konsentrasi tinggi: 3 RS teratas menampung 52,54% rujukan (367 dari 649).

Analisis 3 RS utama:
- RS Prikasih (181, 27,89%)
- RS Siloam Heart Hospital (100, 15,41%)
- Unknown (86, 13,25%)

Implikasi Audit:
- Kemitraan strategis dengan 2 RS utama (Prikasih, Siloam Heart) — jalur cepat, feedback rujukan
- Unknown (86; 13,25%) — perlu perbaikan data input rujukan
- RS Siloam Heart Hospital (73% berulang) — RS tujuan khusus kronis. Bisa diatur sistem rujukan kolektif/jadwal bersama



dr. Hesti Herlinawati



Konsentrasi sangat tinggi: 3 dokter teratas menyumbang 88,45% rujukan (574 dari 649).

Kaitan volume kunjungan vs kontribusi rujukan:

Dokter	Kunjungan	Rujukan	Selisih
Eliyana	30,70	33,13	+2,43
Hesti	28,12	28,66	+0,54
Sylvia	25,28	26,66	-1,38

Temuan:
- dr. Eliyana — over-represented (+2,43), merujuk lebih sering per kunjungan
- dr. Hesti — hampir seimbang (+0,54)
- dr. Sylvia — under-represented, lebih sedikit merujuk per kunjungan

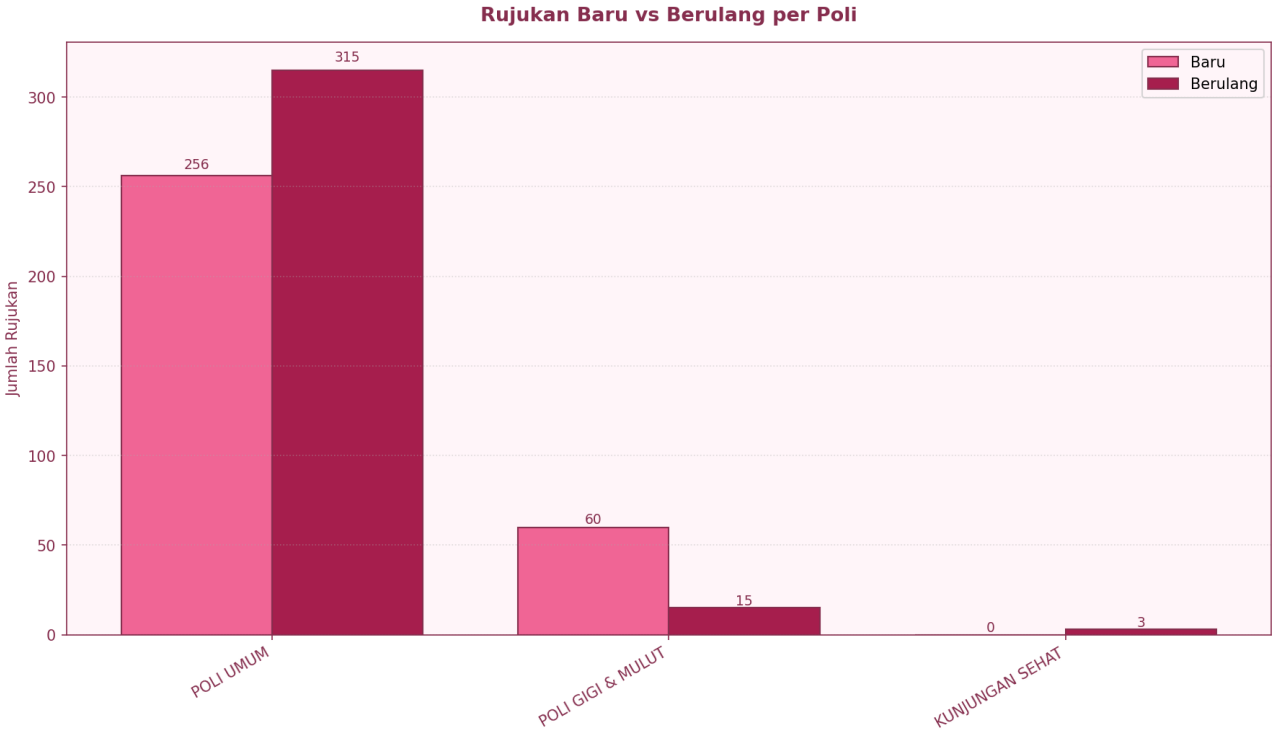
Dokter gigi & bidan:
- Total 6 dokter (gigi+bidan) = 75 rujukan (11,55%)
- Sesuai karakter layanan yang jarang merujuk

Implikasi Audit:
- Konsentrasi rujukan pada 3 dokter — bisa efisien atau berisiko
- dr. Eliyana dan dr. Hesti — perlu peer review
- Perbedaan % kunjungan vs % rujukan — indikator dokter "over-rujuk" atau "under-rujuk"



dr. Hesti Herlinawati

E.4. Rujukan Baru dan Berulang



Poli Umum — Seimbang (55,17%)
- 256 baru, 315 berulang
- Mencerminkan dualitas Poli Umum:
  - separuh rujukan = kasus baru (penyakit akut, diagnosis pertama),
  - separuh lebih = pasien kronis yang kontrol rutin ke spesialis
- Ini area audit utama — 571 rujukan berasal dari Poli Umum

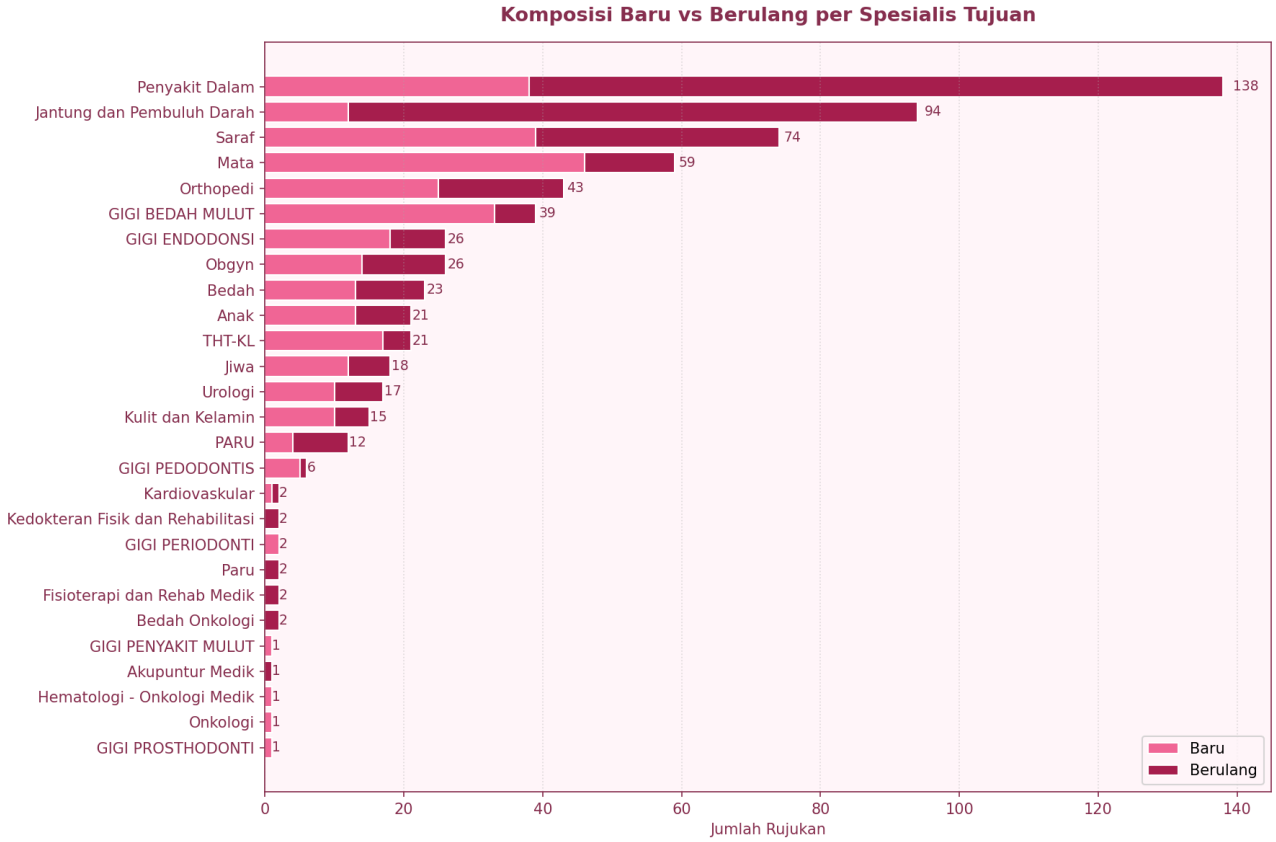
Poli Gigi & Mulut — Rendah (20,00%)
- 60 baru, 15 berulang
- 80% rujukan gigi adalah kasus baru
- Karakter tindakan gigi: sekali tindakan selesai (ekstraksi, penambalan, PSA)
- Wajar — tidak perlu dioptimasi

Kunjungan Sehat — 100% berulang
- 0 baru, 3 berulang
- Sampel terlalu kecil (3), tidak dapat diinterpretasi

Implikasi Audit:
- Poli Umum adalah tempat intervensi (571 dari 649 rujukan = 88,0%)
- Poli Gigi & Mulut — pola wajar, tidak perlu diubah
- Target: Turunkan % berulang Poli Umum dari 55,17% → 45% dalam 6 bulan



dr. Hesti Herlinawati



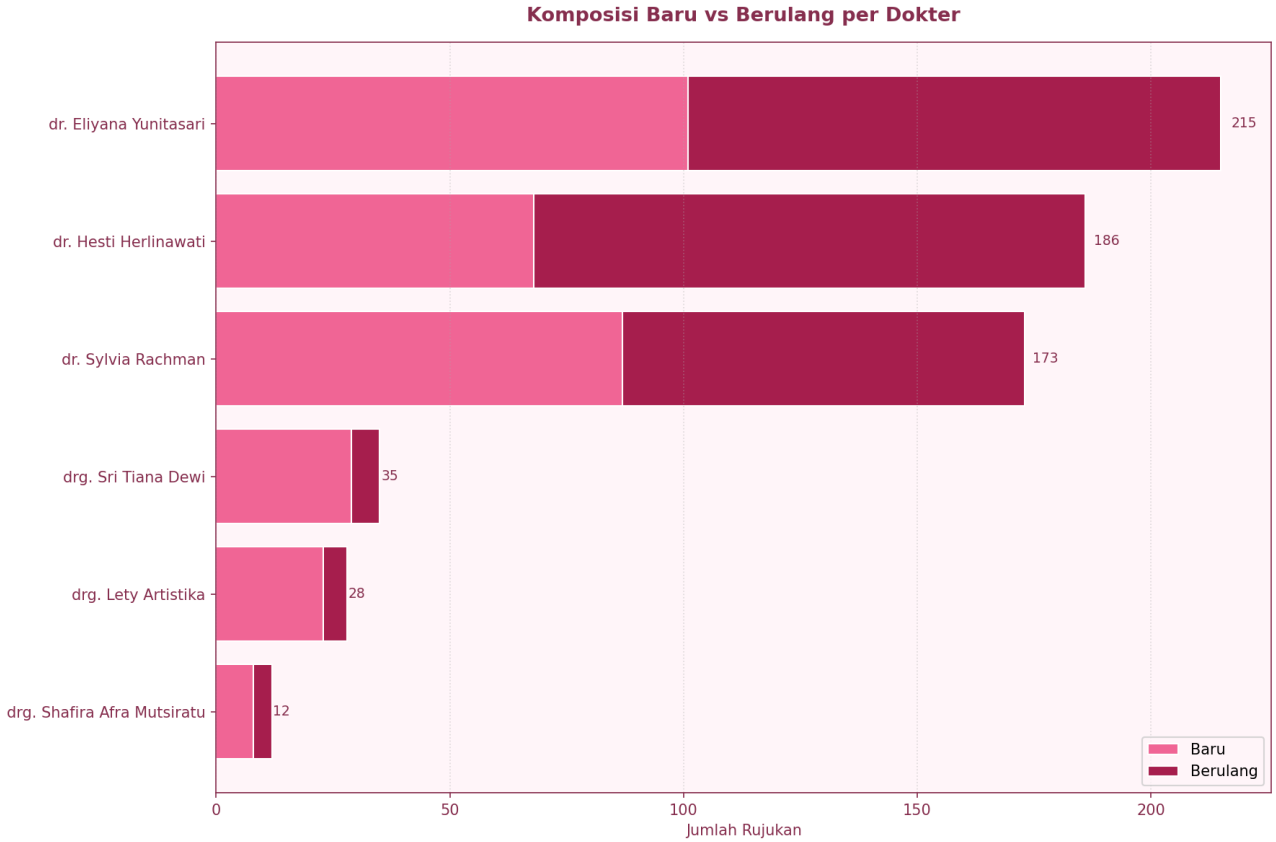
Keduanya volume besar: Jantung dan Pembuluh Darah (94) dan Penyakit Dalam (138), tapi % berulang sangat tinggi (87,23% dan 72,46%). Mengapa?
- Jantung: rujukan didominasi I25 (penyakit jantung iskemik kronik) dan I50 (gagal jantung) — kondisi kronis yang butuh kontrol rutin
- Penyakit Dalam: didominasi E11 (DM) dan I11 (hipertensi dengan komplikasi) — manajemen jangka panjang

Sebaliknya, Mata (22,03%) dan THT-KL (19,05%) memiliki % berulang sangat rendah meski volumenya cukup besar (59 dan 21). Mengapa?
- Mata: rujukan didominasi H54.2 (low vision) — mayoritas kasus baru yang baru terdeteksi. Juga katarak yang perlu operasi sekali.
- THT-KL: rujukan untuk gangguan pendengaran, vertigo, sinusitis kronis — umumnya sekali konsultasi + terapi, tidak perlu balik.
- Kesimpulan: Spesialis akut/tindakan tidak perlu dioptimasi — rujukannya memang esensial.

Implikasi Audit:
- Fokus pada 3 spesialis kronis (PD, Jantung, Saraf)
- Penyakit Dalam = prioritas #1 (138 rujukan, 72,46% berulang)
- Jantung = prioritas #2 (94 rujukan, 87,23% berulang)
- Total beban dari 2 spesialis ini = 232 rujukan (35,75% dari total), dengan 182 berulang
- Kalau bisa dipangkas 30% dari 182 = ~55 rujukan berulang per periode



dr. Hesti Herlinawati

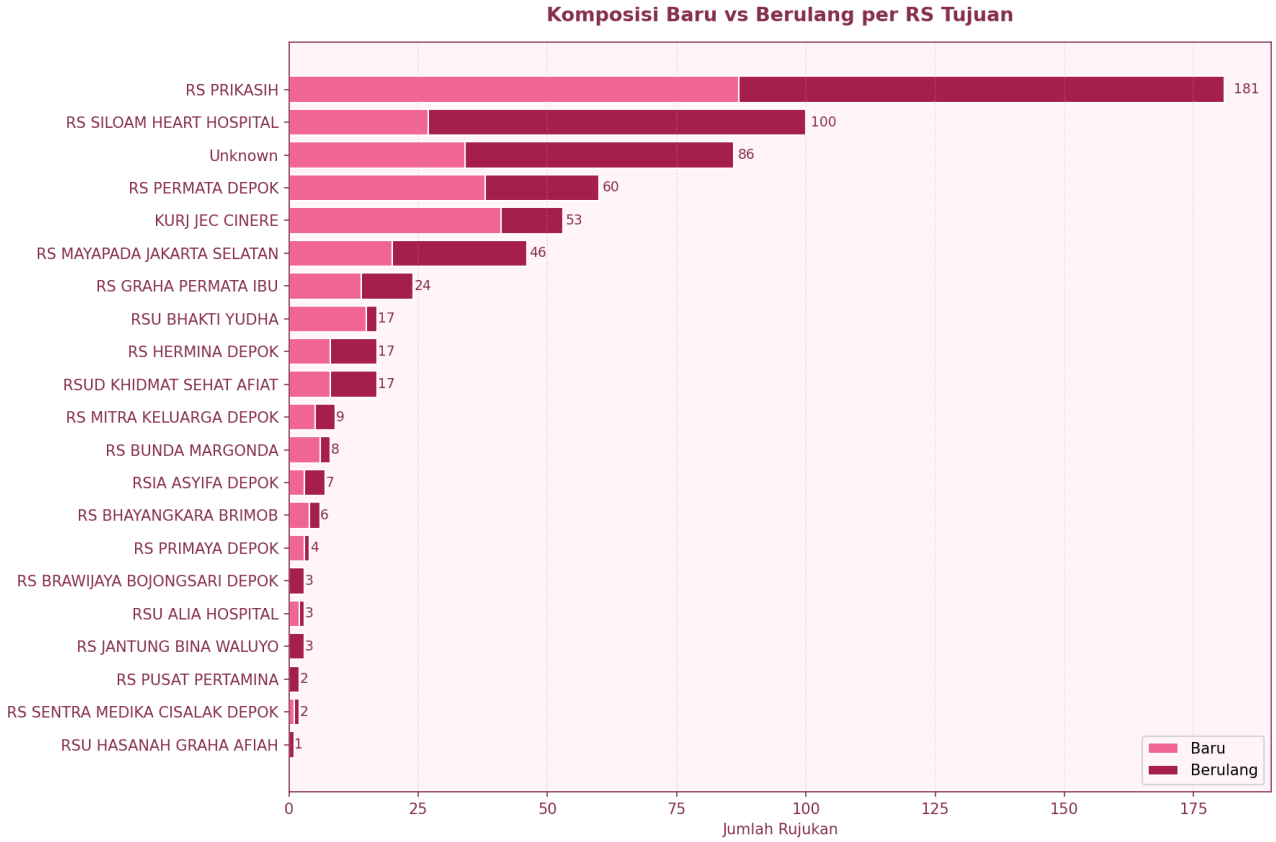


Interpretasi: Dokter dengan % berulang tinggi mungkin menangani lebih banyak pasien kronis — bukan berarti mereka "salah rujuk". Perlu analisis case mix per dokter untuk konfirmasi.
- dr. Hesti (63,44%) — tertinggi di dokter umum. Dari 186 rujukan, 118 berulang. Perlu di-review: apakah case mix beliau memang banyak kronis, atau threshold rujuk beliau lebih rendah?
- dr. Eliyana (53,02%) — paling banyak rujukan (215), tapi % berulang menengah. Artinya: hampir separuh rujukan beliau adalah kasus baru. Volume tinggi tapi tidak "over-rujuk kronis".
- dr. Sylvia (49,71%) — % berulang terendah di dokter umum, konsisten dengan rate yang juga terendah.
- Dokter gigi (17,14%–33,33%) — pola wajar, tindakan gigi sekali selesai.

Implikasi Audit:
- dr. Hesti — % berulang tinggi, perlu di-review kasus per kasus
- dr. Eliyana — volume besar tapi % berulang menengah, relatif seimbang
- Perlu case mix per dokter untuk interpretasi yang benar



dr. Hesti Herlinawati



RS Siloam Heart Hospital (73,00% berulang) — pola ekstrem. Kalau ini untuk pasien jantung kronis (I25, I50), maka:
- Rujukan ini esensial (pasien harus kontrol rutin ke kardiolog)
- Tidak bisa dioptimasi — pasien memang butuh RS
- Rekomendasi: buat sistem rujukan kolektif atau jadwal bersama untuk mengurangi beban administratif

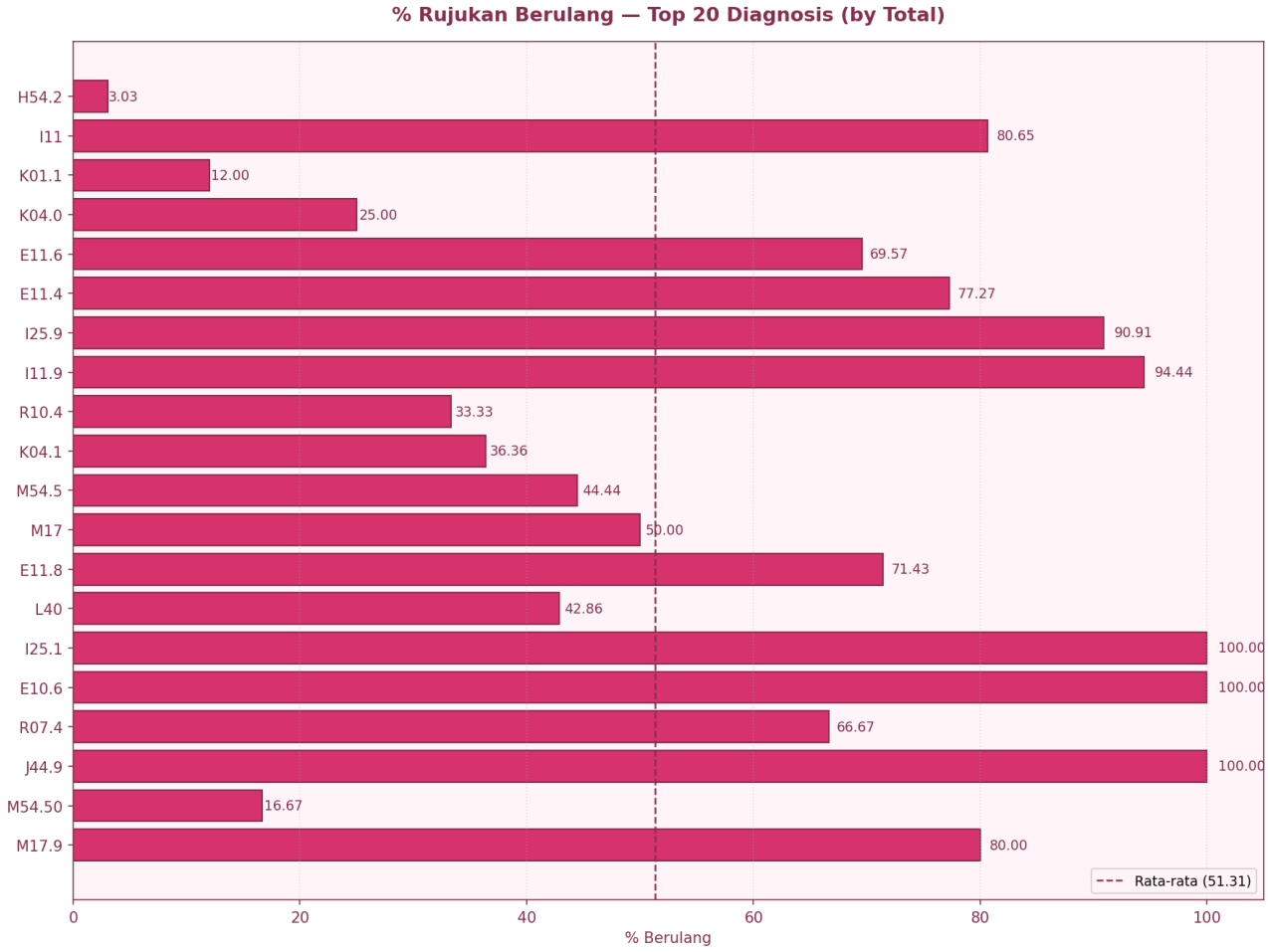
RS Prikasih (51,93% berulang) — seimbang, mencerminkan perannya sebagai RS serba bisa.

Unknown (60,47% berulang) — masalah kualitas data. 52 dari 86 rujukan berulang dengan tujuan RS tidak tercatat.

Implikasi Audit:
- Kemitraan dengan 2 RS utama (Prikasih, Siloam Heart) — fokus optimasi kronis
- RS Siloam Heart Hospital — RS rujukan kronis khusus. Perlu pendekatan berbeda (jadwal kolektif)
- Unknown — perbaikan SOP input rujukan



dr. Hesti Herlinawati



Semua diagnosis kronis dengan n≥5 memiliki % berulang ≥69%:
- I25.9 (90,91%), I25.1 (100%), I11.9 (94,44%), I11 (80,65%), E11.4 (77,27%), E11.6 (69,57%), E11.8 (71,43%), J44.9 (100%), E10.6 (100%) — semuanya jantung, DM, hipertensi, paru
- Artinya: begitu pasien didiagnosis kronis dan dirujuk, hampir pasti akan dirujuk lagi

Implikasi: Ini bukan "salah rujuk" — ini sifat alami penyakit kronis yang butuh kontrol rutin. Tapi:
- Pertanyaan audit: Apakah semua kontrol ini harus di spesialis? Atau bisa dibagi: kontrol rutin di FKTP, evaluasi berkala di spesialis?
- Model yang bisa dipertimbangkan: Shared care — pasien kontrol di FKTP 2×, di spesialis 1× per 3 bulan

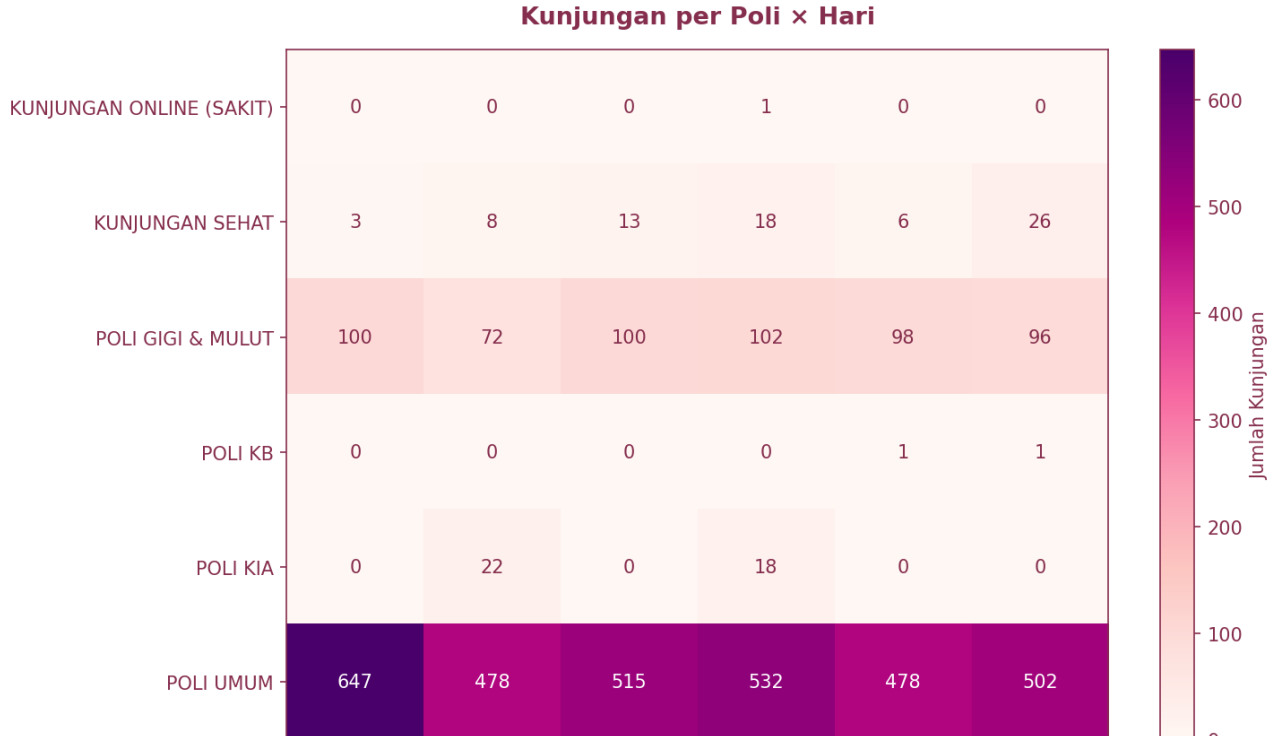
Diagnosis akut dengan n≥5 semua memiliki % berulang rendah:
- H54.2 (3,03%), K01.1 (12,00%), K04.0 (25,00%), K04.1 (36,36%), R10.4 (33,33%), M54.5 (44,44%) — nyeri, low vision, gangguan gigi
- Artinya: rujukan untuk diagnosis ini selalu kasus baru
-Wajar — setelah ditangani, pasien tidak perlu balik lagi

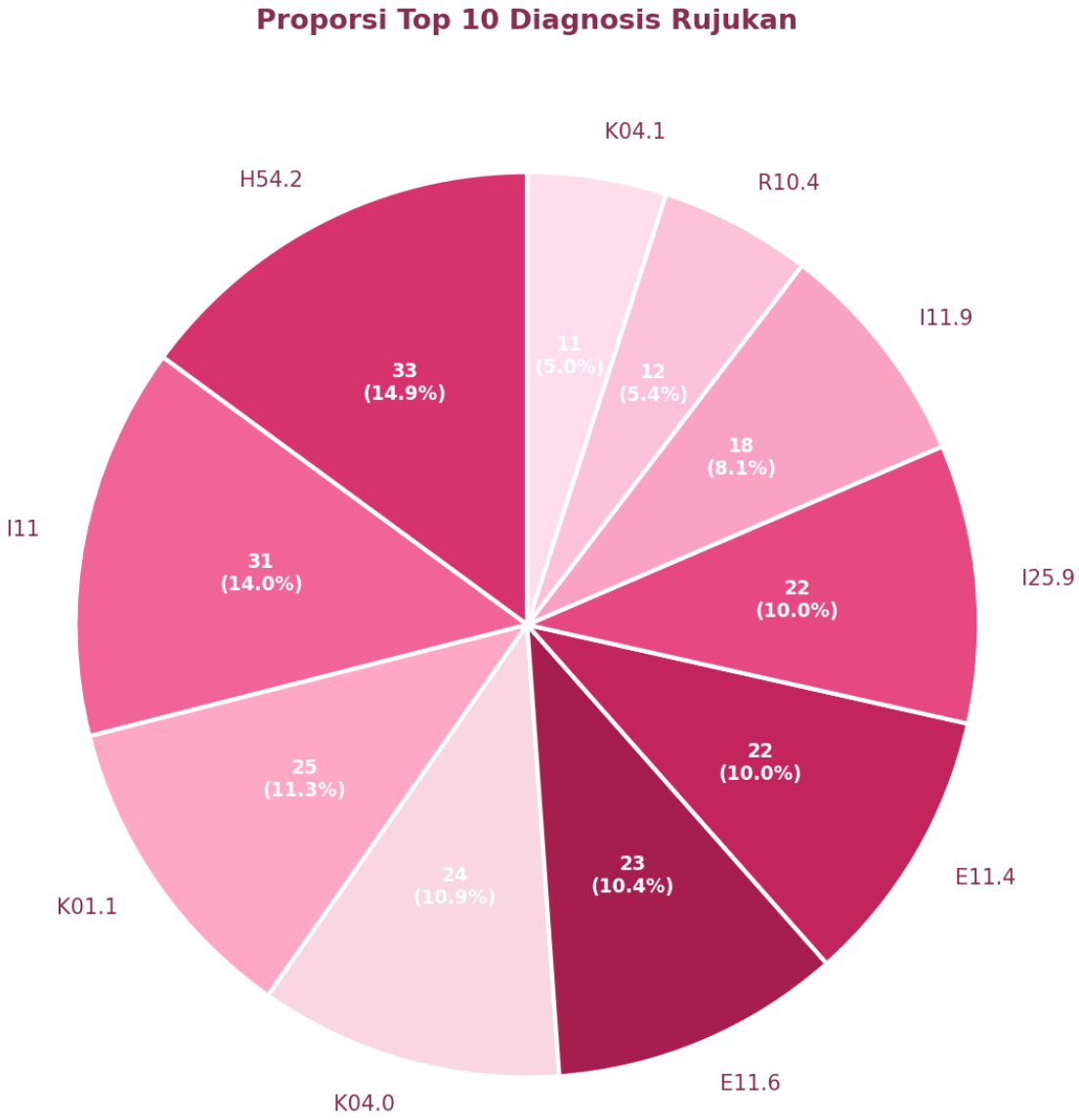
Implikasi Audit:
- Diagnosis kronis (I25, I11, E11, J44) = beban utama rujukan berulang
- Fokus pada 4 kelompok: jantung (I25, I25.9, I25.1), hipertensi (I11, I11.9), DM (E11.4, E11.6, E11.8), paru (J44.9)
- Diagnosis akut tidak perlu perhatian — pola wajar



dr. Hesti Herlinawati

E.5. Lain-lain







dr. Hesti Herlinawati

Kesimpulan Awal

Rate rujukan KMSC 16,91% tidak alarm, tapi tidak ideal. Masalah sebenarnya bukan angka rate itu sendiri, melainkan 51,31% rujukan berulang yang terkonsentrasi di Jantung dan Pembuluh Darah (87,23%) dan Penyakit Dalam (72,46%). Fokus audit ke depan bukan "turunkan rate", tapi "optimasi rujukan kronis" melalui shared care, Prolanis intensif, dan standardisasi kriteria rujukan. Kekuatan FKTP dalam menangani ISPA dan penyakit menular harus dipertahankan. Target realistis: turunkan rujukan berulang dari 51% → 45% dalam 6 bulan, dengan dampak ~40 rujukan dihemat per kuartal.



dr. Hesti Herlinawati

F. Perbandingan Rujukan BPJS: Klinik Cahaya Madani (CAMAD) vs Klinik Mutiara Sehat Cinere (KMSC)

Perbandingan disusun pada tiga dimensi: rate per 1.000 kapitasi, rate per 100 kunjungan, dan case mix. Seluruh angka pada F menggunakan segmen BPJS.

Ringkasan angka dasar (BPJS):

Klinik	Kunjungan	Rujukan	Rate per 100 Kunjungan	Kapitasi	Rate per 1.000 Kapitasi
CAMAD	5.770	1.086	18,82	10.000*	108,6*
KMSC	3.172	553	17,43	5.000*	110,6*

* Kapitasi CAMAD (10.000) dan KMSC (5.000) keduanya adalah asumsi, bukan data resmi. Rate per 1.000 kapitasi kedua klinik bersifat indikatif.

F.1. Perbandingan Rate per 1.000 Kapitasi

Klinik	Kunjungan	Rujukan	Kapitasi	Rate per 1.000 Kapitasi
CAMAD	5.770	1.086	10.000*	108,6*
KMSC	3.172	553	5.000*	110,6*

* Kapitasi CAMAD dan KMSC keduanya asumsi.

Karakteristik:
- CAMAD memiliki kapitasi dua kali lipat KMSC (10.000* vs 5.000*) dan kunjungan 1,82 kali lebih banyak (5.770 vs 3.172).
- Rujukan CAMAD 1,96 kali lebih banyak dari KMSC (1.086 vs 553).
- Hasilnya, rate per 1.000 kapitasi kedua klinik hampir setara: CAMAD 108,6* vs KMSC 110,6* — KMSC sedikit lebih tinggi 2,0 poin.

Analisis spesifik:
- Pada dimensi per kapitasi, CAMAD tidak lebih tinggi dari KMSC. KMSC justru sedikit lebih tinggi (110,6* vs 108,6*).
- Kedua angka rate sangat sensitif terhadap asumsi kapitasi. Untuk CAMAD: pada kapitasi 8.000 → 135,8; pada 12.000 → 90,5. Untuk KMSC: pada kapitasi 4.000 → 138,3; pada 6.000 → 92,2.
- Karena kedua kapitasi adalah asumsi, perbandingan ini paling lemah di antara tiga dimensi dan belum dapat dijadikan dasar kebijakan.

Implikasi Audit:
- Klaim "angka rujukan CAMAD jauh lebih tinggi dari KMSC" tidak terkonfirmasi pada dimensi per kapitasi; justru KMSC sedikit lebih tinggi.
- Prioritas: verifikasi kapitasi CAMAD dan KMSC yang sebenarnya, karena seluruh interpretasi per kapitasi bergantung pada kedua angka ini.



dr. Hesti Herlinawati

F.2. Perbandingan Rate per 100 Kunjungan

Klinik	Total Kunjungan	Rujukan	Rate per 100 Kunjungan
CAMAD	5.770	1.086	18,82
KMSC	3.172	553	17,43
Selisih			+1,39

Karakteristik:
- Rate CAMAD 18,82 vs KMSC 17,43 — selisih 1,39 poin (CAMAD 1,08× KMSC).
- Selisih ini jauh lebih kecil dari kesan "jauh lebih tinggi" pada klaim awal.

Analisis spesifik:
- Selisih 1,39 poin berarti sekitar 44 rujukan ekstra per 3.172 kunjungan bila CAMAD memiliki volume KMSC. Dalam skala CAMAD (5.770 kunjungan), selisih ini setara ~80 rujukan.
- Selisih ini perlu didekomposisi: berapa yang dijelaskan oleh perbedaan case mix (usia, status penyakit, sifat penyakit) dan berapa yang tersisa sebagai faktor klinisi/sistem.

Implikasi Audit:
- Perbandingan agregat (18,82 vs 17,43) tidak dapat diinterpretasi tanpa memperhitungkan case mix. Dekomposisi dilakukan di F.3 dan F.4.

Per Usia Kelompok Usia	CAMAD	KMSC	Selisih (CAMAD − KMSC)
Dewasa / Usia Produktif	20,07	17,79	+2,28
Lansia	33,14	30,41	+2,73
Anak-anak / Usia Sekolah	11,29	6,35	+4,94
Balita	12,67	7,69	+4,98

Karakteristik:
- CAMAD lebih tinggi dari KMSC pada seluruh kelompok usia.
- Selisih terbesar pada balita (+4,98) dan anak sekolah (+4,94); terkecil pada dewasa produktif (+2,28).
- Peringkat rate identik di kedua klinik: lansia > dewasa produktif > balita ≈ anak sekolah.

Analisis spesifik:
- Selisih pada balita dan anak sekolah (~+5 poin) mengindikasikan CAMAD merujuk anak-anak lebih sering dari KMSC. Perlu ditelusuri: case mix anak CAMAD lebih berat, atau perbedaan threshold klinisi.
- Selisih pada lansia (+2,73) dan dewasa produktif (+2,28) relatif kecil — pola penanganan dewasa/lansia di kedua klinik mirip.

Implikasi Audit:
- Fokus audit perbandingan usia ada pada balita dan anak sekolah, karena selisihnya paling besar.



dr. Hesti Herlinawati

Per Status Penyakit

Status	CAMAD	KMSC	Selisih (CAMAD − KMSC)
Kronik	32,72	18,37	+14,35
Akut	16,36	14,92	+1,44

Karakteristik:
- Selisih rate kronik sangat besar: CAMAD 32,72 vs KMSC 18,37 (+14,35 poin).
- Selisih rate akut kecil: CAMAD 16,36 vs KMSC 14,92 (+1,44 poin).
- Rasio kronik/akut: CAMAD 2,00; KMSC 1,23.

Analisis spesifik:
- Ini selisih terbesar di seluruh F.2. CAMAD merujuk hampir dua kali lebih sering pada kasus kronik dibanding KMSC.
- Rate akut kedua klinik relatif dekat — pola penanganan akut mirip.
- Namun perlu diperhatikan: proporsi kunjungan kronik CAMAD hanya 15,04% (868 dari 5.770), sedangkan KMSC 73,80% (2.341 dari 3.172). Kontribusi absolut kronik terhadap total rujukan: CAMAD 284 dari 1.086 (26,2%); KMSC 430 dari 553 (77,8%).
- Artinya: CAMAD merujuk kronik lebih sering per kunjungan kronik, tetapi KMSC merujuk kronik lebih banyak secara absolut karena volume kroniknya jauh lebih besar.

Implikasi Audit:
- Perbedaan rate kronik (+14,35) adalah temuan utama F.2. Perlu ditelusuri apakah CAMAD merujuk kasus kronik yang seharusnya bisa ditangani di FKTP, atau case mix kronik CAMAD lebih berat.
- KMSC dengan rate kronik 18,37% dapat dijadikan pembanding internal untuk mengevaluasi apakah rujukan kronik CAMAD dapat ditekan.

Per Sifat Penyakit

Sifat	CAMAD	KMSC	Selisih (CAMAD − KMSC)
Tidak Menular (PTM)	27,50	29,34	−1,84
Menular	1,01	6,60	−5,59

Karakteristik:
- Pada PTM, CAMAD 27,50 vs KMSC 29,34 — KMSC sedikit lebih tinggi (−1,84 dari sudut CAMAD).
- Pada penyakit menular, CAMAD 1,01 vs KMSC 6,60 — KMSC lebih tinggi (−5,59).
- Kontras PTM vs menular: CAMAD 27,2×; KMSC 4,4×.

Analisis spesifik:
- CAMAD hampir tidak pernah merujuk penyakit menular (1,01%), sementara KMSC merujuk 6,60%. Perlu ditelusuri apakah KMSC merujuk penyakit menular yang seharusnya bisa ditangani di klinik, atau case mix menular KMSC lebih berat.
- Pada PTM, kedua klinik relatif setara (27,50 vs 29,34), mengindikasikan beban rujukan PTM di kisaran sama.
- Kontribusi absolut PTM terhadap total rujukan: CAMAD 1.067 dari 1.086 (98,3%); KMSC 429 dari 553 (77,6%).



dr. Hesti Herlinawati

Implikasi Audit:
- Perbedaan pada penyakit menular (1,01 vs 6,60) perlu ditelusuri di KMSC.
- Pada PTM, kedua klinik setara; fokus audit PTM sebaiknya pada volume absolut dan rate kronik, bukan perbandingan rate PTM.

Per Poli

Poli	CAMAD	KMSC	Selisih (CAMAD − KMSC)
Poli Umum	20,75	18,75	+2,00
Poli Gigi	8,35	14,31	−5,96
Poli KIA	12,84	0,00	+12,84
Poli KB	8,33	0,00	+8,33
Kunjungan Sehat	—	1,61	—
Kunjungan Online	—	0,00	—

Karakteristik:
- Poli Umum: CAMAD 20,75 vs KMSC 18,75 (+2,00). Selisih kecil.
- Poli Gigi: CAMAD 8,35 vs KMSC 14,31 (−5,96). KMSC merujuk gigi lebih sering.
- Poli KIA: CAMAD 12,84 vs KMSC 0,00 (+12,84). CAMAD merujuk KIA, KMSC tidak.
- Poli KB: CAMAD 8,33 vs KMSC 0,00 (+8,33). CAMAD merujuk KB, KMSC tidak.
- Kategori Kunjungan Sehat dan Kunjungan Online hanya ada di KMSC.

Analisis spesifik:
- Selisih paling mencolok ada pada Poli KIA (+12,84) dan Poli KB (+8,33): CAMAD merujuk sebagian kunjungan KIA dan KB, KMSC tidak. Perlu ditelusuri apakah karena perbedaan ketersediaan layanan (USG, alat KB) atau kebijakan rujukan.
- Poli Gigi: KMSC merujuk lebih sering (−5,96). Kemungkinan karena case mix gigi KMSC lebih kompleks (K04.0, K04.1).
- Poli Umum: selisih kecil (+2,00), pola penanganan keluhan umum relatif mirip.

Implikasi Audit:
- Poli KIA dan KB: perbedaan kebijakan rujukan antara CAMAD dan KMSC perlu ditelusuri.
- Poli Gigi: perbedaan case mix atau threshold perlu ditelusuri.

Per Dokter: dr. Hesti Herlinawati sebagai Kontrol Internal

Klinik	Kunjungan	Rujukan	Rate per 100 Kunjungan
CAMAD	1.034	204	19,73
KMSC	879	150	17,06
Selisih			+2,67

Karakteristik:
- dr. Hesti memiliki rate 19,73 di CAMAD dan 17,06 di KMSC — selisih 2,67 poin.
- Selisih ini lebih besar dari selisih rate agregat BPJS (1,39 poin).



dr. Hesti Herlinawati

Analisis spesifik:
- Karena dokter sama, selisih 2,67 poin tidak dapat dijelaskan oleh faktor individu dokter. Faktor kontekstual klinik (case mix pasien, ketersediaan penunjang, kebijakan rujukan) berperan.
- Namun selisih ini juga bisa mencerminkan perbedaan case mix pasien dr. Hesti di kedua klinik. Perlu analisis case mix per dokter untuk konfirmasi.
- dr. Hesti dapat dijadikan "kontrol internal" untuk memisahkan faktor individu dari faktor klinik.

Implikasi Audit:
- Analisis case mix pasien dr. Hesti di kedua klinik diperlukan untuk memahami sumber selisih 2,67 poin.
- Bila case mix setara, selisih 2,67 poin mengindikasikan faktor klinik (ketersediaan penunjang, kebijakan) berperan.

F.3. Perbandingan Case Mix

Diagnosis Top 10

Kode	CAMAD Jumlah (%)	KMSC Jumlah (%)	Selisih (pp)
J00	299 (5,18%)	456 (14,38%)	−9,20
J06	435 (7,54%)	222 (7,00%)	+0,54
J06.9	658 (11,40%)	111 (3,50%)	+7,90
I10	291 (5,04%)	103 (3,25%)	+1,79
K30	199 (3,45%)	188 (5,93%)	−2,48
K04.0	171 (2,96%)	91 (2,87%)	+0,09
A09	152 (2,63%)	72 (2,27%)	+0,36
K02.1	142 (2,46%)	102 (3,22%)	−0,76
K04.1	135 (2,34%)	63 (1,99%)	+0,35
J02	116 (2,01%)	—	—
M79.1	—	52 (1,64%)	—

Karakteristik:
- Kedua klinik didominasi ISPA. Total proporsi ISPA (J00+J06+J06.9): CAMAD 24,12%; KMSC 24,88% — hampir setara.
- CAMAD proporsi J06.9 lebih tinggi (11,40% vs 3,50%); KMSC proporsi J00 lebih tinggi (14,38% vs 5,18%). Ini bisa mencerminkan perbedaan praktik pengkodean diagnosis, bukan perbedaan beban penyakit.
- Hipertensi esensial (I10) sedikit lebih tinggi di CAMAD (5,04% vs 3,25%).
- Dispepsia (K30) lebih tinggi di KMSC (5,93% vs 3,45%).
- Penyakit gigi (K04.0, K02.1, K04.1) relatif setara.

Analisis spesifik:
- Perbedaan pola pengkodean (J00 vs J06.9) perlu diperhatikan sebelum menyimpulkan perbedaan case mix. Keduanya ISPA, tetapi proporsinya berbeda jauh.
- Proporsi ISPA total hampir sama (24,12% vs 24,88%) — beban ISPA di kedua klinik setara.
- Perbedaan utama ada pada hipertensi esensial (+1,79 pp) dan dispepsia (−2,48 pp).



dr. Hesti Herlinawati

Implikasi Audit:
- Perlu standardisasi pengkodean diagnosis (J00 vs J06.9) agar perbandingan case mix antar klinik valid.
- Proporsi ISPA yang setara mengindikasikan beban penyakit menular akut di kedua klinik mirip.

Usia

Kelompok Usia	**CAMAD Jumlah (%)**	**KMSC Jumlah (%)**	**Selisih (pp)**
Dewasa / Usia Produktif	3.203 (55,51%)	1.939 (61,13%)	−5,62
Anak-anak / Usia Sekolah	1.452 (25,16%)	567 (17,88%)	+7,28
Lansia	673 (11,66%)	536 (16,90%)	−5,24
Balita	442 (7,66%)	130 (4,10%)	+3,56

Karakteristik:
- CAMAD proporsi anak (25,16%) dan balita (7,66%) lebih tinggi dari KMSC (17,88% dan 4,10%).
- KMSC proporsi lansia (16,90%) dan dewasa produktif (61,13%) lebih tinggi dari CAMAD (11,66% dan 55,51%).
- Selisih terbesar: anak sekolah (+7,28 pp) dan dewasa produktif (−5,62 pp).

Analisis spesifik:
- CAMAD beban pasien anak lebih besar (anak + balita = 32,82%) dibanding KMSC (21,98%). Ini menjelaskan mengapa selisih rate pada balita dan anak sekolah di F.2 lebih besar.
- KMSC beban lansia lebih besar (16,90% vs 11,66%) — konsisten dengan rate kronik KMSC.
- Perbedaan komposisi usia ini adalah faktor penting yang menjelaskan perbedaan rate agregat.

Implikasi Audit:
- Perbedaan rate agregat sebagian dijelaskan oleh perbedaan komposisi usia.
- Perlu age-adjusted rate untuk perbandingan yang adil.

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	CAMAD Jumlah (%)	KMSC Jumlah (%)	Selisih (pp)
Perempuan	3.220 (55,81%)	1.828 (57,63%)	−1,82
Laki-laki	2.550 (44,19%)	1.344 (42,37%)	+1,82

Karakteristik:
- Komposisi jenis kelamin hampir setara: perempuan dominan di keduanya, selisih 1,82 pp.
- Proporsi perempuan KMSC sedikit lebih tinggi.

Analisis spesifik:
- Karena komposisi hampir setara, perbedaan rate agregat tidak dapat dijelaskan oleh jenis kelamin.
- Rate perempuan: CAMAD 20,06 vs KMSC 17,78 (selisih 2,28). Rate laki-laki: CAMAD 17,25 vs KMSC 17,04 (selisih 0,21). Perbedaan rate agregat lebih banyak berasal dari rate perempuan.

Implikasi Audit:
- Selisih rate perempuan (2,28 poin) perlu ditelusuri.



dr. Hesti Herlinawati

Status Penyakit

Status	CAMAD Jumlah (%)	KMSC Jumlah (%)	Selisih (pp)
Akut	4.902 (84,96%)	831 (26,20%)	+58,76
Kronik	868 (15,04%)	2.341 (73,80%)	−58,76

Karakteristik:
- Perbedaan paling ekstrem di seluruh F.3: CAMAD didominasi akut (84,96%), KMSC didominasi kronik (73,80%).
- Selisih 58,76 pp pada kedua kategori.

Analisis spesifik:
- Perbedaan struktur kronik vs akut ini adalah faktor kunci. CAMAD dengan 84,96% akut memiliki rate agregat 18,82; KMSC dengan 73,80% kronik memiliki rate agregat 17,43.
- Meskipun rate agregat KMSC lebih rendah, rate kronik CAMAD (32,72) jauh lebih tinggi dari KMSC (18,37) — CAMAD merujuk kronik jauh lebih sering meski proporsi kroniknya kecil.
- Rate akut CAMAD (16,36) hanya sedikit lebih tinggi dari KMSC (14,92).

Implikasi Audit:
- Perbandingan rate agregat tidak dapat diinterpretasi tanpa memperhitungkan perbedaan struktur kronik vs akut (58,76 pp).
- Perlu case-mix adjusted rate: hitung rate seolah-olah kedua klinik memiliki proporsi kronik/akut yang sama.

Sifat Penyakit

Sifat	**CAMAD Jumlah (%)**	**KMSC Jumlah (%)**	**Selisih (pp)**
Tidak Menular (PTM)	3.880 (67,24%)	1.435 (45,24%)	+22,00
Menular	1.890 (32,76%)	1.737 (54,76%)	−22,00

Karakteristik:
- CAMAD didominasi PTM (67,24%), KMSC didominasi menular (54,76%). Selisih 22,00 pp.
- Ini perbedaan struktural kedua setelah status penyakit.

Analisis spesifik:
- Konsisten dengan perbedaan status penyakit: CAMAD lebih banyak akut dan PTM, KMSC lebih banyak kronik dan menular.
- Namun rate PTM kedua klinik relatif setara (27,50 vs 29,34), sehingga perbedaan sifat penyakit tidak otomatis menghasilkan perbedaan rate PTM.

Implikasi Audit:
- Perbedaan sifat penyakit perlu diperhitungkan dalam interpretasi rate agregat.



dr. Hesti Herlinawati

Poli Poli	CAMAD Jumlah (%)	KMSC Jumlah (%)	Selisih (pp)
Poli Umum	4.820 (83,54%)	2.565 (80,86%)	+2,68
Poli Gigi	790 (13,69%)	503 (15,86%)	−2,17
Poli KIA	148 (2,56%)	39 (1,23%)	+1,33
Poli KB	12 (0,21%)	2 (0,06%)	+0,15
Kunjungan Sehat	—	62 (1,95%)	—
Kunjungan Online	—	1 (0,03%)	—

Karakteristik:
- Poli Umum dominan di kedua klinik (CAMAD 83,54%; KMSC 80,86%), selisih 2,68 pp.
- Poli Gigi: KMSC sedikit lebih tinggi (15,86% vs 13,69%).
- Poli KIA: CAMAD lebih tinggi (2,56% vs 1,23%).
- Kunjungan Sehat dan Kunjungan Online hanya ada di KMSC.

Analisis spesifik:
- Komposisi poli kedua klinik relatif mirip, kecuali Poli KIA yang lebih tinggi di CAMAD dan adanya Kunjungan Sehat di KMSC.
- Perbedaan Poli KIA (2,56% vs 1,23%) konsisten dengan perbedaan rate Poli KIA di F.2 (CAMAD 12,84 vs KMSC 0,00).

Implikasi Audit:
- Perbedaan Poli KIA perlu ditelusuri: apakah karena volume pasien KIA yang berbeda atau kebijakan rujukan yang berbeda.



dr. Hesti Herlinawati

G. Apakah rujukan "CAMAD > KMSC" Terbukti?

Dimensi 1: Rate per 1.000 Kapitasi
Tidak terbukti. CAMAD 108,6* vs KMSC 110,6* — KMSC justru sedikit lebih tinggi. Namun kedua angka bertumpu pada asumsi kapitasi (CAMAD 10.000; KMSC 5.000), sehingga perbandingan ini paling lemah di antara tiga dimensi dan belum definitif. Sensitivitas kedua angka tinggi: perubahan asumsi kapitasi menggeser rate secara proporsional.

Dimensi 2: Rate per 100 Kunjungan
Terbukti, tetapi selisihnya kecil. CAMAD 18,82 vs KMSC 17,43 — selisih 1,39 poin (CAMAD 1,08× KMSC). Ini jauh dari kesan "jauh lebih tinggi".

Dimensi 3: Case Mix
Perbedaan case mix sangat besar dan menjelaskan sebagian besar selisih rate.
- Status penyakit: CAMAD 84,96% akut vs KMSC 73,80% kronik (selisih 58,76 pp).
- Usia: CAMAD lebih banyak anak (32,82% vs 21,98%); KMSC lebih banyak lansia (16,90% vs 11,66%).
- Sifat penyakit: CAMAD 67,24% PTM vs KMSC 54,76% menular (selisih 22,00 pp).
- Poli KIA: CAMAD 2,56% vs KMSC 1,23%.

Dekomposisi Selisih Rate Agregat
Selisih rate agregat BPJS: CAMAD 18,82 − KMSC 17,43 = 1,39 poin.
Perkiraan kontribusi faktor:
- Faktor case mix (usia + status + sifat): sebagian besar selisih dapat dijelaskan oleh perbedaan struktur kronik/akut dan usia. CAMAD dengan 84,96% akut seharusnya memiliki rate lebih rendah dari KMSC yang 73,80% kronik; namun CAMAD justru lebih tinggi 1,39 poin. Ini berarti faktor selain case mix berperan lebih besar dalam menaikkan rate CAMAD.
- Faktor klinisi: dr. Hesti sebagai kontrol internal menunjukkan rate 19,73 di CAMAD vs 17,06 di KMSC (selisih 2,67 poin). Selisih ini lebih besar dari selisih agregat, mengindikasikan faktor klinik (ketersediaan penunjang, kebijakan) berperan.
- Faktor sistem/data: perbedaan pola pengkodean (J00 vs J06.9) dan adanya kategori Kunjungan Sehat di KMSC memengaruhi denominator dan komparabilitas.

Interpretasi: Klaim "angka rujukan CAMAD jauh lebih tinggi dari KMSC" tidak sepenuhnya terbukti. Pada dimensi per kapitasi, KMSC justru lebih tinggi (meski keduanya asumsi). Pada dimensi per 100 kunjungan, CAMAD lebih tinggi tetapi hanya 1,39 poin. Selisih yang lebih menonjol ada pada rate kronik (CAMAD 32,72 vs KMSC 18,37; +14,35 poin) — ini adalah temuan utama yang perlu diaudit.



dr. Hesti Herlinawati

Kesimpulan Perbandingan

- Rate per 1.000 kapitasi: CAMAD 108,6* vs KMSC 110,6* — KMSC sedikit lebih tinggi. Klaim "CAMAD jauh lebih tinggi" tidak terkonfirmasi pada dimensi ini. Kedua angka bertumpu pada asumsi kapitasi (CAMAD 10.000; KMSC 5.000), sehingga perbandingan ini paling lemah di antara tiga dimensi.

- Rate per 100 kunjungan: CAMAD 18,82 vs KMSC 17,43 — CAMAD lebih tinggi 1,39 poin. Selisih ini kecil dan sebagian besar dapat dijelaskan oleh perbedaan case mix.

- Rate kronik: CAMAD 32,72 vs KMSC 18,37 — CAMAD lebih tinggi 14,35 poin. Ini adalah selisih terbesar dan menjadi fokus utama audit. CAMAD merujuk kasus kronik hampir dua kali lebih sering per kunjungan kronik dibanding KMSC.

- Case mix: Perbedaan struktural paling besar ada pada status penyakit (CAMAD 84,96% akut vs KMSC 73,80% kronik; selisih 58,76 pp), usia (CAMAD lebih banyak anak; KMSC lebih banyak lansia), dan sifat penyakit (CAMAD 67,24% PTM vs KMSC 54,76% menular; selisih 22,00 pp).

- Kontrol internal dr. Hesti: Rate 19,73 di CAMAD vs 17,06 di KMSC (selisih 2,67 poin). Karena dokter sama, selisih ini mengindikasikan faktor klinik berperan, bukan hanya faktor individu.

- Perbedaan kebijakan rujukan Poli KIA/KB: CAMAD merujuk KIA (12,84%) dan KB (8,33%), KMSC tidak merujuk keduanya (0%). Perlu ditelusuri apakah karena perbedaan kapasitas layanan atau kebijakan.

- Implikasi audit: Fokus audit CAMAD sebaiknya pada rujukan kronik (rate 32,72 vs KMSC 18,37) dan pada Poli KIA/KB (rate CAMAD 12,84/8,33 vs KMSC 0/0). Pada dimensi per kapitasi dan per 100 kunjungan agregat, selisih CAMAD–KMSC lebih kecil dari yang diklaim. Verifikasi kapitasi CAMAD dan KMSC yang sebenarnya menjadi prasyarat untuk interpretasi per kapitasi yang valid.